



**Уральский
федеральный
университет**

имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина

**Уральский гуманитарный
институт**

Р. Р. МУСЛУМОВ

КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Учебно-методическое пособие

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА

Р. Р. Муслумов

КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Учебно-методическое пособие

Рекомендовано методическим советом
Уральского федерального университета
для студентов вуза, обучающихся по специальности
37.05.01 «Клиническая психология»

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2025

УДК 615.851(07)
ББК Ю948.1я7
М96

П о д о б щ е й р е д а к ц и е й
А. А. Печёркиной

Р е ц е н з е н т ы:

кафедра юридической психологии Санкт-Петербургского университета
Министерства внутренних дел Российской Федерации
(врио начальника кафедры полковник полиции *И. Ю. Кобозев*);

М. А. Воробьёва, кандидат психологических наук, доцент
(Уральский государственный профессионально-педагогический университет)

Муслумов, Р. Р.

М96 Когнитивно-поведенческая терапия : учеб.-метод. пособие /
Р. Р. Муслумов ; под общ. ред. А. А. Печёркиной ; М-во науки
и высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Ека-
теринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2025. – 156 с. : ил. – Библиогр.:
с. 102–105. – 30 экз. – ISBN 978-5-7996-3992-1. – Текст : непо-
средственный.

ISBN 978-5-7996-3992-1

В учебно-методическом пособии рассмотрены теоретические и приклад-
ные аспекты когнитивно-поведенческой терапии, которая применяется для ра-
боты с различными психологическими проблемами, такими как депрессия,
тревожные расстройства и зависимости. Представлены инструменты психо-
терапевтической практики, основанные на актуальных научных данных и прове-
ренных клинических методах. Пособие снабжено обширным приложением, вклю-
чающим конкретные практические материалы для работы когнитивно-поведен-
ческого терапевта.

Рекомендуется студентам, изучающим дисциплину «Когнитивно-бихевио-
ральная психотерапия». Будет полезно психологам-практикам, особенно на ран-
них этапах вхождения в профессиональную деятельность.

УДК 615.851(07)
ББК Ю948.1я7

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	8
Тема 1. ИСТОРИЯ КППТ И КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ	11
Ключевые понятия	11
1.1. Что такое КППТ?	11
1.2. Отличительные черты КППТ	12
1.3. Философские принципы КППТ	14
1.4. Эволюция КППТ: теория волн	15
1.5. Когнитивная модель	18
1.6. Уровни мыслей	19
Темы для выступлений	22
Темы для обсуждения	22
Разбор техники	22
Информационные ресурсы для конспектирования	22
Практические задания	23
Тема 2. КОГНИТИВНАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ	25
Ключевые понятия	25
2.1. Когнитивная концептуализация	25
2.2. Виды глубинных убеждений	28
2.3. Когнитивная концептуализация сильных черт	29
Темы для выступлений	30
Темы для обсуждения	30
Разбор техник	30
Информационные ресурсы для конспектирования	30
Практические задания	31
Тема 3. ЦЕННОСТИ И МОТИВАЦИЯ КЛИЕНТА	33
Ключевые понятия	33
3.1. Терапевтические отношения в КППТ	33
3.2. Работа с ценностями клиента	34
3.3. Работа с мотивацией клиента	35
Темы для выступлений	37

<i>Темы для обсуждения</i>	38
<i>Разбор техники</i>	38
<i>Информационные ресурсы для конспектирования</i>	38
<i>Практические задания</i>	38
Тема 4. СТРУКТУРИРОВАНИЕ СЕССИЙ	40
Ключевые понятия	40
4.1. Структурирование в КПТ	40
4.2. Структура диагностической, или оценочной, сессии	41
4.3. Структура первой терапевтической сессии	43
4.4. Структура второй и последующих сессий	44
<i>Темы для выступлений</i>	44
<i>Темы для обсуждения</i>	44
<i>Разбор техник</i>	45
<i>Информационные ресурсы для конспектирования</i>	45
<i>Практические задания</i>	45
Тема 5. ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ:	
ПОВЕСТКА, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ	47
Ключевые понятия	47
5.1. Повестка	47
5.2. Обратная связь	48
5.3. Домашнее задание, или план активности	50
<i>Темы для выступлений</i>	51
<i>Темы для обсуждения</i>	51
<i>Разбор техник</i>	51
<i>Информационные ресурсы для конспектирования</i>	51
<i>Практические задания</i>	51
Тема 6. ЭТАПЫ И УРОВНИ	
КОГНИТИВНОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ	54
Ключевые понятия	54
6.1. Этапы работы с проблемой в КПТ	54
6.2. Выявление и оценка мыслей в КПТ	56
6.3. Когнитивные искажения	57
6.4. Работа с мыслями (когнитивная реструктуризация)	59
6.5. Работа с автоматическими мыслями	60

6.6. Работа с промежуточными убеждениями	61
6.7. Работа с глубинными убеждениями	63
<i>Темы для выступлений</i>	65
<i>Темы для обсуждения</i>	65
<i>Разбор техник</i>	65
<i>Информационные ресурсы для конспектирования</i>	65
<i>Практические задания</i>	66
Тема 7. ДИСПУТ	67
Ключевые понятия	67
7.1. Понятие диспутирования	67
7.2. Логический диспут	68
7.3. Функциональный диспут	69
7.4. Прагматический диспут	70
7.5. Стили диспутирования	71
7.6. Сократовский диалог	73
<i>Темы для выступлений</i>	75
<i>Темы для обсуждения</i>	75
<i>Разбор техник</i>	75
<i>Информационные ресурсы для конспектирования</i>	75
<i>Практические задания</i>	76
Тема 8. ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ: ЭКСПОЗИЦИЯ И АКТИВАЦИЯ	77
Ключевые понятия	77
8.1. Работа с поведением (модификация поведения)	77
8.2. Проверяем форму поведения (экспозицию)	79
8.3. Поведенческая активация	81
<i>Темы для выступлений</i>	83
<i>Темы для обсуждения</i>	83
<i>Разбор техник</i>	83
<i>Информационные ресурсы для конспектирования</i>	83
<i>Практические задания</i>	84
Тема 9. СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С ОТДЕЛЬНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ	86
Ключевые понятия	86
9.1. Работа с тревогой	86

9.2. Работа с депрессией	88
9.3. Работа с суицидальным риском	90
9.4. Работа с зависимостями	92
<i>Темы для выступлений</i>	95
<i>Темы для обсуждения</i>	95
<i>Разбор техники</i>	95
<i>Информационные ресурсы для конспектирования</i>	95
<i>Практические задания</i>	96
 Тема 10. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ	97
Ключевые понятия	97
10.1. Этапы работы с клиентом	97
10.2. Проблемы в терапии	98
10.3. Оценка эффективности терапии	99
<i>Темы для выступлений</i>	100
<i>Темы для обсуждения</i>	100
<i>Информационные ресурсы для конспектирования</i>	100
<i>Практические задания</i>	100
 Список информационных ресурсов, рекомендуемых для изучения	102
 <i>Приложение 1. Протоколы и техники КПТ</i>	106
1.1. Протокол СМЭР	106
1.2. Падающая стрела	108
1.3. Мотивационное интервью	108
1.4. Список ценностей	112
1.5. Список тем структурированного интервью для оценочной сессии	116
1.6. Список методик и клинических шкал	117
1.7. Чек-лист вопросов для структурирования сессий	118
1.8. Бланк сессии	119
1.9. Адаптивный ответ	120
1.10. Техника замены императивного иррационального убеждения эффективным новым убеждением	122
1.11. ЭМУУМЭ (разработчик Д. В. Ковпак)	123
1.12. Сократовский диалог, или направленное открытие	125

1.13. Техника сократовского вопрошания С. Уолтмана и Р. Кодда III ...	126
1.14. Протокол экспозиции	127
1.15. Техника самомониторинга	128
1.16. «За» и «против»	130
1.17. Нервно-мышечная релаксация Джекобсона и самонаблюдение	131
1.18. «Лестница страха»	133
1.19. Анализ мотивации изменений при тревоге	134
1.20. Чек-лист «Симптомы депрессии»	135
1.21. Техника «Удовольствие и удовлетворенность»	136
1.22. План безопасности, или антикризисный план	137
1.23. Варианты решения проблем терапии	138
<i>Приложение 2. Перечень проблем, решаемых с помощью КПТ</i>	<i>140</i>
<i>Приложение 3. Термины и понятия</i>	<i>146</i>

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) является одним из самых эффективных и широко используемых подходов в современной психотерапии. Она базируется на тесной связи между мыслями, эмоциями и поведением человека, а также на предположении о том, что негативные мысли и убеждения могут влиять на эмоциональное состояние и приводить к деструктивному поведению. КПТ предоставляет клиентам практические инструменты и стратегии, которые помогают им изменить свое мышление и поведение, а также эффективно справляться с жизненными трудностями и проблемами.

В данном пособии будут рассмотрены основные принципы и методы КПТ, а также представлены практические рекомендации и упражнения, которые помогут применить эту концепцию в работе с клиентами; обсуждены различные техники КПТ, а также показано, как данные методы могут быть адаптированы к различным ситуациям и потребностям клиентов.

Важная особенность КПТ – акцент авторов на ее научной доказательности. Множество исследований, проведенных на протяжении последних десятилетий, подтверждают эффективность КПТ в лечении широкого спектра психологических расстройств, включая депрессию, тревожные и панические расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство, фобии, нарушения пищевого поведения и многие другие.

Систематические обзоры и мета-анализы публикаций в научных журналах подтверждают, что КПТ демонстрирует значительные клинические результаты, причем эффекты часто оказываются долгосрочными и поддерживаются после завершения терапии. Эти исследования не только обнаруживают улучшение симптомов у клиентов, но и подтверждают, что КПТ сопровождается изменениями в когнитивных функциях и регуляции эмоций, что свидетельствует о глубоком понимании механизмов, которые лежат в основе эффективности данного подхода.

В учебно-методическом пособии представлены темы, рассматриваемые в подготовке клинических психологов по дисциплине «Когнитивно-бихевиоральная психотерапия». Каждая тема включает следующие разделы, ознакомление с которыми дает возможность ориентироваться в учебном материале:

- ключевые понятия;
- теоретический материал по теме;
- разработка практического занятия, содержащая темы для устных сообщений и обсуждений на занятии, перечень техник, разбираемых на занятии и информационные ресурсы для конспектирования;
- практические задания, предложенные в конце каждого занятия, являются наиболее популярными техниками в КПТ. Их выполнение позволит ознакомиться с техниками, которые в дальнейшем можно предложить клиентам. В процессе выполнения этих техник вы можете столкнуться с трудностями, аналогичными тем, которые в дальнейшем возникнут у ваших клиентов.

В приложениях к пособию представлены: перечень техник, бланков, чек-листов и других материалов, которые могут быть использованы в практической работе, а также словарь основных терминов. В конце пособия приведен список рекомендованной литературы.

Дисциплина, в освоении которой используется предложенное пособие, занимает важное место в подготовке клинического психолога. Это направление не только сочетает в себе теоретические знания и практические навыки, но и предоставляет специалистам инструменты для эффективной работы с клиентами. Настоящее учебно-методическое пособие призвано помочь студентам освоить ключевые концепции КПТ, а также научиться применять их в реальной практике. Благодаря своей структуре, оно позволяет не только углубленно изучить теоретический материал, но и через выполнение практических заданий познакомиться с популярными техниками терапии, которые впоследствии можно использовать в профессиональной деятельности.

Пособие организует учебный процесс таким образом, чтобы студенты могли не только понимать основные принципы КПТ,

но и разрабатывать собственные способы их применения в зависимости от ситуации и потребностей клиента. Включенные в пособие словарь терминов, перечень техник, чек-листы и другие материалы способствуют более глубокому и осознанному погружению в тему. Это не только систематизирует знания, но и обеспечивает их практическую значимость, делая пособие важным элементом в подготовке специалистов, способных эффективно применять КПТ в работе с клиентами.

Тема 1

ИСТОРИЯ КПТ И КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ

Ключевые понятия

Гипотеза доступности, гипотеза изменений, гипотеза медиации, реализм, эмпиризм, рационализм, конструктивизм, прагматизм, пятичастная модель жизненного опыта, когниции, реакции, бихевиоризм, стимул, реакция, когнитивная модель, произвольные мысли, автоматические мысли, промежуточные убеждения, определения, правила, предположения, глубинные убеждения.

1.1. Что такое КПТ?

КПТ – это форма психотерапии, которая фокусируется на взаимосвязи между мыслями, чувствами и поведением. Она основывается на идее, что не ситуации, в которые мы попадаем, а наши мысли в большей степени влияют на наши чувства и действия. Изменение неадаптивных, не соответствующих реальности мыслей может привести к изменению эмоций и поведения.

КПТ разработана на основе работ американских психологов Аарона Бека (1921–2021) и Альберта Эллиса (1913–2007) в середине XX в. и активно применяется для лечения различных психических проблем, таких как депрессия, тревожные расстройства, паническое расстройство, фобии, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), а также для управления стрессом и решения проблем.

В основе КПТ выделяют следующие ключевые гипотезы¹:

– **доступности**, согласно которой содержание и процесс мышления познаваемы и могут быть оценены. Человек может научиться тому, чтобы осознавать свой мыслительный процесс;

¹ См.: Добсон Д., Добсон К. Научно-обоснованная практика в когнитивно-поведенческой терапии. СПб. : Питер, 2021. С. 25–27.

– **медиации** – мысли выступают посредниками между ситуациями и эмоциональными, а также поведенческими реакциями;

– **изменений** – человек имеет возможность изменить свои эмоции и поведение посредством изменения отношения к ситуациям.

Терапевты, использующие КПТ, ориентированы на работу с убеждениями (когнитивная реструктуризация) и поведением (поведенческая модификация) клиентов.

«Когнитивная реконструкция», или «когнитивная реструктуризация», заключается в анализе и изменении негативных мыслей и убеждений с целью достижения более адаптивных и реалистичных представлений о себе, мире и будущем.

Поведенческая модификация направлена на изменение поведения клиента, в том числе на выработку новых форм поведения (поведенческая активация) и работу с формами избегания, позволяющую в рамках поведенческого эксперимента проверить возможность справиться с ситуациями, в которых клиент чувствует себя некомфортно (экспозиция). Терапевты, использующие КПТ, часто работают с клиентами, применяя такие техники, как контроль дыхания, релаксацию, тренировку в социальных навыках и стратегии преодоления неадаптивного поведения.

1.2. Отличительные черты КПТ

В основе каждого психотерапевтического направления выделяют набор ключевых принципов. Самая известная классификация принципов КПТ принадлежит Джудит Бек².

Данная классификация строится:

1. На концептуализации, т. е. описании клиентского случая, объясняющего природу трудностей клиента и способы их решения. Концептуализация согласовывается с клиентом на всех этапах помощи.

² См.: Бек Д. Когнитивно-поведенческая терапия. От основ к направлениям. 3-е изд. СПб. : Питер, 2024. С. 41–53. (Сер. «Когнитивно-поведенческая психотерапия»).

2. Крепком терапевтическом союзе. Эффективная работа – это результат совместных усилий, построение которых является одной из ключевых задач. Условия создания такого союза – регулярная обратная связь, внимание и поддержка.

3. Непрерывном наблюдении за прогрессом клиента. Используются еженедельные чек-листы симптомов, терапевт регулярно получает обратную связь от клиента.

4. Адаптации под культурные и индивидуальные особенности.

5. КПТ работает над развитием позитивного мышления.

6. Сотрудничестве и активном участии клиента. Терапия – это командная работа, в которой клиент берет на себя часть функций по определению повестки, подведению итогов, выбору плана активации.

7. Основана на ценностях и устремлениях, ориентированных на достижение цели.

8. Фокусе на настоящем. Терапия строится на проблемах, существующих «здесь и сейчас».

9. КПТ – образовательная терапия, цель которой – научить клиента быть терапевтом для самого себя. При этом клиент учится анализировать и решать обсуждаемые проблемы и большое внимание уделяет профилактике рецидивов.

10. Ограниченности во времени. Как правило, большинство клиентских случаев ориентированы на облегчение симптомов и ремиссию в течении 6–14 сессий.

11. Сессии структурированы, чтобы суть работы была понятна клиенту и в дальнейшем могла использоваться им для самопомощи.

12. Использует методику направляемого открытия и обучения клиента выявлять, оценивать и реагировать на собственные дисфункциональные мысли и убеждения.

13. Включает планы действий (выполнение домашней работы).

14. Использование техник, изменяющих образ мыслей, настроение и поведение.

КПТ обычно является краткосрочной и эффективной формой психотерапии, часто она ограничивается относительно небольшим количеством сессий, что делает ее привлекательной для многих

людей, ищущих помощи в решении конкретных проблем или справляющихся с психическими расстройствами.

Терапия направлена на идентификацию и переоценку негативных мыслей, разработку более здоровых и позитивных убеждений, а также использование конкретных стратегий и техник для изменения поведенческих паттернов.

1.3. Философские принципы КПТ

Изучение КПТ как научного направления начинается в середине XX в., однако идеи, лежащие в ее основе, появились гораздо раньше. В рамках философии был заложен ряд идей и принципов, которые и сегодня используются в КПТ.

КПТ имеет свои корни в нескольких философских идеях, оказавших значительное влияние на ее развитие. Приведем некоторые из основных философских концепций, лежащих в основе КПТ:

- **реализм**: объективная реальность существует независимо от того, осознаем мы ее или нет, поэтому чем больше человек знает о мире, тем лучше он может функционировать в этом контексте. То, насколько мы психически здоровы, напрямую зависит от того, насколько точно мы ориентируемся в мире;

- **эмпиризм**: клиенты исследуют свои мысли, эмоции и поведение на основе конкретных наблюдений и опыта, а не предположений или абстракций. Принцип эмпиризма подчеркивает важность опыта и наблюдения в процессе познания мира;

- **рационализм**, напротив, выделяет важность разума и мышления в понимании мира. В КПТ это проявляется в акценте на рациональном анализе и переоценке мыслей и убеждений, которые могут быть источником дистресса;

- **конструктивизм** подчеркивает активное участие индивида в процессе познания и конструирования своего опыта. В рамках КПТ это означает, что терапия строится на понимании индивидуального опыта и интерпретации событий, а также на активном участии клиента в изменении своих мыслей и поведения;

- **прагматизм** указывает на важность практических результатов и применимости идей в реальной жизни. Терапевты ориен-

тированы на конкретные цели изменения и разработку практических стратегий, которые помогут клиентам управлять своими мыслями и эмоциями.

Все названные философские идеи в разной степени влияют на основные принципы и методы КПТ. Они подчеркивают важность практического подхода к психотерапии, а также акцентируют внимание на роли мышления и интерпретации в формировании эмоционального состояния и поведения человека.

1.4. Эволюция КПТ: теория волн

На сегодняшний день популярной является идея о выделении трех волн КПТ.

Первая волна связана с развитием поведенческой психологии в начале XX в., которая была сформирована в значительной степени работами Ивана Петровича Павлова (1849–1936) и Джона Б. Уотсона (1878–1958), а также других ведущих бихевиористов (Э. Торндайк, Э. Толмен) того времени. В тот период в психологии преобладало убеждение, что для понимания человеческого поведения достаточно изучать его внешние проявления и условия, которые их вызывают, без обращения к внутренним процессам мышления.

Идеи Павлова о классическом условном рефлексе и подход Уотсона к поведению, базирующиеся на принципе «стимул – реакция», стали основой для развития поведенческой терапии. И. П. Павлов и Д. Уотсон доказали, что поведение можно изменить путем контроля над стимулами и реакциями, а не через работу с внутренним миром человека.

Данные идеи повлияли на появление поведенческих методик, таких как систематическая десенсибилизация и экспозиция, которые стали частью первых форм КПТ. Основной акцент делался на изменение поведенческих реакций с помощью систематической модификации внешних стимулов и ассоциаций. В этот период терапевты больше внимания обращали на проблемы фобий и навыки управления стрессом.

Вторая волна связана с работами выдающихся психотерапевтов Аарона Т. Бека (1921–2021) и Альберта Эллиса (1913–2007).

Она начала формироваться в 1950–1960-х гг. и включала ряд новых концепций и методов, которые дополнили и расширили первоначальные бихевиористские подходы.

А. Т. Бек разработал когнитивную терапию (КТ), основанную на идее, что негативные мысли и убеждения играют решающую роль в развитии и поддержании психологических проблем. Он выделил ряд когнитивных искажений, или ошибок мышления, которые приводят к негативным эмоциональным состояниям, таким как депрессия и тревожность, разработал методы для анализа и изменения этих мыслей, что позволило клиентам преодолевать свои психологические проблемы.

А. Эллис создал рационально-эмоциональную терапию (в дальнейшем рационально-эмотивно поведенческую терапию – РЭПТ), основанную на принципах рационального мышления. Он утверждал, что не сами события вызывают эмоциональные реакции, а способ, которым люди интерпретируют эти события. Эллис разработал методы, которые помогали клиентам идентифицировать и изменять их иррациональные убеждения, что приводило к улучшению их эмоционального состояния и поведения.

Оба специалиста сделали значительный вклад в развитие КПТ, расширив ее теоретические основы и практические методы. Их работы стали основой для многих современных подходов в психотерапии и оказали значительное влияние на понимание психологических проблем и их решение.

Третья волна представляет собой современное развитие КПТ, которое началось в конце прошлого века и продолжается до сегодняшнего дня. Она характеризуется расширением и дальнейшим развитием концепций и методов КПТ, а также интеграцией с другими направлениями психотерапии и научными исследованиями.

Одним из ключевых аспектов третьей волны КПТ является акцент на процессе и механизмах изменения, а также на контекстуальном подходе к пониманию психологических проблем. На данном этапе уделяется больше внимания не только тому, что происходит внутри клиента, но и внешним факторам, таким как окружающая среда, социальные взаимодействия и культурные особенности.

Третья волна включает в себя различные подходы и методы, часть которых представлена в следующем списке:

- КТ, основанная на осознанности – Mindfulness Based Cognitive Therapy³;
- терапия принятия и ответственности – Acceptance and Commitment Therapy⁴;
- диалектико-поведенческая терапия – Dialectical behavior therapy (DBT)⁵;
- схемотерапия – Schema Therapy⁶;
- метакогнитивная терапия – Metacognitive Therapy⁷;
- травма – сфокусированный подход – Trauma focused cognitive behavioral therapy⁸;
- терапия, ориентированная на сострадание – Compassion-focused therapy⁹;
- КТ, ориентированная на восстановление – Recovery-Oriented Cognitive Therapy (CT-R)¹⁰.

Появление направлений третьей волны не означает устаревание и неактуальность направлений второй волны, а большую ориентацию на отдельных аспектах лечения или категорий клиентов. Все направления строятся на базовой идее, объединяющей КПТ – когнитивную модель.

³ См.: *Segal Z. V., Williams J. M. G., Teasdale J. D.* Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression: A New Approach to Preventing Relapse. New York : Guilford Press, 2002.

⁴ См.: *Hayes S. C., Strosahl K. D., Wilson K. G.* Acceptance and Commitment Therapy: An Experiential Approach to Behavior Change. New York : Guilford Press, 1999.

⁵ См.: *Linehan M. M.* Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. New York : Guilford Press, 1996.

⁶ См.: *Young J. E.* Cognitive Therapy for Personality Disorders: A Schema-Focused Approach. Sarasota, FL : Professional Resource Exchange, 1990.

⁷ См.: *Wells A., Matthews G.* Attention and Emotion: A Clinical Perspective. Hove, UK : Lawrence Erlbaum Associates, 1994.

⁸ См.: *Cohen J. A., Mannarino A. P., Deblinger E.* Treating Trauma and Traumatic Grief in Children and Adolescents. New York : Guilford Press, 2006.

⁹ См.: *Gilbert P.* Compassion: Conceptualisations, Research and Use in Psychotherapy. London : Routledge, 2006.

¹⁰ См.: *Beck A. T., Grant P. M.* Recovery-Oriented Cognitive Therapy for Serious Mental Health Conditions. New York : Guilford Press, 2021.

1.5. Когнитивная модель

Когнитивная модель является каркасом подхода и обеспечивает основу для понимания того, как мысли, чувства и поведение взаимодействуют между собой. Визуально все элементы, представленные в данной модели, можно увидеть в пятичастной модели жизненного опыта, предложенной Кристин Падески¹¹ (рис. 1).

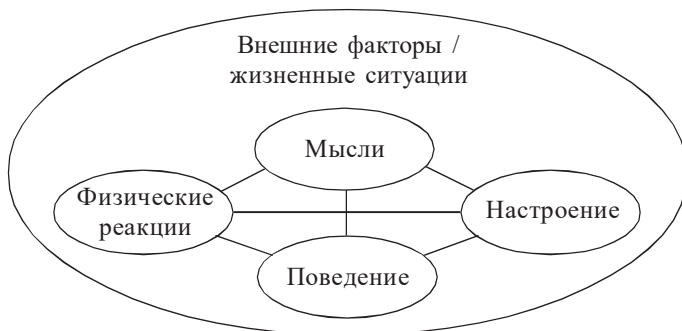


Рис. 1. Пятичастная модель жизненного опыта К. Падески

Элементы модели взаимно влияют друг на друга, изменение каждого из них неминуемо отразится на остальных. Так, например, смена обстановки (ситуации) может позитивно отразиться на психоэмоциональном состоянии клиента (эмоции).

Многочисленные наблюдения и исследования показали, что элементы организованы определенным образом. Данная организация и лежит в основе структуры когнитивной модели, где главной является идея о том, что мысли клиента проксимально (в наибольшей степени) определяют его эмоции, физиологические ощущения и поведение. Не ситуация определяет, что чувствуют люди, но ее восприятие (рис. 2)¹².

¹¹ См.: Гринбергер Д., Падески К. А. Разум рулит настроением. Измени свои мысли, привычки, здоровье, жизнь. СПб. : Питер, 2019. С. 31.

¹² См.: Beck A. T. Thinking and depression: 2. Theory and therapy // Archives of general psychiatry. 1964. Т. 10, nr 6. С. 561–571; Ellis A. Reason and emotion in psychotherapy. L. : Stuart, 1962.

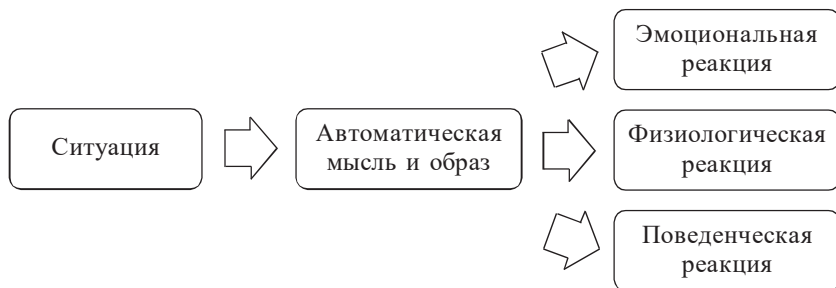


Рис. 2. Когнитивная модель по Дж. Бек

В процессе терапии важно постоянно подчеркивать и доносить до клиента когнитивную модель, показывать, что вы интерпретируете рассматриваемые ситуации в ее ключе. Наиболее удобным средством объяснения когнитивной модели является анализ конкретной проблемной ситуации клиента с помощью протокола СМЭР – ситуации, мысли, эмоции, реакции (прил. 1.1).

1.6. Уровни мыслей

В КПТ выделяют несколько уровней мыслей, которые играют важную роль в природе психологических проблем у клиента. Как отмечают А. Бек и А. Фримен, «важные когнитивные конструкты являются категориально и иерархично организованными»¹³. Анализ этих уровней помогает терапевту и клиенту понимать различные аспекты мышления, а также определять стратегии работы для достижения желаемых изменений.

На рис. 3 представлены уровни когниций, причем чем выше уровень, тем проще он осознается клиентом и тем легче его скорректировать.

На верхнем уровне располагаются *произвольные мысли*. Это мысли, сопровождающие действия человека, призванные решать вопросы планирования и сопровождения действий. Их условно

¹³ Бек А., Фримен А. Когнитивная психотерапия расстройств личности. СПб. : Питер, 2024. С. 23. (Сер. «Мастера психологии»).

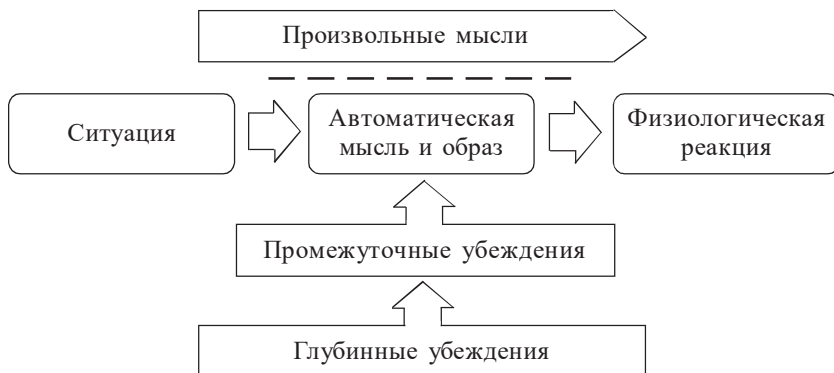


Рис. 3. Уровни мыслей в КПТ

можно назвать мыслями «холодными», т. е. не имеющими эмоционального заряда. Такими мыслями могут быть следующие мысли: «который сейчас час?», «надо взять ключи, которые я положил на стол» и т. д.

Автоматические мысли возникают у человека в ответ на определенные события или ситуации. Они могут быть неосознаваемыми, но при этом эмоционально окрашенными. Их задача – сверять то, что происходит в реальности с субъективной картиной мира. Они как будто проводят оценку того, что происходит с человеком на соответствие с тем, как все должно происходить. Например, автоматическая мысль «я никогда не справлюсь» может возникнуть в ответ на сложную задачу или вызов.

Потоки произвольных и автоматических мыслей происходят, как будто параллельно. Произвольные мысли сосредоточены на решении осознаваемых задач, автоматические, в свою очередь, оценивают правильность происходящего. Метафорически это можно описать как работу компьютера, где параллельно с работой программ (произвольные мысли) функционируют процессы, контролирующие работоспособность системы в целом (автоматические мысли).

Почему у человека возникают именно эти автоматические мысли, а не какие-то другие? Почему один человек в ситуации экзамена думает «у меня не получится», а другой «я уверен, что

успешно сдать экзамен»? Ответ на этот вопрос – наличие укоренившихся убеждений, представляющих собой устоявшиеся схемы мышления.

Это *промежуточные убеждения*, которые представляют собой устоявшиеся обобщенные представления о том, как в мире все устроено. Можно выделить три вида промежуточных убеждений:

– *определения* – суждения о том, что и чем может являться. Обычно они не вызывают сомнений у клиентов, воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. В качестве примера можно привести такие определения: «жизнь – это борьба», «без труда не выловишь и рыбку из пруда» и т. д. По своему строению они могут напоминать пословицы или краткие определения;

– *долженствования, или правила* – категоричные убеждения в том, как все должно быть. Они могут относиться к самому человеку, другим людям и окружающему миру в целом. В РЭПТ долженствование рассматривается как основное когнитивное искажение. Примером может быть мысль «я должна всем нравиться»;

– *предположения* – это условные суждения о наличии причинно-следственной связи, сформулированные в форме «если..., то...». Примером может быть идея о том, что «если я получу плохую оценку, то окружающие будут надо мной смеяться».

И наконец, базовый когнитивный уровень – это *глубинные убеждения*. Они являются основополагающими представлениями человека о себе¹⁴. Так как в терапии речь идет о решении проблем, то и глубинные убеждения в этом контексте рассматриваются как негативные. Примером могут быть убеждения «я – никчемный» или «я – беспомощный». Сегодня одним из трендов в развитии психотерапии является опора на сильные стороны личности, а не просто решение проблем. Терапевт пытается работать посредством достижения целей в соответствии с ценностями клиента. В связи с этой особенностью в актуальных работах все чаще появляется идея о позитивных глубинных убеждениях, которые могут быть опорой в решении проблем клиента.

¹⁴ См.: Бек Д. Когнитивно-поведенческая терапия. От основ к направлениям. С. 257.

Темы для выступлений

1. Философские основания КПТ.
2. Роль Аарона Бека в становлении КПТ.
3. Работы Альберта Эллиса и их роль в развитии КПТ.
4. Обзор направлений третьей волны КПТ.
5. Актуальные проблемы и исследования в КПТ.
6. Перечень проблем, с которыми успешно работает КПТ.

Темы для обсуждения

1. В чем заключаются трудности объяснения клиенту когнитивной модели?
2. Какие тенденции в развитии КПТ можно выделить сегодня, и какие новые направления исследований в этой области могут быть перспективными?

Разбор техники

Протокол СМЭР.

Информационные ресурсы для конспектирования

Бек Д. Когнитивно-поведенческая терапия. От основ к направлениям. Гл. 1. «Введение в когнитивно-поведенческую терапию» / Д. Бек. 3-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2024. С. 20–40. (Сер. «Когнитивно-поведенческая психотерапия»).

МакМаллин Р. Практикум по когнитивной терапии. Гл. 1 / Р. МакМаллин ; пер. с англ. Санкт-Петербург : Речь, 2001. С. 22–54.

Бек Д. Когнитивно-поведенческая терапия. От основ к направлениям. Гл. 13. Эмоции / Д. Бек. 3-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2024. С. 236–309. (Сер. «Когнитивно-поведенческая психотерапия»).

Прохазка Дж. Системы психотерапии: Для консультантов, психотерапевтов и психологов. Гл. 16 «Будущее психотерапии» / Дж. Прохазка, Дж. Норкросс. Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРО-ЗНАК, 2007. С. 374–383.

Ковпак Д. В. Вклад отечественных ученых в развитие когнитивно-поведенческой терапии // I Междунар. съезд Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии : сб. науч. ст. Санкт-Петербург : СИНЭЛ, 2015. С. 28–36.

Ромек Е. А. Философские концепции, лежащие в основании современной когнитивно-поведенческой психотерапии / Е. А. Ромек, В. Г. Ро-

мек // Сб. науч. ст. 6-го Междунар. форума CBTFForum. Санкт-Петербург, 2022. Санкт-Петербург : Лема, 2022. С. 212–215.

Open, aware, and active: Contextual approaches as an emerging trend in the behavioral and cognitive therapies / S. C. Hayes, M. Villatte, M. Levin, M. Hildebrandt // *Annual Review of Clinical Psychology*. 2011. Vol. 7. P. 141–168.

Beck A. T. Cognitive therapy: current status and future directions / A. T. Beck, D. J. A. Dozois // *Annual Review of Medicine*. 2011. Vol. 62. P. 397–409.

What four decades of meta-analysis have taught us about youth psychotherapy and the science of research synthesis / J. R. Weisz, S. Kuppens, M. Y. Ng, D. Eckshtain, A. M. Ugueto, R. Vaughn-Coaxum, A. Jensen-Doss // *Annual Review of Clinical Psychology*. 2023. Vol. 19. P. 79–105.

Практические задания

Задание 1. Разделение мыслей и фактов

Довольно часто клиент, говоря о своих мыслях, воспринимает их как очевидные факты. Например, мысль о том, что у него ничего не получится, может не соответствовать реальности. Мысль – всего лишь наша попытка осознать то, что происходит объективно. Это не всегда легкая задача.

Для выполнения задания необходимо выписать несколько ситуаций, которые произошли на прошлой неделе, вызвав негативные эмоции. Напишите слева на странице обстоятельства / факты, относящиеся к ситуации, а справа – ваши мысли / интерпретации по этому поводу.

Пример выполнения задания:

Обстоятельства / факты	Мысли / интерпретации
1. Пропустил срок сдачи проекта на работе.	1. «Я полный неудачник, не способен управлять своим временем и обязанностями».
2. Получил от начальника выговор за некачественную работу.	2. «Меня уволят, я не подхожу для этой работы».
3. Пропустил важное семейное событие из-за переработок.	3. «Моя семья разочарована во мне, я не могу уделить ей достаточно времени».
4. Потерял ключи от квартиры и опоздал на важную встречу.	4. «Я никогда не стану настоящим профессионалом, постоянно делаю ошибки».
5. Погода на прошлой неделе была дождливой и мрачной	5. «Плохая погода – это просто еще одно подтверждение моего несчастья и неудач»

Задание 2. Дневник СМЭР

Вам нужно будет установить любые два приложения для ведения дневника на вашем телефоне, которые предназначены для отслеживания ваших эмоций, мыслей и реакций (СМЭР – ситуации, мысли, эмоции, реакции).

После установки приложений вам необходимо будет записать три события из жизни, которые вызвали у вас негативные эмоции. В каждой записи укажите подробности о ситуации, ваши мысли или интерпретации этого события, а также эмоции, которые оно вызвало.

Попробуйте также описать, как вы реагировали на эти эмоции, какие действия предприняли в ответ на них. Данное задание поможет вам лучше понять, что именно вызывает у вас негативные эмоции, как вы реагируете на них, и найти способы более конструктивной обработки этих эмоций.

Задание 3. Подборка материалов

Сделайте подборку исследований, демонстрирующих эффективность КПТ по любой из проблем, представленных в прил. 2.

Тема 2

КОГНИТИВНАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ

Ключевые понятия

Концептуализация (формулировка), значение автоматической мысли, значимые события детства или важная информация о детстве, произвольная мысль, автоматическая мысль, глубинное убеждение, правила как промежуточные убеждения, ожидания/допущения как промежуточные убеждения, отношения как промежуточные убеждения, компенсаторная стратегия, перфекционизм.

2.1. Когнитивная концептуализация

Концептуализация в КПТ – процесс создания индивидуализированного понимания проблемы или расстройства клиента на основе когнитивной модели. Этот процесс помогает терапевту разработать стратегию лечения, опираясь на понимание основных когнитивных, эмоциональных и поведенческих факторов, влияющих на состояние клиента.

Основные компоненты концептуализации в КПТ включены в схему концептуализации, предложенную Джудит Бек¹⁵ (рис. 4).

Ключевых элементов в когнитивной концептуализации четыре, опишем их роль в происхождении и проявлении проблем клиента:

1. **Значимые события детства** формируют у клиента уникальный способ воспринимать себя, окружающих и мир вокруг себя. Эти события оказывают влияние на формирование ключевых когнитивных структур, убеждений и схем, которые определяют поведение и реакции клиента на различные ситуации.

Важно отметить, что не только сами события детства играют роль, но и способ, которым клиент интерпретирует их. Например,

¹⁵ См.: Beck A. T. Cognitive approaches to panic disorder: Theory and therapy // Panic. Routledge, 2013. P. 91–109.

Значимые события детства

- События, которые повлияли на формирование и укрепление глубинных убеждений

Глубинные убеждения

- Основные убеждения клиента о себе и окружающем мире

Промежуточные убеждения

- Система правил выработанная, чтобы справиться с наличием глубинного убеждения, проявлять себя адаптивно

Компенсаторные стратегии

- Алгоритмы поведения, включающие способы реагирования на жизненные ситуации в связи с наличием системы убеждений

Рис. 4. Элементы когнитивной концептуализации

дети, пережившие травматические события, могут развить убеждения о собственной неполноценности или ненадежности окружающего мира, что затем может проявиться в различных проблемах в зрелом возрасте. На основе интерпретаций значимых событий детства формируется глубинное негативное убеждение клиента в восприятии себя.

2. Глубинное убеждение – это аналог линзы, через которую человек воспринимает окружающий мир. Глубинные убеждения представляют собой основные, часто смутно осознаваемые убеждения о себе, других и мире, которые формируются на ранних этапах жизни и оказывают значительное влияние на мышление, эмоции и поведение человека.

Эти убеждения являются более абстрактными и общими, чем поверхностные мысли, и часто лежат в основе множества конкретных мыслей и убеждений. Аарон Бек отмечает, что «глубинные убеждения – это устойчивые представления, настолько фундаментальные и глубокие, что часто не осознаются и не формируются даже самим человеком. Они воспринимаются как абсолютные истины и влияют на то, как человек обрабатывает информацию,

воспринимает себя и других, а также эмоционально реагирует на ситуации»¹⁶.

Глубинные убеждения в КПТ также иногда называются «ядром убеждений», или «основными убеждениями». Эти убеждения часто становятся автоматическими и бессознательными, и они могут переживать подтверждение через жизненный опыт, что укрепляет их влияние.

3. Промежуточные убеждения – в когнитивной концептуализации «обслуживают» глубинное убеждение. Так, например, если у клиента есть глубинное убеждение «Я – недостойн любви», то промежуточным убеждением может быть «Я должен заслужить любовь».

Глубинные и промежуточные убеждения возникают на ранних стадиях развития, когда люди пытаются понять окружающий мир и им необходимо организовать полученный опыт таким образом, чтобы вести себя адаптивно¹⁷.

4. Компенсаторные стратегии связывают систему убеждений клиента с тем, как это будет проявляться в поведении. Можно выделить три основные категории компенсаторных стратегий:

- *гиперкомпенсация* – попытка всячески контролировать проблемную сферу. В примере с клиентом выше – «Надо быть все время в отношениях и не дать партнерше уйти»;

- *избегание* – попытка игнорировать проблемную сферу. В нашем примере – «Я должен уйти первым».

- *капитуляция* – принять проблемную ситуацию, ничего с ней не делать, надеясь на лучший исход. В примере с клиентом выше – «Я никому не нужен и не буду пытаться что-то с этим делать».

Таким образом, четыре элемента концептуализации создают единую взаимно обуславливающую систему, которая объясняет природу трудностей клиента и позволяет определить направление терапии. Для выявления более глубоких уровней убеждений используется техника «Падающая стрела» (прил. 1.2).

¹⁶ Clark D. A., Beck A. T. Cognitive Therapy of Anxiety Disorders: Science and Practice. New York : Guilford Press, 2010. P. 484.

¹⁷ См.: Rosen H. The Constructivist-Development Paradigm // Paradigms of Clinical Social Work / ed. by R. A. Dorfman. 1st ed. New York : Routledge, 1988. P. 39.

2.2. Виды глубинных убеждений

Глубинные негативные убеждения целесообразно классифицировать на три группы. Изначально Аароном Бекон были выделены две категории глубинных убеждений: беспомощность и непривлекательность. Джудит Бек добавляет в эту классификацию категорию бесполезности, или никчемности (табл. 1).

Т а б л и ц а 1

Виды глубинных убеждений и общие стратегии их коррекции

Название убеждения на русском	Название убеждения на английском	Общая стратегия решения проблемы
Я – беспомощный	HELPLESS CORE BELIEFS	Повышение эффективности
Я – непривлекательный или ненужный	UNLOVABLE CORE BELIEFS	Поведенческий эксперимент
Я – никчемный	WORTHLESS CORE BELIEFS	Безусловное принятие

Часто при переводе теряется смысл выделенного убеждения, поэтому в табл. 1 приведен англоязычный вариант. Так, убеждение в беспомощности можно буквально рассматривать как «нуждающийся в поддержке», категорию непривлекательности – как «неспособный вызвать любовь», а категорию никчемности – как «нестоящий», или «недостойный».

Категория непривлекательности и никчемности – по сути общая категория отверженности с оговоркой, что непривлекательность – отверженность другими людьми, а никчемность – отвержение самого себя.

Смысл выделения категорий глубинного убеждения в том, что это дает возможность определить общую стратегию решения проблемы клиента. В случае с беспомощностью совместные усилия терапевта и клиента будут направлены на выработку эффективности в деятельности, чтобы получить поведенческое подтверждение того, что клиент не беспомощен. В случае с непривлека-

тельностью работа будет строиться на основе поведенческого эксперимента для того, чтобы проверить глубинное убеждение и увериться в том, что даже отвержение не является катастрофой, разрушающей личность клиента. В случае с убеждением в никчемности усилия будут направлены на техники безусловного принятия.

Таким образом, выявление категории глубинного убеждения позволяет выстраивать когнитивную концептуализацию проблемы и определять общую стратегию терапии.

2.3. Когнитивная концептуализация сильных черт

В современных трактовках построения концептуализации предлагается обращение к понятию «концептуализация сильных черт»¹⁸. Ее построение – это процесс, направленный на идентификацию и акцентирование сильных и позитивных аспектов личности клиента. Подход позволяет клиенту переоценить себя и свои способности, а также развить более здоровую и позитивную самооценку.

Приведем несколько шагов для концептуализации сильных черт:

1. Идентификация сильных черт. Терапевт совместно с клиентом идентифицирует и описывает сильные и позитивные черты личности, навыки и достижения клиента. Это может включать в себя такие аспекты, как доброта, эмпатия, настойчивость, креативность, а также профессиональные навыки и достижения.

2. Анализ влияния. Терапевт и клиент анализируют влияние этих сильных черт на различные аспекты жизни клиента, такие как отношения, работа, учеба, хобби и т. д. Они обсуждают, какие преимущества приносят данные качества в жизнь клиента.

3. Поддержка и укрепление. Терапевт поддерживает клиента, подчеркивая его сильные стороны и успехи, а также помогает ему укрепить и развить названные черты. Это может включать в себя поощрение и поддержку, упражнения по укреплению самооценки

¹⁸ См.: Бек Д. Когнитивно-поведенческая терапия. От основ к направлениям. С. 78–81.

и самопринятия, а также развитие новых навыков на основе сильных сторон.

4. Использование в терапии. Терапевт интегрирует сильные черты клиента в процесс терапии, используя их для поддержки и достижения терапевтических целей, что может включать в себя использование сильных черт как ресурсов для преодоления проблем и развития новых стратегий решения проблем.

5. Поддержка рефлексии и роста. Терапевт помогает клиенту осознать свои сильные стороны и ценности, а также поощряет его к постоянному саморазвитию и росту. Это включает в себя постоянную рефлексию и работу над развитием новых навыков и качеств.

Концептуализация сильных черт помогает клиентам увидеть себя в более позитивном свете, укрепляет их самооценку и самопринятие, а также способствует развитию личностного роста и психологического благополучия.

Темы для выступлений

1. Практическое значение когнитивной концептуализации в КПТ.
2. Обзор клинических шкал, используемых в диагностической работе.
3. Варианты организации структурированного интервью на оценочной сессии.

Темы для обсуждения

1. Варианты организации сбора анамнеза по клиентскому случаю.
2. Особенности обсуждения концептуализации с клиентом.

Разбор техник

1. Структурированная беседа для сбора анамнеза.
2. Падающая стрела (прил. 1.2).

Информационные ресурсы для конспектирования

Бек А. Т. 60-летняя эволюция когнитивной теории и терапии / А. Т. Бек // Сб. науч. ст. 6-го Междунар. форума СВТForum. Санкт-Петербург, 2022. С. 7–16.

Бурдин М. В. Индивидуальная кейс-концептуализация в КПТ: варианты и перспективы / М. В. Бурдин // Когнитивно-поведенческий подход в консультировании и психотерапии : сб. ст. II Междунар. науч.-практ. конф. Минск, 5–6 ноября 2020 года. Минск : Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», 2020. С. 16–21.

Добсон Д. Научно-обоснованная практика в когнитивно-поведенческой терапии. Гл. 3. «Интеграция и концептуализация» / Д. Добсон, К. Добсон. Санкт-Петербург : Питер, 2021. С. 63–95.

Малыгин Я. В. Концептуализация коморбидных тревожных и депрессивных расстройств и подходы к их ведению / Я. В. Малыгин, А. С. Орлова, В. Л. Малыгин // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2022. Т. 122, №. 6. С. 48–54.

Easden M. H. Case conceptualization research in cognitive behavior therapy: A state of the science review / M. H. Easden, N. Kazantzis // Journal of clinical psychology. 2018. Т. 74, nr 3. P. 356–384.

Практические задания

Задание 1. Составьте список из 30 событий, которые произошли в вашей жизни на разных этапах: в детстве, подростковом и зрелом возрасте. Вам нужно выбрать по 10 событий для каждого периода.

При составлении списка обратите внимание на разнообразие событий, которые имеют для вас значение, отражают важные моменты жизни и оказали влияние на развитие. Это могут быть как положительные, так и негативные события, которые оставили след в памяти и сформировали вас как личность.

Возле каждого события напишите, какое значение оно для вас имело, какой вывод вы из него сделали.

Пример выполнения

Детство

Событие: первый день в школе, учительница ошиблась, когда читала мою фамилию, а все засмеялись.

Значение: данное событие было непростым для меня, так как я почувствовал себя потерянным и испытал страх перед неизвестным. Из него я сделал вывод, что надо всегда говорить громко, иначе над тобой будут смеяться. Этот день оставил во мне чувство неуверенности и тревоги.

Задание 2. Сформулируйте варианты промежуточных убеждений по типам: правило, предположение и отношение:

1. «Ошибка – это провал».
2. «Настоящая женщина обязана всегда отлично выглядеть».
3. «Если я не сдам этот экзамен, то все будут думать, что я неудачник».
4. «Я не должен опаздывать».
5. «Если не можешь сделать что-то идеально, то нет смысла делать это вообще».

Пример выполнения:

- долженствование – «я должна быть хорошей матерью», «мой ребенок должен хорошо учиться»;
- определение – «у хороших матерей дети хорошо учатся»;
- предположение – «если мой ребенок учится плохо, то я плохая мать».

Задание 3. В указанной ситуации пропишите все возможные компенсаторные стратегии, согласно рассмотренной классификации в п. 2.1.

«Получив плохую оценку на устном экзамене, Николай, студент второго курса, чувствует, как негативные эмоции захлестывают его. Ему кажется, что все его усилия и время, вложенные в подготовку к этому экзамену, оказались напрасными. Страх перед тем, что он и дальше не сможет учиться, заставляет его сомневаться в своих способностях и ценности как студента.

Он чувствует себя одиноким и беспомощным перед таким событием. Этот неудачный экзамен стал для него не только препятствием на пути к учебе, но и испытанием его самооценки и веры в собственные силы. Николай понимает, что не может оставаться в подобном состоянии и что нужно что-то делать.

Он решает...».

Объясните, от чего будет зависеть выбор Николая.

Задание 4. Выберите любого героя классического произведения русской литературы и составьте его когнитивную концептуализацию проблемы и когнитивную концептуализацию сильных черт.

Тема 3

ЦЕННОСТИ И МОТИВАЦИЯ КЛИЕНТА

Ключевые понятия

Триада Роджерса, искренний интерес, конгруэнтность самовыражения, безоценочное принятие, терапевтические отношения, абстрактные цели, конкретные цели, ценности, активное слушание, мотивационное интервью, ответственный гедонизм, самоэффективность.

3.1. Терапевтические отношения в КПТ

В КПТ терапевтические отношения играют ключевую роль в успешности терапевтического процесса. Сформированный альянс лежит в основе эффективной терапевтической работы.

Терапевтические отношения в КПТ основаны на эмпатии, поддержке, взаимном доверии и сотрудничестве между терапевтом и клиентом. В основу терапевтических отношений можно положить популярную идею о триаде, предложенной Карлом Роджерсом (1902–1987), которая является концептуальной моделью, состоящей из трех компонентов:

- **эмпатии**, отражающей способность терапевта понимать и воспринимать мир клиента через его собственную перспективу. Включает в себя не только понимание эмоционального состояния клиента, но и активное стремление к сочувствию и поддержке его чувств и переживаний;

- **позитивного принятия**, предполагающего безусловное принятие клиента терапевтом. Это означает создание атмосферы доверия и безопасности, в которой клиент чувствует себя способным свободно выражать свои мысли и чувства, даже если они отличаются от нормативных или ожидаемых;

- **подлинности (конгруэнтности)**, относящейся к способности терапевта быть искренним и аутентичным во взаимодействии

с клиентом. Это включает в себя готовность терапевта быть открытым и честным относительно своих собственных чувств, мыслей и опыта, что способствует развитию и укреплению взаимодоверия в терапевтической работе.

В триаде К. Роджерса основной акцент делается на построении терапевтических отношений с клиентом. В КППТ, как отмечают А. Бек с коллегами, «вышеназванные характеристики являются необходимыми, но не единственными условиями для достижения оптимального терапевтического эффекта»¹⁹.

К важным аспектам терапевтических отношений в КППТ можно дополнительно отнести следующие:

1. Работа с ценностями клиента, их согласование для построения эффективной работы и поддержки мотивации клиента.
2. Сотрудничество и равноправие в определении целей работы.
3. Поддержание четкой структуры взаимодействия, делающего работу понятной для клиента.
4. Терапевт регулярно предоставляет клиенту обратную связь по ходу терапии, помогая ему осознать прогресс и преодолевать трудности. Сам клиент также регулярно дает обратную связь терапевту, поэтому уровень открытости и доверия повышается.
5. Терапевт соблюдает конфиденциальность, что способствует созданию атмосферы доверия и безопасности.

Терапевтические отношения в КППТ играют важную роль в успешном лечении клиента, обеспечивая ему поддержку, мотивацию и понимание в процессе преодоления психологических проблем, которые являются основой для эффективного взаимодействия между терапевтом и клиентом и способствуют достижению поставленных целей терапии.

3.2. Работа с ценностями клиента

Данная работа играет важную роль, поскольку ценности клиента являются ключевыми мотивирующими факторами поведения

¹⁹ Когнитивная терапия депрессии / А. Бек, А. Раш, Б. Шо, Г. Эмери. СПб. : Питер, 2003. С. 44. (Сер. «Золотой фонд психотерапии»).

человека. В контексте КПТ ценности рассматриваются как важные убеждения и принципы, определяющие, что для клиента является важным и значимым в жизни.

Основными методами работы с ценностями в КПТ являются идентификация и оценка значимости ценностей для клиента. Терапевт помогает ему определить и проанализировать его ценности, выявить их важность и соответствие текущему образу жизни. Это может быть осуществлено через использование различных техник, таких как ведение дневника, обсуждение важных событий и переживаний, а также проведение специальных упражнений.

В КПТ также акцентируется внимание на выстраивании соответствия между поведением клиента и его ценностями. Терапевтический процесс направлен на помощь клиенту в принятии решений и совершении действий, которые соответствуют его ценностям и целям. Это включает в себя разработку планов действий, направленных на достижение желаемых результатов в соответствии с ценностями клиента.

Наконец, работа с ценностями в КПТ также включает в себя работу с когнитивными и поведенческими препятствиями, которые могут мешать клиенту жить в соответствии со его ценностями. Терапевт помогает клиенту выявить и изменить негативные схемы, а также разработать стратегии преодоления препятствий и преобразования своего поведения в соответствии с его ценностями.

Важно учитывать, что мотивация клиента в процессе терапии меняется. Как указывает Джудит Бек, изначально терапевт получает аванс доверия со стороны клиента, но ничто так не укрепляет рабочий альянс и мотивацию клиента, как достижение результатов терапии²⁰.

3.3. Работа с мотивацией клиента

Уровень мотивации клиента играет одну из ключевых ролей в успешности терапии. Преодоление устоявшихся паттернов мыш-

²⁰ См.: Бек Д. Когнитивно-поведенческая терапия. От основ к направлениям. СПб. : Питер, 2023. (Сер. «Мастера психологии»).

ления всегда связано со значительным стрессом, поэтому заинтересованность в результате и настойчивость клиента могут сыграть основную роль в успешном решении проблем.

Перечислим ключевые факторы, от которых зависит мотивация клиента:

1. Установление сотрудничества и эмпатия. Консультант стремится установить доверительные отношения с клиентом, выразить понимание его ситуации и эмоций. Это создает основу для сотрудничества и работы над изменениями.

2. Определение целей. Терапевт помогает клиенту четко определить свои цели и приоритеты в терапии, что позволяет последнему понять, чего он хочет достичь, и мотивирует его к действиям.

3. Развитие внутренней мотивации. Терапевт помогает клиенту осознать внутренние мотивы изменений, такие как личные ценности, желания и потребности. Это помогает клиенту обрести более глубокую мотивацию к изменениям.

4. Идентификация препятствий. Задача терапевта – помочь клиенту выявить препятствия и барьеры на пути к достижению его целей, т. е. разработать стратегии и ресурсы для их преодоления.

5. Поддержка и поощрение. Терапевт поддерживает клиента в его усилиях, поощряет его достижения и успехи, даже если они небольшие, помогает поддерживать мотивацию клиента в трудные моменты и стимулирует его к дальнейшим усилиям.

6. Постановка реалистичных ожиданий. Терапевт помогает клиенту поставить реалистичные и достижимые цели и ожидания. Это позволяет избежать разочарования и поддерживает клиента в его усилиях на протяжении всего процесса терапии.

Работа с мотивацией клиента является важным элементом успешной терапии в КПТ, поскольку мотивированный клиент более склонен к активному участию в процессе изменений и к достижению поставленных целей.

Для налаживания отношений с клиентом и прояснения его мотивации можно использовать следующие вопросы:

1. О чем вы думали и что чувствовали, когда готовились к нашей встрече?

2. Обсуждали ли вы с кем-либо такую встречу? Какие эмоции при этом испытывали?

3. Какие действия предпринимали для решения проблемы?

4. Что помогло справиться с проблемой? Что если вы снова попытаетесь это сделать?

5. Как я мог бы помочь вам в этом? Что или кто еще может вам помочь?

6. Какие ваши сильные стороны (личные качества, ресурсы) могут помочь вам справиться с данной проблемой?

7. Расскажите о трудных ситуациях, которые вы смогли решить в прошлом, как это получилось?

8. Какие вы видите особенности у данной проблемы? Какие сложные моменты, какие особенности, которые вы можете использовать для ее решения?

9. Что будет, если ситуация разрешится?

10. Ваше текущее поведение наносит кому-то вред и, если да, как? Важно ли это для вас?

11. Вредит ли данная ситуация вам лично? Важно ли это?

12. Если проблема не решится, то какой будет ваша жизнь через 1, 5, 10 лет?

13. А если решится?

14. Что для вас является ключевыми ценностями?

15. Чье мнение для вас наиболее важно?

16. Вспомните ситуации, в которых вы больше всего собой гордились?

Среди конкретных техник по работе с мотивацией и ценностями клиентов можно также отметить технику мотивационного интервью. С ней можно ознакомиться в прил. 1.3.

Темы для выступлений

1. Понятие ценностей в психологии.

2. Динамика мотивации клиента в психотерапии.

3. Специфика ценностей в КТ и РЭПТ.

Темы для обсуждения

1. Идентификация и актуализация ценностей клиента.
2. Как вы понимаете слова Роберта Лихи «самая ценная техника и самая главная интервенция – это ваши действия, направленные на то, чтобы нуждающийся в помощи человек почувствовал, что о нем заботятся и его слышат»²¹.

Разбор техники

Мотивационное интервью (прил. 1.3).

Информационные ресурсы для конспектирования

Рационально-эмотивно-поведенческая терапия. Гл. 1. «Альбер Эллис и философия РЭПТ» / Р. Диджузеппе, К. Дойл, У. Драйден, У. Бакс ; пер. с англ. Санкт-Петербург : Питер, 2021. С. 32–48.

Ярусси М. М. Интеграция мотивационного консультирования и когнитивно-поведенческой терапии в клинической практике. Гл. 2. «Мотивационное консультирование» / М. М. Ярусси, М. Мелани ; пер. с англ. Т. П. Предчук. Киев : «Диалектика», 2022. С. 39–58.

Добсон Д. Научно-обоснованная практика в когнитивно-поведенческой терапии. Гл. 4. «Выстраивание альянса и планирование как подготовка почвы для когнитивно-поведенческой терапии» / Д. Добсон, К. Добсон. Санкт-Петербург : Питер, 2021. С. 96–128.

Рационально-эмотивно-поведенческая терапия. Гл. 5. «Хорошее начало терапии» / Р. Диджузеппе, К. Дойл, У. Драйден, У. Бакс ; пер. с англ. Санкт-Петербург : Питер, 2021. С. 103–125.

Смагина Е. Н. Теоретический обзор концепций ценностей в психологии / Е. Н. Смагина // Вестник ЮУрГПУ. 2020. № 2 (155). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskiy-obzor-kontseptsiy-tsennostey-v-psihologii> (дата обращения: 01.05.2024).

Практические задания

Задание 1. Используя доступные интернет-источники, соберите подборку различных техник, которые помогут выявить ценности у клиента.

²¹ *Лихи Р.* Техники когнитивной психотерапии. СПб. : Питер, 2020. С. 32.

Эти техники могут включать в себя вопросники, упражнения, ролевые игры, направленные на обнаружение и раскрытие основных ценностей человека.

Пример упражнения

Клиенту предлагается вообразить себя на мероприятии, где каждый гость произносит тост в его честь. Ему задают вопрос: «Если бы вы могли услышать тост от кого угодно, кого бы вы выбрали и что бы вы хотели услышать в этом тосте?»

После того как клиент определится с выбором, ему предлагается поделиться своими мыслями с терапевтом. Он может описать, кого бы он выбрал и какую конкретную похвалу или признание хотел услышать от этого человека.

Данное упражнение может помочь клиенту лучше понять свои ценности, а также рассмотреть внутренние убеждения и ожидания от себя и других.

Задание 2. Проанализируйте список ценностей, представленный в прил. 1.4. Необходимо выделить ценности, которые для вас наиболее важны. К каждому из пунктов своего списка запишите варианты реализации ценностей в вашей жизни.

Задание 3. Выберите любую из ценностей в вашем списке и проанализируйте ее происхождение. Для этого вспомните самые яркие моменты, в которых эта ценность проявлялась. Опишите данное воспоминание: где это произошло, кто был рядом, какие чувства они испытывали.

Пример упражнения

Клиент вспомнил, что в детстве он проводил много времени со своим дедушкой, который был очень заботливым и внимательным к нему. Они часто гуляли в парке, дедушка учил его наблюдать за природой и ценить маленькие радости жизни. Этот опыт заставил клиента ценить семейные отношения, заботу о природе и уважение к старшим.

На основе данного воспоминания клиент осознал, что для него важны ценности семьи, уважения к окружающему миру и заботы о других. Эти ценности мотивируют его стремиться к гармонии в отношениях и заботиться об окружающей среде.

Тема 4

СТРУКТУРИРОВАНИЕ СЕССИЙ

Ключевые понятия

Оценочная, или диагностическая, сессия, терапевтическая сессия, структурирование, повестка, или аджента, *smart*-цели, анамнез, проблема, обратная связь.

4.1. Структурирование в КПТ

Структурирование является ключевым аспектом в КПТ по нескольким причинам:

- помогает установить ясные и понятные рамки для терапевтического процесса как для терапевта, так и для клиента;
- позволяет терапевту организовать работу с клиентом, определяя цели, методы и последовательность действий для достижения этих целей, что способствует обеспечению систематического и продуктивного продвижения в процессе терапии;
- способствует сосредоточению на конкретных проблемах и задачах, что повышает эффективность работы как терапевта, так и клиента;
- помогает разработать план действий для работы над проблемами клиента. Это включает в себя определение конкретных шагов, которые нужно предпринять, и временные рамки для их выполнения;
- позволяет создать четкий курс терапии с определенными этапами и достижениями, что обеспечивает клиенту чувство прогресса и движения вперед.

В КПТ структурирование включает в себя следующие основные элементы:

- установление целей – определение конкретных целей, которых клиент хочет достичь в рамках терапии, и разработка плана действий для их достижения;

– оценка и планирование – регулярный мониторинг текущего состояния и изменение планов в соответствии с полученными изменениями;

– структура сессий, которые четко структурируются, предложенная структура позволяет в дальнейшем клиенту стать терапевтом для самого себя, освоив структуру самопомощи;

– подведение итогов работы над конкретными проблемами или темами на каждой сессии и обсуждение планов на следующие периоды.

Таким образом, структурирование в терапевтической работе играет важную роль, обеспечивая систематическое продвижение в процессе терапии и помогая клиенту достигнуть поставленных целей.

4.2. Структура диагностической, или оценочной, сессии

Диагностическая сессия в КПТ направлена на оценку клиента, его проблем и целей, а также на установление начального контакта и планирование дальнейших шагов в терапевтическом процессе. Вот как может быть структурирована диагностическая сессия в КПТ:

1. Знакомство и установление контакта:

- терапевт приветствует клиента и представляется;
- создает атмосферу доверия и поддержки;
- обсуждает цели сессии: объясняет цели диагностической сессии и что клиент может ожидать от процесса.

2. Сбор анамнеза:

- история проблемы (клиент рассказывает о своих текущих проблемах, их длительности и о том, как они влияют на его жизнь);
- история жизни (клиент повествует о своем прошлом, семейной истории, прошлых терапевтических опытах и других факторах, которые могут быть связаны с его проблемами);
- оценка симптомов (терапевт проводит оценку текущих симптомов и их влияния на функционирование клиента).

3. Оценка ресурсов и сильных сторон:

- терапевт и клиент обсуждают ресурсы и сильные стороны клиента, которые могут помочь ему в процессе терапии;
- обсуждают ранее использованные стратегии решения аналогичных или похожих проблем и их эффективность.

4. Определение целей терапии:

- терапевт и клиент совместно определяют цели терапии на основе анализа проблем и потребностей клиента;
- цели формулируются SMART (конкретные – *specific*; измеримые – *measurable*; достижимые – *achievable*; важные – *relevant*; ограниченные во времени – *time-bound*).

5. Планирование дальнейших шагов:

- терапевт и клиент обсуждают возможные методы терапии и решают, какие методы будут наиболее подходящими для достижения целей клиента;
- разрабатывают первоначальный план терапии, включая частоту и продолжительность сессий, домашнее задание и ожидания от процесса терапии.

6. Заключение и обратная связь:

- терапевт подводит итоги диагностической сессии и обеспечивает обратную связь о том, что было обсуждено и какие планы разработаны;
- диагностическая сессия может завершиться обсуждением ожиданий клиента от терапии и ответами на его вопросы.

Данная структура помогает терапевту получить комплексное представление о клиенте и его проблемах, а также разработать индивидуализированный план терапии для дальнейшей работы. В прил. 1.5 приведены общая форма диагностической сессии и примерные вопросы для выяснения анамнеза.

В практике зарубежных коллег распространено утверждение, что диагностическую сессию может проводить не основной терапевт, а стажер или лаборант, который в дальнейшем передает информацию терапевту. Это дает возможность специалисту сосредоточиться на мотивированных клиентах, избежать трудоемкой работы по сбору общей информации.

Также популярным вариантом может быть заочное использование опросников и клинических шкал, чтобы составить общее мнение о контексте текущей ситуации клиента. Список клинических шкал приведен в прил. 1.6.

4.3. Структура первой терапевтической сессии

Первая терапевтическая сессия в КПТ важна для установления начального контакта с клиентом, определения проблем и целей терапии, а также создания основы для дальнейшей работы.

Структура первой терапевтической сессии немного отличается от последующих, так как не включает в себя проверку домашнего задания (его не было) и содержит ознакомление с когнитивной моделью. Первая сессия при этом сохраняет общую логику терапии, делает упор на психологическое образование клиента, ознакомление его с процессом терапии.

Джудит Бек рекомендует включить в первую терапевтическую сессию следующие элементы²²:

I. Вводная часть сессии:

- определение повестки дня;
- оценка настроения клиента;
- выяснение, что изменилось с оценочной сессии;
- обсуждение диагноза.

II. Основная часть сессии:

- выявление проблемы и определение цели;
- ознакомление клиента с когнитивной моделью;
- обсуждение проблемы.

III. Завершение сессии:

- подведение итогов или помощь клиенту в этом;
- формулировка домашнего задания или план активности;
- получение обратной связи.

В прил. 1.7 приведен чек-лист вводных слов и вопросов, которые можно использовать для структурирования сессий.

²² Бек Д. Когнитивно-поведенческая терапия. От основ к направлениям. 3-е изд. СПб. : Питер, 2024. С. 132. (Сер. «Когнитивно-поведенческая психотерапия»).

4.4. Структура второй и последующих сессий

Приведем общую структуру второй и последующих сессий в КПТ согласно Джудит Бек²³:

I. Вводная часть сессии:

- оценка настроения пациента;
- обсуждение повестки дня;
- выявление того, что изменилось с прошлой встречи;
- проверка домашнего задания или плана активации;
- составление повестки дня.

II. Основная часть сессии:

- проработка конкретной проблемы и в ее контексте разбор когнитивно-поведенческих навыков с пациентом;
- дополнительное совместное обсуждение формулировки домашнего задания;
- проработка второй проблемы.

III. Завершение сессии:

- подведение итогов или помощь пациенту в этом;
- уточнение домашнего задания;
- получение обратной связи.

В прил. 1.7 приведен чек-лист вводных слов и вопросов, которые можно использовать для структурирования сессий.

Темы для выступлений

1. Значение структурирования сессий в КПТ.
2. Специфические особенности первой терапевтической сессии.
3. Особенности проведения второй и последующих сессий.

Темы для обсуждения

1. Как преодолеть трудности, связанные со структурированием сессий?
2. Обсуждение структуры сессий с клиентом.

²³ См.: Бек Д. Когнитивно-поведенческая терапия. От основ к направлениям. С. 125.

Разбор техник

1. Структура сессии.
2. Бланк сессии (прил. 1.8).

Информационные ресурсы для конспектирования

Бек Д. Когнитивно-поведенческая терапия. От основ к направлениям. Гл. 11. «Трудности при структурировании сессий» / Д. Бек. 3-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2024. С. 256–276 (Сер. «Когнитивно-поведенческая психотерапия»).

Бек Д. Когнитивная терапия для сложных случаев: что делать, когда простые решения не работают. Гл. 8. «Сложности при структурировании сессии» / Д. Бек ; пер. с англ. Санкт-Петербург : Диалектика, 2020. С. 221–248.

Практические задания

Задание 1. Напишите список возможных автоматических мыслей терапевта, которые мешают ему структурировать сессию.

Примеры утверждений

«Я недостаточно квалифицирован, чтобы помочь этому клиенту»;
«Этот клиент слишком сложен, мне будет трудно найти подход к нему»;
«Мои предыдущие сессии не были успешными, поэтому у меня нет уверенности в своих способностях».

Распишите возможные аргументы против этих утверждений.

Задание 2. Ниже приведен список возражений клиента на возможные попытки терапевта структурировать сессию. Приведите возможные слова терапевта на каждую из этих ситуаций:

1. «Мне кажется, что вы перебиваете меня. Я хочу, чтобы вы сперва меня выслушали, а уже потом задавали вопросы».

2. «Я передумал, не хочу сейчас обсуждать этот вопрос. Ситуация с матерью кажется мне более важной. Давайте поменяем повестку».

3. «Я вижу, что вы меня торопите и понимаю, что время заканчивается. Могли бы мы немного задержаться, я чувствую, что мне это необходимо».

Задание 3. Напишите список аргументов «за» и «против» жесткого структурирования сессий.

Н а п р и м е р

Аргументы «за»:

Ясность – структурированные сессии помогают ясно определить цели и задачи каждой встречи, что способствует более эффективной работе и достижению результатов.

Аргументы «против»:

Отсутствие эмоциональной свободы – слишком жесткая структура может создать ощущение ограничения для клиента, лишая его возможности свободно выражать свои эмоции и мысли.

Тема 5

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ: ПОВЕСТКА, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Ключевые понятия

Обратная связь, повестка, или аджента, домашнее задание, план активации.

5.1. Повестка

Повестка в КПТ играет ключевую роль в определении целей и направлений терапевтической работы. Важность повестки в КПТ проявляется в нескольких аспектах:

1. **Определение целей терапии.** Повестка помогает как терапевту, так и клиенту четко определить, чего они хотят достичь в ходе терапии. Это позволяет сосредоточиться на конкретных проблемах или целях, которых клиент хочет достичь.

2. **Ориентация на решение проблем.** Повестка в КПТ ориентирована на решение конкретных проблем, или симптомов, с которыми сталкивается клиент. Она помогает выявить негативные мысли и убеждения и сконцентрироваться на тех, которые могут быть связаны с этими проблемами, разработать стратегии и методы их преодоления.

3. **Планирование терапевтических сессий.** Повестка помогает организовать терапевтические сессии таким образом, чтобы максимально эффективно использовать время клиента и терапевта. Она определяет, какие темы будут обсуждаться на каждой сессии, и какие задания или упражнения будут назначены для выполнения между сессиями.

4. **Оценка прогресса.** Повестка позволяет отслеживать прогресс клиента в терапии, поскольку цели и задачи терапии четко

определены. Это помогает клиенту видеть свои достижения и мотивирует его продолжать работу над собой.

Таким образом, повестка в КПТ играет важную роль в определении целей терапии, ориентации на решение проблем, планировании терапевтических сессий и оценке прогресса клиента. Она помогает сделать терапию более структурированной, направленной и эффективной для достижения желаемых результатов.

Типичные вопросы для определения повестки представлены в чек-листе вопросов для структурирования сессии в прил. 1.7.

5.2. Обратная связь

Обратная связь является базовым инструментом для оценки прогресса клиента, коррекции терапевтического процесса и улучшения результатов лечения. Важность обратной связи в КПТ проявляется в нескольких аспектах:

1. Оценка прогресса. Обратная связь помогает терапевту и клиенту оценить текущее состояние и прогресс в рамках терапии. Путем обсуждения достижений и проблем клиент и терапевт могут определить, насколько успешно и эффективно проходит процесс лечения.

2. Идентификация трудностей. Обратная связь позволяет выявить трудности, с которыми сталкивается клиент во время терапии, а также причины возникновения данных трудностей. Это помогает терапевту настроить процесс терапии таким образом, чтобы было максимально удобно и эффективно для клиента.

3. Адаптация методов. На основе обратной связи терапевт может адаптировать свои методы и подходы к работе с клиентом в соответствии с его потребностями и характеристиками. Это включает в себя изменение стратегий терапии, подбор новых техник или углубление в работе над конкретными проблемами.

4. Поддержка мотивации. Обратная связь помогает поддерживать мотивацию клиента к изменению, выявляя его успехи и достижения в процессе терапии. Положительная обратная связь может стать мощным стимулом для клиента продолжать работу над собой и своими проблемами.

5. Установление и развитие терапевтических отношений. Обратная связь способствует установлению и развитию доверительных отношений между терапевтом и клиентом. Открытость в обсуждении прогресса и проблем способствует созданию атмосферы взаимного доверия и понимания.

6. Повышение эффективности. Регулярная обратная связь позволяет корректировать терапевтический процесс в реальном времени, что помогает улучшить его эффективность и достичь лучших результатов для клиента.

Таким образом, обратная связь играет ценную и необходимую роль в КПТ, помогая терапевту и клиенту совместно работать над преодолением проблем и достижением поставленных целей терапии.

Приведем несколько примеров вопросов, которые терапевт может задать клиенту, чтобы получить обратную связь о процессе терапии и его эффективности:

1. Как вы чувствуете себя после нашей последней сессии?
2. Что было полезным или значимым для вас в нашей работе на этой неделе?
3. Есть ли что-то, что вы хотели бы обсудить или изменить в нашем подходе к терапии?
4. Какие изменения вы заметили в своих мыслях, чувствах или поведении с момента начала терапии?
5. Есть ли ситуации или проблемы, с которыми вы продолжаете испытывать трудности?
6. Какие уроки, или инсайты, вы получили в результате наших сессий?
7. Как вы оцениваете свой прогресс в работе над поставленными целями?
8. Что бы вы хотели изменить или улучшить в нашем взаимодействии или подходе к терапии?
9. Есть ли что-то, что мы не обсуждали или упустили в наших сессиях?
10. Какие рекомендации вы бы дали терапевту, чтобы сделать работу с ним более полезной для вас?

Данные вопросы помогают терапевту получить информацию о том, как клиент воспринимает процесс терапии, что для него значимо и полезно, а также помогают идентифицировать области, которые требуют дополнительного внимания или коррекции.

5.3. Домашнее задание, или план активности

Домашнее задание, или план активности, закрепляет достижения, сделанные на сессиях, и интегрирует их в повседневную жизнь клиента. Задачи, предложенные в домашнем задании, или плане активности, обычно связаны с темами, обсуждаемыми на сессиях, и направлены на достижение целей терапии.

Приведем несколько типичных задач, которые можно включить в домашнее задание, или план активности:

1. **Практика новых навыков.** Клиент пробует использовать стратегии, изученные на сессии, например, техники управления стрессом или техники изменения мышления.

2. **Ведение дневника.** Клиент может вести дневник своих мыслей, эмоций и поведения, чтобы отслеживать и оспаривать негативные убеждения.

3. **Постановка конкретных целей.** Клиент может определить конкретные цели на неделю или месяц и разработать план действий для их достижения.

4. **Активности по увеличению удовлетворения жизнью.** Клиент составляет список приятных дел и находит время и ресурсы для его реализации.

5. **Упражнения по релаксации.** Клиент получает инструкции по выполнению упражнений по релаксации, таких как глубокое дыхание, прогрессивная мышечная релаксация или медитация.

Важно, чтобы домашнее задание, или план активности, было адаптировано под индивидуальные потребности и возможности клиента, а также чтобы были выдвинуты реалистичные и достижимые цели. Также нужно обсудить с клиентом его отношение к выполнению заданий и их эффективность на последующих сессиях терапии. Необходимо помнить, что домашнее задание, которое не проверяется, обычно больше и не выполняется.

Темы для выступлений

1. Повестка и ее значение для работы с клиентом.
2. Трудности получения обратной связи от клиентов.
3. Типичные домашние задания в КПТ.

Тема для обсуждения

Как социализировать клиента в КПТ.

Разбор техник

Домашнее задание.

Информационные ресурсы для конспектирования

Ли Дэвид. Когнитивно-поведенческая терапия для врачебной практики : Практическое руководство. Гл. 5. «Навыки общения, необходимые в КПТ» / Дэвид Ли ; пер. с англ. Е. М. Савиновой. Киев : «Науковий Світ», 2023. С. 71–94.

Бек Д. Когнитивно-поведенческая терапия. От основ к направлениям. Гл. 8. «План действий» / Д. Бек. 3-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2024. С. 186–216. (Сер. «Когнитивно-поведенческая психотерапия»).

Практические задания

Задание 1. Сделайте подборку типичных домашних заданий (10 шт.) в КПТ в форме таблицы:

№ п/п	Задание	Цель
1	Ведение ежедневного дневника настроения	Отслеживание своих эмоций, мыслей и поведения для выявления паттернов и ассоциаций между ними
2	Проведение дыхательных упражнений и релаксации	Уменьшение физиологической активации и стресса путем освоения техник дыхания и релаксации
3	Ведение списка достижений и самооценка	Повышение самооценки и уверенности путем фиксации достижений и положительных моментов в жизни

Задание 2. Приведите примеры непродуктивной обратной связи в фильмах (5 шт.), составив следующую таблицу:

Откуда взят пример	Какой была обратная связь	В чем была проблема, как было лучше это сделать
Фильм «Дьявол носит Prada»	Начальник критикует работу ассистента за неправильно выбранную одежду и просит переделать работу	Критика была слишком суровой и неконструктивной. Лучше было бы выделить позитивные аспекты и предложить конкретные рекомендации по улучшению

Задание 3. Предложите пункты повестки дня для клиентов, которые описывают ситуации следующим образом.

С и т у а ц и я 1

Когда я встаю утром, всегда ощущаю какую-то тяжесть в груди, словно невидимый груз лежит на моем сердце. Мне кажется, что никто из моих коллег не ценит мою работу, что все, что я делаю, неважно и не имеет значения. В последнее время я начал часто терять концентрацию на работе, забываю о важных сроках и делах. Это меня очень беспокоит, потому что я всегда был организованным и дисциплинированным. Я также заметил, что начал избегать общения с коллегами, часто предпочитаю оставаться в одиночестве. Мне трудно объяснить, почему это происходит, но я постоянно чувствую себя нервным и напряженным, словно что-то гложет меня изнутри. Недавно у меня появились проблемы со сном, я часто просыпаюсь ночью и не могу заснуть снова, мои мысли крутятся в голове, не давая покоя. Все это начало влиять на мои отношения с семьей, я стал раздражительным и не могу найти общий язык даже с близкими. Я не уверен, что делать дальше, и чувствую, что нуждаюсь в помощи, чтобы разобраться в своих чувствах и преодолеть эти проблемы.

С и т у а ц и я 2

Последнее время я ощущаю, что моя жизнь как будто стоит на месте, словно я нахожусь в глухой ловушке без выхода. Я все чаще чувствую себя потерянным и одиноким, даже когда рядом много людей. Мои друзья заметили, что я стал избегать общества, все меньше выхожу из дома и предпочитаю оставаться в одиночестве. Сложно описать, что именно меня беспокоит, но чувства тоски и пустоты не покидают меня уже длительное время. Я также стал замечать, что мне трудно сосредоточиться на повсе-

дневных делах, мои мысли постоянно улетают далеко, а мозг словно зависает на месте. Это стало влиять на мою работу, я начал делать больше ошибок, моя производительность снижается, и я чувствую, что теряю контроль над собой. Я понимаю, что нужно что-то менять, но не знаю, с чего начать, и чувствую себя как будто застрявшим в темном тоннеле без света в конце.

Тема 6

ЭТАПЫ И УРОВНИ КОГНИТИВНОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

Ключевые понятия

Черно-белое мышление, катастрофизация, обесценивание или игнорирование позитивного опыта, эмоциональное обоснование, навешивание ярлыков, преувеличение или преуменьшение, мысленный фильтр, чтение мыслей, сверхобобщение, персонализация, долженствование, туннельное зрение.

6.1. Этапы работы с проблемой в КПТ

Работа с проблемой в КПТ требует внимательного анализа и действий для достижения целей терапии. В целом работа с проблемой подразделяется на три этапа.

Рассмотрим каждый из них подробнее.

1-й этап. Осознать, что мешает.

На данном этапе клиент и терапевт работают над осознанием и пониманием того, что мешает клиенту в достижении его целей или решении проблемы. Возможным вариантом формулировки проблемы является оценка конкретных жизненных ситуаций, в которых клиент «должен что-либо делать», или, наоборот, «не должен или не может что-то делать». Примером может быть: «Должен возвращаться и проверять, выключил ли утюг». Или: «Не могу выходить на улицу». Как видите, акцент делается на поведенческом проявлении проблемы.

На основе выделенной формы поведения терапевт и клиент проводят идентификацию автоматических мыслей, когнитивных искажений и глубинных убеждений, которые поддерживают проблемное поведение или эмоции. Также важно выявить внешние факторы или ситуации, которые влияют на проблему. В результате

этого этапа клиент становится более осведомленным о причинах своих трудностей и начинает понимать, что нужно изменить.

На данном этапе происходит ознакомление клиента с когнитивной моделью и обучение его интерпретации ситуаций и проблем с ее помощью. Также происходит работа по укреплению сотрудничества с клиентом, сбор и уточнение информации для концептуализации, социализация клиента в КПТ.

2-й этап. Найти альтернативу.

На данном этапе клиент и терапевт работают над поиском альтернативных мыслей, убеждений и стратегий, которые могут помочь клиенту решить проблему или достичь его целей. Это включает в себя разработку новых способов восприятия ситуации, пересмотра убеждений, исправления искаженных мыслей и выработки новых поведенческих реакций. Также важно учитывать внешние факторы и ресурсы, которые могут помочь клиенту в решении проблемы.

На этом этапе клиент обучается критическому подходу в оценке своих мыслей, оспариванию возникающих идей, выработке навыков диспута.

3-й этап. Отработать альтернативу.

На данном этапе клиент и терапевт работают над практическим применением альтернативных мыслей, убеждений и стратегий в реальной жизни. Это включает в себя проведение экспериментов, ролевых игр, тренировок и других практических упражнений, которые помогут клиенту применить новые подходы в повседневных ситуациях. В результате третьего этапа клиент приобретает новый опыт и навыки, которые помогают ему более эффективно решать свои проблемы и достигать поставленных целей. Таким образом, на этом этапе мы говорим о реализации поведенческой модификации.

Каждый из этапов является важным компонентом процесса терапии в КПТ и помогает клиенту систематически работать над своими проблемами и достигать желаемых изменений.

6.2. Выявление и оценка мыслей в КПТ

Выявление и оценка мыслей играют ключевую роль в КПТ, поскольку основная идея подхода заключается в том, что наши мысли о событиях влияют на наши эмоции и поведение. В основе эффективной работы лежит способность клиента научиться замечать и оспаривать автоматические мысли и способность психолога научить его этому.

Приведем некоторые ключевые шаги в выявлении и оценке мыслей в рамках КПТ:

1. Осознание мыслей: помочь клиенту осознать свои мысли в ответ на определенные события или ситуации. Это может быть достигнуто путем самонаблюдения или заполнения дневника мыслей.

2. Идентификация когнитивных искажений: терапевт помогает клиенту идентифицировать различные когнитивные искажения или ошибки мышления, которые могут приводить к негативным эмоциональным реакциям (более подробно в п. 5.3).

3. Оценка мыслей: после того как мысли идентифицированы, они оцениваются на достоверность и логичность. Терапевт может задавать вопросы клиенту, чтобы помочь ему критически оценить свои мысли и проверить их на основе доказательств.

4. Формулирование альтернативных мыслей: важной частью процесса оценки мыслей является разработка альтернативных и более адаптивных мыслей или интерпретаций событий.

5. Тестирование гипотез: выработка альтернативных гипотез предполагает выход в реальность. Часто клиент на данном этапе говорит о том, что он «умом понимает, но чувствам не прикажешь». Это означает, что необходимо перейти к проведению поведенческого эксперимента, проверке альтернативных гипотез.

Осуществление этого процесса в тесном сотрудничестве с клиентом помогает последнему понять, как именно его мысли влияют на эмоции и поведение, и разработать новые стратегии мышления, которые могут улучшить его психологическое благополучие.

6.3. Когнитивные искажения

Когнитивное искажение – это нормальное явление, встречающееся у большинства людей в той или иной степени. Оно выражено в форме неточностей мышления, восприятия или убеждений²⁴. Когнитивные искажения возникли эволюционно, по причине того, что позволяют сократить время на принятие решений и могут повысить эффективность деятельности за счет обобщений.

На текущий момент существует множество классификаций когнитивных искажений, мы приводим вариант, предложенный Джудит Бек²⁵.

Т а б л и ц а 2

Классификация когнитивных искажений

Когнитивное искажение	Описание	Пример
Черно-белое мышление	Ситуация оценивается либо как успех, либо как провал	«Она не заметила меня тогда, в зале, значит, у меня нет ни единого шанса»
Катастрофизация	Ситуация оценивается как развивающаяся по наихудшему сценарию	«Если она меня бросит, то я себе уже точно никого не найду»
Обесценивание или игнорирование позитивного опыта	Ситуация оценивается только негативно	«Она согласилась встретиться со мной, наверное, ей было совсем нечем заняться»
Эмоциональное обоснование	Ситуация оценивается негативно на основании эмоциональных ощущений, без рациональных оснований	«Она не опоздала, потому что не уважает меня»

²⁴ См.: *VandenBos G. R.* APA dictionary of psychology // American Psychological Association. 2007. С. 204.

²⁵ См.: *Бек Д.* Когнитивно-поведенческая терапия. От основ к направлениям. С. 207–208.

Когнитивное искажение	Описание	Пример
Навешивание ярлыков	Люди или сам клиент оцениваются на основе придуманного ярлыка	«Она – легкомысленная»
Преувеличение или преуменьшение	Ситуация и люди оцениваются либо как очень позитивные, либо как очень негативные	«Она не улыбнулась мне, значит, разлюбила»
Мысленный фильтр	Ситуация и люди воспринимаются через фильтр, отсекающий аспекты, противоречащие сложившемуся взгляду	«Она ненавидит меня, раз сразу не ответила на мое сообщение»
Чтение мыслей	Люди оцениваются на основе мыслей, которые им приписываются	«Она думает, что я неудачник»
Сверхообобщение	Ситуация и люди оцениваются по единичному опыту	«У меня с ней не получилось, я останусь один навсегда»
Персонализация	Ситуация и люди настроены «лично» против вас	«Она лично настроена против меня, я сразу ей не понравился»
Долженствование	Вы, другие люди, сам мир обязаны быть именно такими, как вам кажется	«Она должна была меня поддержать»
Туннельное зрение	Ситуация или люди воспринимаются исключительно негативно	«Она постоянно ошибается»

Когнитивные искажения являются для человека типичными ошибками оценки себя, ситуаций и окружающих. Исследование когнитивных искажений клиента позволяет понять его мыслительные процессы, реакции на различные ситуации и восприятие

окружающего мира. В результате такого исследования терапевт может выявить те шаблоны мышления, которые могут приводить к негативным эмоциям и поведению, что дает возможность понять причины дистресса и определить направления для работы.

Целесообразно обсудить с клиентом его когнитивные искажения, научить его самостоятельно оценивать их проявления, учить его их оспаривать с помощью таких техник, как «адаптивный ответ» (см. прил. 1.9).

6.4. Работа с мыслями (когнитивная реструктуризация)

Когнитивная реструктуризация – это техника, направленная на изменение негативных или деструктивных мыслей и установок, приводящих к нежелательным эмоциональным реакциям и поведенческим паттернам.

Процесс когнитивной реструктуризации, т. е. отслеживания, оценки и изменения образа мышления, включает следующие шаги:

1. Идентификация негативных мыслей. Заключается в помощи клиенту распознать негативные мысли или убеждения, которые вызывают дискомфорт или деструктивные реакции. Это может включать в себя запись мыслей в дневнике или обсуждение их в сессии терапии.

2. Анализ когнитивных искажений. Терапевт помогает клиенту идентифицировать различные когнитивные искажения, или ошибки мышления, которые могут приводить к негативным мыслям.

3. Оценка мыслей. После того как негативные мысли и искажения определены, они оцениваются на достоверность и логичность. Терапевт может помочь клиенту задать себе вопросы для критической оценки своих мыслей и проверки их на основе доказательств.

4. Выработка альтернативных мыслей. На данном этапе терапевт помогает клиенту разработать новые, более адаптивные мысли или интерпретации событий, которые могут заменить негативные или деструктивные мысли. Это включает в себя рассмотрение различных способов толкования ситуаций, которые могут быть более здоровыми и реалистичными.

5. Практика новых мыслей. Клиенту предлагается проводить практические упражнения или эксперименты, чтобы протестировать и укрепить новые альтернативные мысли. Это может включать в себя визуализацию, ролевые игры или реальные ситуации из жизни.

6. Отслеживание результатов. После того как клиент начнет применять новые мысли в своей жизни, важно периодически пересматривать результаты и корректировать при необходимости подход к ним. Это помогает убедиться, что новые мысли и установки работают эффективно и способствуют улучшению психологического благополучия.

Когнитивная реструктуризация – собирательное название для когнитивных техник, направленных на изменение образа мышления клиента.

6.5. Работа с автоматическими мыслями

Когниции клиента располагаются на нескольких уровнях (более подробно в п. 1.4). В КПТ работа ведется на всех уровнях, среди которых уровень автоматических мыслей является наиболее доступным для осознания и гибким для изменения.

Автоматические мысли – это произвольные, оценочные и часто негативные мысли, которые возникают в ответ на определенные ситуации или события. В РЭПТ для определения таких мыслей используется термин «горячие» или вызывающие эмоциональные реакции.

В практике работы с автоматическими мыслями обычно возникает сложность, связанная с тем, что человек может не замечать их. Зачастую клиент думает о том, что мыслей как будто бы нет, и на вопрос, «о чем вы подумали в этой ситуации», отвечает, что ни о чем не думал. На самом деле, тут мы имеем дело со скрытой интерпретацией происходящего, что содержит в себе оценку в виде мысли или образа, вызывающего эмоцию.

Умение замечать автоматические мысли не является врожденным, оно развивается с практикой. Для его формирования важно

успешное понимание клиентом когнитивной модели, помощь консультанта во время первых попыток идентификации мыслей и регулярная практика. Это может включать в себя использование дневника мыслей или самонаблюдение для записи негативных мыслей, которые возникают в определенных ситуациях.

Важно отметить, что автоматические мысли могут быть представлены не только в форме внутренней речи, но и в форме образов. Так, например, клиент в ситуации, когда его негативно оценили, может представить себе образ будущего, без поддержки близких, и этот образ вызывает у него грусть, а не конкретные слова, которые он мысленно произнес во внутренней речи.

Один из трудных моментов терапии – разделение автоматических мыслей и эмоций у клиента. Типичной становится форма, когда клиент, отвечая на вопрос о мыслях, говорит о своих переживаниях и наоборот. Обучение тому, как эти мысли различать – одна из ключевых на первых этапах работы. Так, например, одним из основных отличий является то, что мысли состоят из нескольких слов, в то время как эмоции, чаще всего, из одного слова.

Задача выделения автоматической мысли состоит в том, чтобы понять, какие конкретные идеи и интерпретации вызывают негативные переживания, насколько они соотносятся с реальным положением дел. Для этого важна их точная идентификация, в частности, надо их сформулировать в понятной для клиента утвердительной форме, поскольку зачастую клиент может их сформулировать в форме вопроса или междометия.

Работа с выделенной ключевой автоматической мыслью происходит посредством диспутирования, в рамках которого терапевт совместно с клиентом разрабатывают оптимальную стратегию оспаривания автоматических мыслей, которые не проходят проверку на функциональность, логику и прагматизм.

6.6. Работа с промежуточными убеждениями

Работа с промежуточными убеждениями важна, особенно когда речь идет о долгосрочных изменениях в мышлении и поведении клиента. Промежуточные убеждения менее осознаваемы клиен-

тами и гораздо более устойчивы к изменениям по сравнению с автоматическими мыслями. Промежуточные убеждения представляют собой более общие и глубокие представления о себе, других и мире, которые могут влиять на то, как человек воспринимает себя и окружающий мир, а также на его поведение.

Для идентификации промежуточных убеждений существует целый ряд техник, но среди них основной является «Падающая стрела». Технология ее проведения представлена в прил. 1.2.

По сути, сходные промежуточные убеждения могут быть сформулированы для клиента по-разному:

- определение – «у хороших матерей дети хорошо учатся»;
- долженствование – «я должна быть хорошей матерью», «мой ребенок должен хорошо учиться»;
- предположение – «если мой ребенок учится плохо, то я плохая мать».

Решение задачи определения промежуточных убеждений проще начинать с выделения определений, чтобы понять систему представлений клиента. Для проведения диспутирования более эффективно выделить предположения, которые потом можно проверить на практике.

Приведем некоторые методы работы с промежуточными убеждениями в рамках КПТ:

1. Анализ влияния промежуточных убеждений. Терапевт помогает клиенту понять, как именно его промежуточные убеждения влияют на его мышление, эмоции и поведение. Это может включать в себя обсуждение конкретных примеров из прошлого и настоящего, когда промежуточные убеждения влияли на принятие решений и реакции на события.

2. Оценка промежуточных убеждений. Терапевт помогает клиенту оценить достоверность и логичность его промежуточных убеждений. Это может включать в себя задание вопросов для критической оценки убеждений и проверки их на основе доказательств.

3. Развитие альтернативных убеждений. После того как промежуточные убеждения проанализированы, клиент и терапевт работают вместе над разработкой альтернативных и более здоровых

убеждений или систем ценностей. Это может помочь клиенту изменить свой способ мышления и взглянуть на себя и мир иначе. Примером такой работы обычно служит техника замены императивного иррационального убеждения эффективным новым убеждением, представленная в прил. 1.10.

4. Практика новых убеждений. Клиенту предлагается провести практические упражнения для укрепления новых, более адаптивных убеждений.

6.7. Работа с глубинными убеждениями

Данная работа является одной из наиболее длительных и трудоемких. Глубинные убеждения представляют собой базовые убеждения по поводу личности и ценности клиента.

Для идентификации глубинных убеждений необходима работа по составлению когнитивной концептуализации, для чего используется оценка нескольких конкретных ситуаций проявления проблемы и техника «Падающая стрела» для определения значения автоматических мыслей в данных ситуациях.

Для изменения глубинных убеждений используется ряд техник:

1. ***Создание нового глубинного убеждения.*** Эта техника направлена на разработку новых, более адаптивных убеждений, которые могут заменить негативные или неадаптивные убеждения. В процессе терапии клиент и терапевт работают над идентификацией и анализом существующих убеждений, а затем совместно разрабатывают новые убеждения, которые поддерживают здоровое функционирование и благополучие клиента.

2. ***Действовать «как будто».*** Данная техника предполагает проведение поведенческих экспериментов, в ходе которых клиент пробует новые способы мышления и поведения, даже если он пока не уверен в их эффективности. Путем действий «как будто» клиент может опробовать альтернативные стратегии и убедиться в их полезности на практике.

3. ***Анализ преимуществ и недостатков.*** Техника включает в себя анализ плюсов и минусов различных стратегий, мыслей или поведенческих моделей. Клиент и терапевт совместно рассмат-

ривают потенциальные выгоды и ограничения каждого варианта, что помогает клиенту принять более информированное решение о том, как действовать.

4. Рационально-эмотивные ролевые игры. Эта техника предполагает создание ролевых ситуаций, в которых клиент и терапевт могут моделировать и анализировать поведение и реакции в различных сценариях. Путем игры в роли разных персонажей клиент может получить новые перспективы и понимание собственных эмоций и поведения.

5. Поведенческие эксперименты. Данная техника включает в себя систематическое планирование и проведение экспериментов в реальной жизни, направленных на проверку гипотез и изменение негативных убеждений или поведенческих шаблонов. Путем наблюдения за результатами экспериментов клиент может получить новый опыт и убедиться в эффективности альтернативных подходов.

6. Когнитивный континуум. Техника используется для исследования и изменения крайних убеждений или мыслительных шаблонов клиента путем поиска промежуточных, более уравновешенных позиций. Клиент учится рассматривать ситуации или проблемы с разных точек зрения и находить более гибкие и адаптивные способы мышления.

7. Самораскрытие терапевта. Подобная техника предполагает открытое обсуждение терапевтом своих личных опытов и убеждений с целью установления более доверительного отношения и создания эмпатии с клиентом. Через такую открытость и прозрачность клиент лучше понимает себя и свои проблемы.

8. Копинг-карточки реструктурирования ранних воспоминаний. Техника включает в себя создание карточек с адаптивными утверждениями и переоценкой ранних негативных воспоминаний. Путем систематического использования карточек клиент учится переоценивать и переформулировать свои убеждения о прошлых событиях и ситуациях, что помогает снизить негативные эмоции и улучшить самоощущение.

Эти и другие техники модификации глубинных убеждений позволяют клиенту прийти к стойким изменениям в мышлении и поведении.

Темы для выступлений

1. Идентификация автоматических мыслей клиента.
2. Составление копинг-карточек как метод оспаривания автоматических мыслей.

Темы для обсуждения

1. Признаки определения ключевой автоматической мысли клиента.
2. От чего зависит углубленность в уровни когнитивных клиент?
3. Как согласовать с клиентом глубинное убеждение?

Разбор техник

1. Протокол ЭМУУМЭ (дисфункциональные эмоции, мысли, убеждения и функциональные убеждения, мысли, эмоции – прил. 1.11).
2. Протокол адаптивный ответ (прил. 1.9).

Информационные ресурсы для конспектирования

Бек Д. Когнитивно-поведенческая терапия. От основ к направлениям. Гл. 12. «Выявление автоматических мыслей» / Д. Бек. 3-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2024. С. 277–295. (Сер. «Когнитивно-поведенческая психотерапия»).

Рационально-эмотивно-поведенческая терапия. Гл. 3 «Иррациональное и рациональное убеждения» / Р. Диджузеппе, К. Дойл, У. Драйден, У. Бакс. Санкт-Петербург : Питер, 2021. С. 78–94.

Оверхолзер Джеймс. Метод Сократа в психотерапии. Гл. 8. «Управляемое открытие» / Джеймс Оверхолзер ; пер. с англ., под ред. Т. А. Исмаил. Киев : «Диалектика», 2022. С. 123–142.

Лихи Р. Техники когнитивной психотерапии. Гл. 5. «Логические ошибки и искажения в обработке информации» (любые три техники) / Р. Лихи. Санкт-Петербург : Питер, 2020. С. 125–164.

Практические задания

Задание 1. Согласно классификации когнитивных искажений в п. 5.3 выпишите фразы, соответствующие им. Для этого определите несколько типичных автоматических мыслей, характерных для героев мультфильма о Винни-Пухе.

П р и м е р

В мультфильме «Винни-Пух» можно увидеть пример когнитивного искажения в персонаже Иа-Иа. Так, когда он говорит: «Что если это случится, что если то случится?», то это пример катастрофизации, когда события могут быть преувеличены и представлены в самом негативном свете без реальных оснований для этого.

Задание 2. Приведите список из пяти литературных героев и их типичные долженствования, не менее трех для каждого.

П р и м е р

Родион Раскольников (из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание»):

1. Совершить идеальное преступление и доказать свою теорию о «непреступном».
2. Избежать наказания за убийство.
3. Понять и принять свою вину перед законом и собственной совестью.

Задание 3. Составьте список новых глубинных убеждений для каждого из трех типов негативных глубинных убеждений, заполните таблицу:

Негативное глубинное убеждение	Варианты новых глубинных убеждений
Я – беспомощный	1. 2. 3.
Я – непривлекательный или ненужный	1. 2. 3.
Я – никчемный	1. 2. 3.

Тема 7

ДИСПУТ

Ключевые понятия

Диспут, логический диспут, функциональный диспут, прагматический диспут, протокол ЭМУУМЭ, функциональное убеждение, дисфункциональное убеждение, сократовский диалог, или направляемое открытие.

7.1. Понятие диспутирования

Диспутирование – это процесс анализа и изменения негативных или неадаптивных убеждений и мыслей клиента. Метод используется для помощи клиенту в переоценке и переформулировке его мыслей, которые могут приводить к деструктивным эмоциям и поведению.

Диспут начинается с идентификации негативных мыслей или убеждений клиента, которые вызывают негативные переживания. Затем терапевт помогает клиенту провести критический анализ этих мыслей, выявить логические ошибки, искажения и недостоверности в них.

После этого следует этап диспута, в ходе которого терапевт и клиент совместно анализируют негативные мысли и ищут доказательства и контраргументы, которые могли бы ослабить их влияние. Важно подчеркнуть, что диспут в КПТ основывается на эмпирических данных и логических аргументах, а не на простом отрицании или игнорировании убеждений клиента.

Завершающий этап диспута включает в себя разработку более адаптивных и позитивных убеждений или мыслей, которые помогут клиенту лучше справляться с жизненными ситуациями и достигать своих целей. Этот процесс может потребовать времени и усилий, но он обычно приводит к уменьшению эмоционального дискомфорта и улучшению психологического благополучия клиента.

В зависимости от обсуждаемых аргументов терапевт ориентируется на следующие: логика, функциональность и прагматизм в работе с мыслями клиента.

7.2. Логический диспут

В данном диспуте терапевт помогает проверить логическую обоснованность и правильность мыслей клиента. В совместной работе анализируются логические ошибки, противоречия или необоснованные предположения в негативных убеждениях. Это может включать в себя использование различных логических приемов, таких как метод «вопрос – ответ», идентификацию логических искажений (например, черно-белое мышление) и демонстрацию альтернативных точек зрения.

Логику часто определяют как науку о правильном мышлении, предполагая достижение некой истины. В КПТ важно помнить, что речь идет не о достижении истины, а о помощи клиенту²⁶, что скорее говорит не о необходимости сделать его мышление абсолютно безошибочным, а лишь более приближенным к реальности.

Примеры вопросов, которые могут быть использованы в логическом диспуте:

1. «Каковы доказательства или факты, подтверждающие ваше убеждение?»
2. «Существует ли альтернативное объяснение или интерпретация ситуации?»
3. «Как бы вы оценили вероятность того, что ваше предположение является истинным?»
4. «Какие доказательства противоречат вашему убеждению или могут подвергнуть его сомнению?»
5. «Какие могут быть последствия, если ваше убеждение неверно или несостоятельно?»
6. «Можете ли вы рассмотреть ситуацию с другой точки зрения или через призму опыта других людей?»

²⁶ См.: *Граница А., Ковпак Д., Зепсен А.* Тактики диспута: когнитивно-поведенческий подход. СПб. : Питер, 2024. С. 7. (Сер. «Когнитивно-поведенческая психотерапия»).

7. «Каковы логические шаги, которые вы использовали, чтобы прийти к вашему убеждению? Могут ли они считаться полными и надежными?»

8. «Есть ли доказательства того, что ваше убеждение было правильным в других аналогичных ситуациях?»

9. «Могло ли ваше эмоциональное состояние или предвзятость повлиять на формирование вашего убеждения?»

10. «Какие альтернативные выводы или интерпретации могут быть сделаны на основе имеющихся данных или фактов?»

Подобного рода вопросы помогают клиенту более критически рассмотреть свои мысли и убеждения, а также оценить их логическую обоснованность и достоверность.

7.3. Функциональный диспут

Данный диспут используется с целью помощи клиенту проверить его убеждения путем исследования и оценки их практической полезности и функциональности. Диспут сосредоточен на том, какие последствия имеют убеждения и мысли для поведения и эмоционального состояния клиента.

В ходе диспута терапевт помогает клиенту проанализировать, какие функции выполняют его убеждения в личной жизни. Это может включать в себя выявление того, какие преимущества или защитные механизмы обеспечиваются через поддержание данных убеждений, а также какие негативные последствия они могут иметь для благополучия клиента.

Примеры вопросов

1. «Какие преимущества или защитные механизмы обеспечивает вам это убеждение?»

2. «Как оно помогает вам справляться с трудностями или вызовами в вашей жизни?»

3. «Какие конкретные последствия имеет для вас поддержание этого убеждения?»

4. «Как данное убеждение влияет на ваше поведение и реакции в различных ситуациях?»

5. «Можете ли вы рассмотреть другие способы реагирования на те же ситуации или проблемы?»

6. «Как бы вы оценили полезность данного убеждения в долгосрочной перспективе?»

7. «Есть ли доказательства того, что это убеждение помогает вам достигать ваших целей или желаемых результатов?»

8. «Какие негативные последствия может иметь поддержание этого убеждения для вашего эмоционального благополучия или межличностных отношений?»

9. «Можете ли вы представить себе ситуации, в которых данное убеждение может быть не таким полезным или даже вредным?»

10. «Как вы можете приспособить это убеждение таким образом, чтобы оно лучше соответствовало вашим целям и потребностям?»

Данные вопросы позволяют разобраться с функциями сформированных у клиента убеждений.

7.4. Прагматический диспут

Данный диспут ориентирован на анализ и изменение негативных убеждений и мыслей клиента путем рассмотрения их полезности и эффективности в решении конкретных проблем или достижении целей. В этом типе диспута терапевт сосредоточен на том, какую выгоду имеют убеждения и мысли для клиента в контексте его конкретной жизненной ситуации. Обсуждение строится в контексте целей и потребностей клиента.

Примеры вопросов

1. «Какие конкретные результаты вы ожидаете от поддержания этого убеждения или мысли?»

2. «Как данное убеждение влияет на ваше поведение в ситуациях, когда вы сталкиваетесь с трудностями или проблемами?»

3. «Каковы преимущества и недостатки использования этого убеждения в решении вашей текущей проблемы?»

4. «Сможете ли вы представить себе альтернативные способы мышления, которые могли бы привести к другим результатам?»

5. «Насколько эффективным данное убеждение было в прошлом в схожих ситуациях?»

6. «Как бы вы оценили полезность этого убеждения в долгосрочной перспективе?»

7. «Какие последствия могут возникнуть, если вы продолжите придерживаться данного убеждения в будущем?»

8. «Какие доказательства или опыт вы можете использовать, чтобы поддержать или опровергнуть данное убеждение?»

9. «Какие шаги вы можете предпринять для проверки или исследования эффективности этого убеждения?»

10. «Какие изменения в вашем мышлении могли бы помочь вам достичь желаемых результатов или решить вашу проблему?»

Вопросы сосредоточены на обсуждении тем выгод и достижений для клиента.

7.5. Стили диспутирования

Наряду с тактикой диспута (то, на что мы направляем внимание при диспутировании) можно рассмотреть вопрос о стиле диспута (как мы это делаем). Так, каждый клиент требует индивидуального подхода, важно, чтобы терапевт умел использовать разнообразные стили диспута. Ниже, в табл. 3, представлен их перечень с кратким описанием.

Т а б л и ц а 3

Стили диспута

Стиль	Описание	Примеры фраз терапевта
Сократовский	Активное ведение диалога с клиентом с помощью открытых вопросов. В основе лежат знания и опыт клиента, происходит опора на его самопознание	«Что бы произошло, если бы вы рассмотрели эту ситуацию с другой точки зрения?» «Как вы думаете, какие альтернативные объяснения могут быть для вашего опыта?»
Дидактический	Терапевт передает клиенту информацию и знания, используя объяснения, при-	«Позвольте мне рассказать вам о том, как работает этот механизм.»

Стиль	Описание	Примеры фраз терапевта
	меры и образовательные материалы. Данный подход эффективен для разъяснения концепции КПТ и объяснения принципов работы мышления	«Важно понимать, что эмоции могут быть обусловлены нашими мыслями. Я хотел бы показать вам, как это происходит»
Метафорический	Для иллюстрации сложных концепций и понятий. Терапевт может использовать аллегории и метафоры, чтобы помочь клиенту увидеть свои проблемы и ситуации с новой перспективы, что способствует изменению убеждений и поведения	«Ваша жизнь похожа на строительство дома, и сейчас мы можем начать возводить более крепкий фундамент». «Вы можете представить, что ваше состояние сейчас подобно темной пещере, но мы можем найти свет, чтобы осветить ее»
Юмористический	Может помочь создать атмосферу доверия и комфорта в процессе терапии. Юмор снизит напряжение, поможет пациенту расслабиться и способствует более открытому общению	«Ваша мыслительное искажение напоминает мне одну историю. Давайте рассмотрим ее смешную сторону»

Использование разных стилей позволяет адаптировать подход к индивидуальным потребностям каждого клиента. Например, сократовский стиль способствует развитию самопознания и осознанию аспектов проблемы через вопросы и рефлексии. Дидактический стиль полезен при передаче новых знаний и навыков клиенту, а метафорический подход может помочь выразить и понять сложные концепции с помощью образов и аналогий. Кроме того, использование юмористического стиля смягчит обстановку и установит доверительные отношения между терапевтом и клиентом, способствуя более эффективной работе над проблемой.

При этом важно учитывать, что использование каждого стиля дает определенные преимущества, а также несет риски. Например, давая рекомендации в дидактическом стиле, вы рискуете оказаться в роли «эксперта», берущего на себя ответственность²⁷.

7.6. Сократовский диалог

С точки зрения индивидуализации работы, опоры на самопознание и закрепление появляющихся изменений предпочтительным стилем диспутирования можно назвать сократовский. Он лучше всего обеспечивает активное участие клиента, помогая ему осознать свои мысли и поведенческие паттерны. Данный стиль также развивает критическое мышление и способствует установлению доверительных отношений между терапевтом и клиентом.

Сократовский диалог связан с именем древнегреческого философа Сократа, жившего в V в. до н. э. Идея сократовского диалога происходит из его метода философского исследования, который предполагал поиск истины через вопросы и диалог, а не через догматическое учение.

Сократ проводил свои философские беседы на афинских улицах, общаясь с людьми различных социальных слоев. Он ставил перед собой задачу не просто донести свое мнение, а помочь собеседнику самостоятельно прийти к пониманию истины путем активного обсуждения и анализа. Этот метод позже стал известен как сократовский диалог и получил широкое применение в образовании и психотерапии. Другим популярным названием, отражающим его сущность, является «направляемое открытие».

В основе использования сократовского диалога лежат следующие принципы:

1. Клиент обладает достаточными знаниями для ответа на вопрос, но вопросы терапевта должны ориентироваться на уровень его знаний, т. е. быть в «зоне ближайшего развития» клиента. Это зна-

²⁷ См.: Рационально-эмотивно-поведенческая терапия / Р. Диджузеппе, К. Дойл, У. Драйден, У. Бакс. С. 356.

чит, что клиент способен ответить на вопросы терапевта в совместном диалоге.

2. Терапевт направляет внимание на отдельные аспекты проблемы, выходящие за пределы внимания клиента. При этом он не настаивает на той или иной интерпретации клиента.

3. Переключение между частным и общим уровнями жизни клиента, т. е. вопросы направляются на перемещение внимания от конкретных примеров к более абстрактным выводам и обратно.

4. В завершение диалога клиент самостоятельно формулирует альтернативное понимание проблемы или способов ее решения. Данный этап является ключевым для достижения инсайтов и решения проблемы.

Одну из популярных реализаций идеи «направляемого открытия» предложила Кристин Падески, разработавшая четырехступенчатую модель сократовского диалога²⁸. Модель включает:

1. Опрашивание;
2. Активное слушание;
3. Обобщение;
4. Аналитические вопросы.

В основе схемы лежит идея, что метод не предполагает никакой конфронтации, а только совместное исследование и поиск новых перспектив развития клиента.

5. В современной психотерапии сократовский диалог не раз становился предметом изучения²⁹. В прил. 1.13 приведена техника сократовского вопрошания С. Уолтмана и Р. Кодда III. Примеры вопросов при обсуждении автоматических мыслей и ключевых идей клиента можно посмотреть в прил. 1.11.

²⁸ См.: *Гринбергер Д., Падески К.* Разум рулит настроением: как изменить мысли и справиться с депрессией. СПб. : Питер, 2021. С. 82. (Сер. «Когнитивно-поведенческая психотерапия»).

²⁹ См.: *Оверхолзер Дж.* Метод Сократа в психотерапии / пер. с англ., под ред. Т. А. Исмаил. Киев : «Диалектика», 2022; Сократовские вопросы в психотерапии и консультировании / С. Уолтман, Р. Кодд, Л. Макфарр, Б. Мур. СПб. : Питер, 2023. (Сер. «Когнитивно-поведенческая психотерапия»).

Темы для выступлений

1. Особенности логического диспута.
2. Особенности функционального диспута.
3. Особенности прагматического диспута.
4. Сократовский диалог: история, особенности метода.
5. Трудности и ловушки сократовского диалога.

Темы для обсуждения

1. Выбор стратегии и стиля диспута.
2. Какие трудности могут быть при использовании «направляемого открытия» и как с ними работать?
3. Достоинства и недостатки техники «сократовский диалог».

Разбор техник

1. Техника замены императивного иррационального убеждения эффективным новым убеждением.
2. Сократовский диалог.
3. Техника сократовского вопрошания С. Уолтмана и Р. Кодда III.

Информационные ресурсы для конспектирования

Рационально-эмотивно-поведенческая терапия. Гл. 10. «Стратегии когнитивных изменений» / Р. Диджузеппе, К. Дойл, У. Драйден, У. Бакс. Санкт-Петербург : Питер, 2021. С. 221–257.

Бек Д. Когнитивно-поведенческая терапия. От основ к направлениям. Гл. 17. «Работа с убеждениями клиента» / Д. Бек. 3-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2024. С. 363–389. (Сер. «Когнитивно-поведенческая психотерапия»).

Зайкина Д. С. Метод Сократа в практике когнитивно-поведенческой психотерапии / Д. С. Зайкина // *Abyss* (Вопросы философии, политологии и социальной антропологии). 2020. № 3 (13). С. 54–60.

Лихи Р. Техники когнитивной психотерапии. Гл. 10. «Выявление и модификация схем» (любые три техники) / Р. Лихи. Санкт-Петербург : Питер, 2020. С. 467.

Практические задания

Задание 1. Составьте список аргументов «за» и «против» по следующим позициям:

- массовое использование антидепрессантов;
- популяризация направлений психологии, не имеющих подтвержденных научных доказательств эффективности;
- онлайн-консультирование;
- искусственный интеллект в консультировании и психотерапии.

Задание 2. В приведенных примерах выделите логические ошибки:

- «Если люди не могут найти работу, значит, им просто не хочется работать. Ведь сейчас предложений работы много, просто ленивые не хотят прилагать усилия для трудоустройства»;
- «Если человек слушает грустную музыку, значит, он грустный. Поэтому, чтобы быть счастливым, нужно слушать только веселую музыку»;
- «Все, кто проводит много времени в социальных сетях, страдают от депрессии. Поэтому, чтобы быть счастливым, нужно полностью избегать использования социальных сетей».

Тема 8

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ: ЭКСПОЗИЦИЯ И АКТИВАЦИЯ

Ключевые понятия

Экспозиция, рефлексия, охранительное поведение, подкрепляющий цикл, протокол экспозиции, поведенческая активация, поведенческая интервенция, поведенческий эксперимент, техники дыхательной релаксации, техники саморегуляции, нервно-мышечная релаксация, тренинг навыков, ассертивность, повышение уровня активности.

8.1. Работа с поведением (модификация поведения)

В КПТ, как понятно из названия термина, большое внимание уделяется поведенческому аспекту. Поведение не просто является следствием мыслей, но также и подкрепляет их, образуя циклы активности клиента.

Так, например, человек со страхом открытого пространства (агорафобией) не выходит на улицу, будучи уверенным, что там с ним что-то произойдет. Оставшись дома, он приходит к выводу, что смог спастись лишь потому, что остался дома (рис. 5).

Конкретный акт (остаюсь дома) выступил формой охранительного поведения, которое подкрепляет мысль. Вероятность того, что в следующий раз данный человек снова примет такое решение, повышается. Наши действия оказывают значительное влияние на наше психологическое состояние и общее благополучие. В КПТ используются различные методы для модификации или изменения поведения клиента:

1. Установка конкретных целей, когда терапевт и клиент совместно принимают конкретные и измеримые цели, касающиеся



Рис. 5. Иллюстрация поведенческого цикла

желаемых изменений в поведении. Это может быть, например, увеличение физической активности, улучшение навыков общения или уменьшение прокрастинации (откладывания дел).

2. Развитие плана действий, когда совместно с терапевтом клиент разрабатывает план действий, который поможет ему достичь поставленных целей. Данный план включает в себя конкретные шаги, которые нужно предпринять для изменения нежелательных поведенческих паттернов.

3. Постепенное приближение к тревожащему стимулу. Это означает, что клиент постепенно вводит в свою жизнь новые поведенческие шаги, начиная с более легких и постепенно переходя к более сложным.

4. Позитивное подкрепление, когда клиент получает поощрение или вознаграждение за желаемое поведение. Это может быть что-то приятное или мотивирующее, что помогает укрепить новые поведенческие привычки.

5. Изменение окружения, что может включать в себя изменение рабочих привычек, реорганизацию пространства или установление новых социальных связей.

6. Практика новых навыков, когда клиенту предлагается провести практические упражнения для укрепления новых, более адаптивных поведенческих навыков. Она помогает клиенту интегрировать изменения в свою жизнь и укрепить их.

В конечном итоге модификацию поведения клиента можно разделить на следующие большие направления³⁰:

1. Стратегии, направленные на уменьшение избегания, самосаботаж и проблемного поведения (экспозиция). Данное воздействие является типичным для решения проблем тревоги.

2. Стратегии достижения поведенческих изменений (поведенческая активация). Данное воздействие является типичным для решения проблем депрессии.

Модификация поведения в КПТ направлена на создание позитивных и адаптивных изменений в жизни клиента, что в конечном итоге приводит к улучшению его психологического благополучия.

8.2. Проверяем форму поведения (экспозицию)

Экспозиция – один из ключевых методов, использованных для лечения различных тревожных расстройств, фобий, посттравматического стрессового расстройства и других проблем. Метод заключается в контролируемом и систематическом представлении клиенту стимулов, событий или ситуаций, вызывающих у него тревогу или страх, с целью достижения психологической адаптации и снижения симптомов.

Проблема клиента при столкновении с тревожащими ситуациями заключается в переживании беспомощности, т. е. с мыслями о невозможности справиться с обстоятельствами. Цель экспозиции – убедиться в том, что травмирующая ситуация является тяжелой, но ее последствия не катастрофичны, переживания клиента при этом тяжелы, но не являются невыносимыми.

По сути, единственный способ снизить уровень тревоги к конкретному стимулу – это убедиться на практике, что переживание не так ужасно, как нам кажется. Например, если клиент боится высоты, то, находясь в безопасном месте на высоте, у него появляется возможность понаблюдать за своими ощущениями, сформировать уверенность, что при всем эмоциональном дискомфорте, он

³⁰ См.: Добсон Д., Добсон К. Научно-обоснованная практика в когнитивно-поведенческой терапии. С. 149.

остается собой, может продолжать трезво оценивать ситуацию и справляется со своими чувствами. Схематически этот процесс представлен на рис. 6.

Сталкиваясь с неприятными ситуациями, мы, естественно, эволюционно целесообразно, стараемся их избегать. При этом для выживания не так уж важен характер опасности, важно, чтобы мы спаслись. Искаженные интерпретации о ситуациях, выводы, что мы можем погибнуть, часто не соответствуют реальности. Например, ситуация экзамена, связанная с оценкой студента, может трактоваться как ужасная, даже угрожающая жизни, а подготовка к нему – как эмоционально тяжелое событие. При этом проверка новостей в социальных сетях выступит формой охранительного поведения. Сам процесс такого откладывания является прокрастинацией, а по сути формой избегания неприятных эмоций.

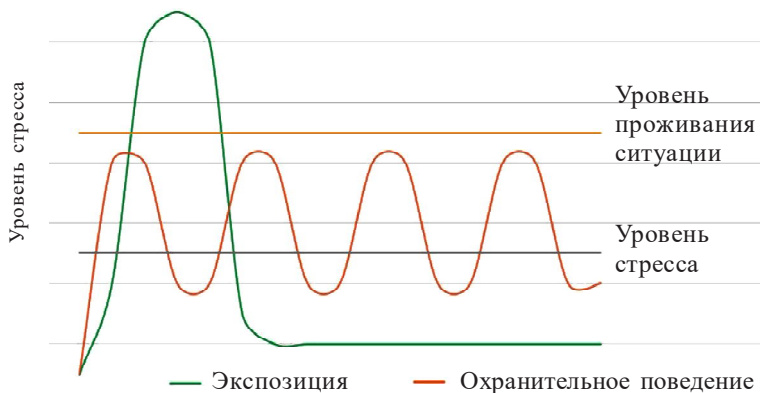


Рис. 6. Сравнительные графики интенсивности тревоги при использовании экспозиции и при охранительном поведении

Экспозиция включает в себя следующие аспекты:

- **Целенаправленность.** Проводится с целью преодоления тревожных реакций клиента и развития новых адаптивных способов реагирования на вызывающие тревогу ситуации.
- **Систематичность.** Проводится поэтапно, от менее стрессовых ситуаций к более интенсивным, чтобы клиент мог постепенно приспособиться и справиться с уровнем тревоги.

• **Повторяемость.** Повторяющиеся экспозиции в различных контекстах помогают укрепить адаптивные реакции клиента и снизить тревожность в реальных ситуациях.

• **Продолжительность.** Длится до тех пор, пока тревожные симптомы клиента не снизятся до приемлемого уровня и он не почувствует себя более комфортно в ситуации, которая ранее вызывала у него тревогу.

Проведение экспозиции включает следующие этапы:

1. **Подготовку.** Терапевт работает с клиентом над пониманием целей и методов экспозиции, обсуждает возможные риски и вырабатывает стратегии совладания с тревогой.

2. **Выбор стимулов.** Совместно с клиентом определяются ситуации, или стимулы, вызывающие тревогу, которые будут использоваться в экспозиции.

3. **Разработку плана.** Обсуждается план экспозиции, который включает в себя последовательное представление стимулов с нарастающей интенсивностью.

4. **Проведение экспозиции.** Клиент подвергается стимулам в соответствии с разработанным планом, а терапевт помогает ему отследить возникающие тревожные реакции.

5. **Оценку результатов.** После каждого этапа экспозиции проводится оценка выраженности признаков и рассматриваются возможные корректировки плана.

6. **Поддержку и укрепление полученных результатов,** а также перенос новых адаптивных способов реагирования на реальные ситуации в повседневной жизни.

Экспозиция является эффективным методом для преодоления тревожности и обучения клиента справляться с вызывающими тревогу ситуациями, что способствует его психологическому благополучию.

Протокол использования экспозиции представлен в прил. 1.14.

8.3. Поведенческая активация

Данная активация, в отличие от экспозиции – форма модификации поведения, когда терапевт создает новую форму активности

для клиента. Этот метод используется для лечения депрессивных расстройств и направлен на восстановление утраченного интереса к жизни, повышение настроения и улучшение общего психологического функционирования. Он также используется и в таких запросах, как повышение качества жизни, формирование новых навыков.

Специфика поведенческой активации включает в себя следующие аспекты:

1. **Целенаправленность.** Поведенческая активация проводится с целью увеличения активности клиента, повышения уровня его энергии и степени участия в приятных и значимых для него видах деятельности.

2. **Индивидуальный подход.** План активации разрабатывается с учетом индивидуальных интересов, ценностей и возможностей клиента, чтобы максимально подстроиться под его потребности.

3. **Постепенное увеличение активности.** Поведенческая активация включает в себя постепенное увеличение количества и разнообразия приятных и полезных видов деятельности, чтобы клиент мог постепенно возвращаться к активной жизни.

4. **Систематичность.** Активации проводятся систематически, чтобы обеспечить постоянную поддержку клиента и продолжительное улучшение его психологического состояния.

Этапы проведения поведенческой активации включают:

1. **Оценку и планирование.** Терапевт и клиент оценивают текущий уровень активности и интересов клиента и совместно разрабатывают план активации. Для оценки текущего уровня рекомендуется использование протокола самомониторинга (прил. 1.15).

2. **Постановку целей.** Определяются конкретные цели активации, которых клиент хочет достичь в рамках терапии (прил. 1.16).

3. **Разработку расписания.** Разрабатывается расписание видов деятельности, включающее приятные и значимые для клиента активности, которые будут включены в его повседневную жизнь.

4. **Проведение активаций.** Клиент начинает постепенно включать запланированные виды деятельности в свою жизнь и учится наслаждаться ими.

5. **Оценку и коррекцию.** Проводится оценка эффективности активаций и корректировка плана в зависимости от результатов.

6. Поддержку и поддержание. Терапевт оказывает поддержку клиенту на протяжении всего процесса активации и помогает ему поддерживать достигнутые результаты в долгосрочной перспективе.

Поведенческая активация способствует восстановлению активности и участия клиента в жизни, что является важным шагом в преодолении депрессивных симптомов и улучшении его психологического состояния.

Темы для выступлений

1. Метод экспозиции: история и перспективы.
2. Порядок проведения экспозиции.
3. Поведенческие эксперименты: теоретические основы.
4. Нервно-мышечная релаксация по Джекобсону.

Темы для обсуждения

1. Преимущества и недостатки различных методов релаксации.
2. Ограничения метода прогрессивной нервно-мышечной релаксации по Джекобсону (прил. 1.17).
3. Мотивация клиентов к экспозиционной терапии.

Разбор техник

1. Протокол экспозиции.
2. Лестница страха (прил. 1.18).
3. Техника самомониторинга.
4. «За» и «против».
5. Техника прогрессивной нервно-мышечной релаксации.

Информационные ресурсы для конспектирования

Гринбергер Д. Разум рулит настроением. Измени свои мысли, привычки, здоровье, жизнь. Гл. 11. «Исходные положения и поведенческие эксперименты» / Д. Гринбергер, К. А. Падески. Санкт-Петербург : Питер, 2019. С. 156–178.

Спрингер К. С. Большая книга экспозиций: инновационная и эффективная методика лечения тревожных расстройств на основе когнитивно-

поведенческой терапии. Гл. 2. «Мотивирование клиентов к применению экспозиционной терапии» / К. С. Спрингер, Д. Ф. Толин ; пер. с англ. Я. В. Бабковой. Киев : «Диалектика», 2022. С. 43–60.

Добсон Д. Научно-обоснованная практика в когнитивно-поведенческой терапии. Гл. 6. «Поведенческая работа. Развитие навыков» / Д. Добсон, К. Добсон. Санкт-Петербург : Питер, 2021. С. 147–178.

Добсон Д. Научно-обоснованная практика в когнитивно-поведенческой терапии. Гл. 7. «Поведенческая работа. Снижение избегания» / Д. Добсон, К. Добсон. Санкт-Петербург : Питер, 2021. С. 179–201.

Лихи Р. Техники когнитивной психотерапии. Гл. 9. «Взгляд на проблемы в перспективе» (любые три техники) / Р. Лихи. Санкт-Петербург : Питер, 2020. С. 263–295.

Хачетлова З. Х. Эффективность экспозиционной терапии в работе с людьми, переживающими горе / З. Х. Хачетлова // Технологические инновации и научные открытия : сб. тр. по материалам XII Междунар. конкурса науч.-исслед. работ, Уфа, 27 февраля 2023 года. Уфа : Научно-издательский центр «Вестник науки», 2023. С. 240–243.

Практические задания

Задание 1. Составьте свою лестницу страха по какому-либо из своих ограничений (со страхом высоты).

Пример выполнения

1. Посмотреть на фотографию высокого здания или местности с высокими горами.
2. Подняться на высокий балкон или смотровую площадку, но оставаться в пределах ограждения.
3. Подняться на лестницу в помещении на второй или третий этаж.
4. Подняться на крышу небольшого здания или дома.
5. Подняться на верхнюю площадку видовой башни или смотровой площадки, но оставаться в пределах ограждения.
6. Подняться на вершину небольшого холма или горы.
7. Подняться на вершину средней по высоте горы или скалы.
8. Подняться на вершину высокой горы или на высокое здание с открытой площадкой.
9. Попробовать пройти по узкому мосту или тропе на высокой вышке.
10. Самостоятельно постоять на краю высокого утеса или смотровой площадки без ограждения некоторое время.

Задание 2. На основе протокола экспозиции (прил. 1.14) составьте для себя список возможных наблюдаемых признаков (5 позиций).

П р и м е р

- Потливость.
- Учащенный пульс.
- Нервные жестикюляции.
- Панические или беспокойные мысли.
- Тошнота или рвота.

Задание 3. Напишите список приятных активностей, которые доставляют вам удовольствие и помогают расслабиться.

П р и м е р в ы п о л н е н и я

- Прогулки в парке или в лесу.
- Занятия рукоделием (вязание, вышивание и т. д.).
- Пробежки на свежем воздухе.
- Велосипедные прогулки.
- Разговоры «по душам» с близким человеком.

Задание 4. Оцените свой список приятных активностей согласно технике «Удовольствие/ Удовлетворенность» (от 10 видов деятельности).

П р и м е р в ы п о л н е н и я

Активность	Удовольствие (процесс)	Удовлетворенность (результат)	Итоговая оценка
Кальян	5	2	10
Тренировка	3	5	15

Задание 5. Распишите три цели согласно технологии SMART.

П р и м е р в ы п о л н е н и я

Улучшение навыков владения английским языком:

- Специфичность – повысить уровень владения английским языком.
- Измеримость – пройти онлайн-курс английского языка и достичь уровня B2.
- Достижимость – выделять по 30 мин каждый день на изучение языка и выполнение заданий курса.
- Релевантность – улучшение коммуникационных навыков и расширение возможностей в карьерном и личном развитии.
- Ограниченность по времени – завершение курса и достижение уровня B2 за шесть месяцев.

Тема 9

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С ОТДЕЛЬНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

Ключевые понятия

Руминации, экзогенная депрессия, психогенная депрессия, суицидальное намерение, суицидальное поведение, суицидальные мысли, тревога, тревожность, страх, тревожное расстройство, паническое расстройство, агорафобия, экзогенная депрессия, психогенная депрессия, аддиктивное поведение, аддикция.

9.1. Работа с тревогой

Тревога – это нормальная реакция организма на стрессовые ситуации, характеризующиеся ощущением беспокойства, напряжения, неопределенности или опасности. Тревога, как и все остальные эмоции, эволюционно целесообразна. Она может быть полезной, помогая адаптироваться к новым ситуациям или подготовиться к реагированию на угрозы. Но когда тревожные ощущения становятся чрезмерными, длительными или мешают нормальному функционированию, это может сигнализировать о тревожном расстройстве.

С точки зрения когнитивной модели тревога вызывается тревожными мыслями, которые можно рассмотреть как сочетание следующих идей:

- 1) что-то неприятное может произойти;
- 2) если это произойдет, то я не справлюсь (катастрофизация), или мне будет очень плохо (недостаточная толерантность к фрустрации), или это будет говорить обо мне что-то ужасное (обобщение).

К типичным мыслям тревожного человека можно отнести:

- «Что-то плохое произойдет». Тревожный человек может постоянно ожидать негативных событий, даже если нет конкретных

оснований для этого. Он может думать: «Что, если случится несчастье?» Или: «Все будет испорчено».

- «Я не смогу справиться». Тревожность может привести к убеждению, что человек не сможет справиться с тем, что может случиться. Он будет думать: «Я не справлюсь с этой задачей». Или: «Я не смогу выдержать эту ситуацию».

- «Все меня осудят». Тревожный человек часто беспокоится о том, что окружающие будут осуждать его за действия или поведение. Он может думать: «Все подумают, что я глупец». Или: «Меня никто не поймет».

- «Я не достоин любви/уважения». Тревожность обычно приводит к сомнениям в собственной ценности или достоинстве. Человек может думать: «Никто не будет меня любить». Или: «Меня никто не уважает».

- «Что, если я потеряю контроль». Тревожный человек будет беспокоиться о потере контроля над ситуацией или своими эмоциями. Он может думать: «Что, если я потеряю разум?» Или: «Я не смогу остановить свои страхи».

Работа с тревогой в КПТ подразумевает выработку реалистичного взгляда на ситуацию и тренировку действий, которые позволяют быть более адаптивным к угрозам. Так, Роберт Лихи отмечает наличие правил, в соответствии с которыми действует тревожный человек³¹:

1. Поиск опасности.
2. Преувеличение негативных последствий.
3. Попытка контролировать ситуацию с помощью иррациональных ритуалов и суеверий.
4. Избегание ситуаций, вызывающих тревожные состояния.

В качестве адаптивной альтернативы этим правилам он предлагает рациональный анализ информации об угрозе, оценку и принятие последствий, тренировку проживания тревожной ситуации, выработку готовности принять тревогу.

Этапы преодоления излишней тревоги представлены на рис. 7.

³¹ Лихи Р. Лекарство от нервов. Как перестать волноваться и получить удовольствие от жизни. СПб. : Питер, 2018. С. 3.

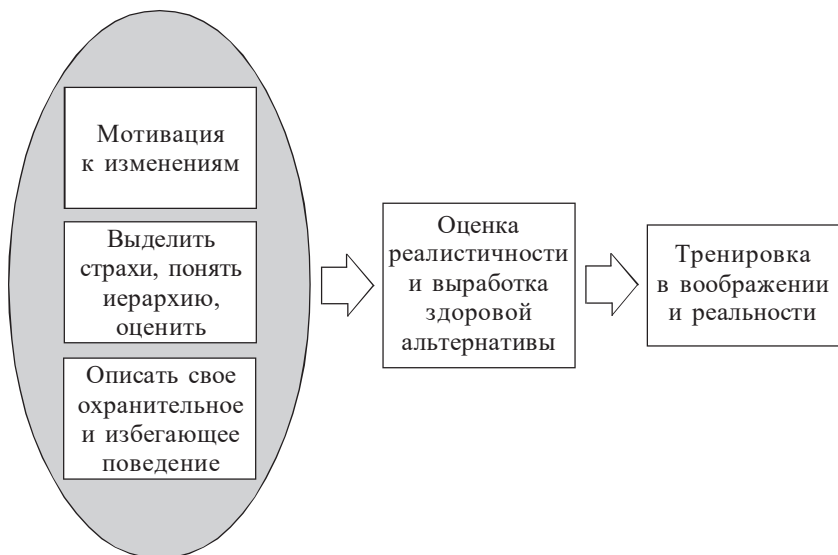


Рис. 7. Этапы решения проблемы излишней тревоги

Для каждого из этих этапов можно рекомендовать следующие техники и протоколы: «Протокол экспозиции» (прил. 1.14), «Лестница страха» (прил. 1.18), «Анализ мотивации изменений при тревоге» (прил. 1.19).

9.2. Работа с депрессией

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения депрессия (от лат. *depressio* – подавление, угнетение) – это широко распространенное психическое нарушение, которое характеризуется унынием, потерей интереса, неспособностью радоваться и получать удовольствие, чувством вины или низкой самооценкой, нарушениями сна, аппетита, чувством усталости и плохой концентрацией. Проявлениям депрессии в МКБ-11 посвящен блок L2-6A7, где даны классификация и симптоматика расстройств.

Один из первых исследователей депрессии – Э. Крепелин выделяет следующую классическую триаду (1899), определяющую депрессивные проявления:

- гипотимия (сниженное настроение, подавленность);
- идеаторная заторможенность (снижение психической активности);
- моторная заторможенность (снижение двигательной активности).

А. Бек уже в рамках когнитивного подхода выделяет когнитивную триаду депрессии (1963), разделяющую мысли депрессивного пациента на следующие группы:

- 1) к самому себе (чувство неполноценности, бесполезности, неизлечимости);
- 2) к текущему опыту (ощущение непреодолимых препятствий и высоких требований);
- 3) к будущему (предвидение неизбежных трудностей, разочарований и провалов).

Ниже представлен рассматриваемый в рамках КПТ так называемый порочный круг депрессии, или «цикл депрессии». Он демонстрирует механизм того, как негативные оценочные мысли подкрепляются соответствующим поведением, что в дальнейшем усиливает негативные мысли.

На рис. 8 можно увидеть, как бездеятельность пациента (ситуация) провоцирует негативные мысли о себе (автоматические мысли), что является причиной эмоциональной подавленности (эмоциональной реакции), а в конечном итоге вызывает клинические проявления депрессии, определяющие еще большую бездеятельность.

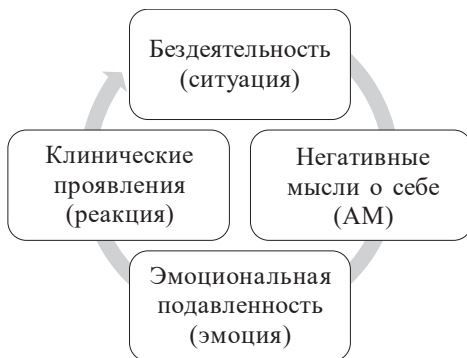


Рис. 8. Порочный круг депрессии

Лечение депрессии всегда производится в сотрудничестве с психиатром в силу высоких рисков для клиента в процессе лечения, как правило, в сочетании с приемом лекарственных препаратов. Выбор тактики лечения определяется в том числе анамнезом пациента, видом депрессивного расстройства и анализом механизма возникновения расстройства.

Ключевая цель в работе с проявлениями депрессии заключается в изменении негативных мыслей, ощущений и поведения, которые способствуют поддержанию депрессивного состояния. Это включает идентификацию и пересмотр искажений мышления, участие в приятных и значимых активностях, а также развитие навыков решения проблем.

В целом, чем сильнее выражена депрессия, тем больший акцент в терапии делается на поведенческих техниках. Из рекомендуемых техник и протоколов можно отметить чек-лист «Симптомы депрессии» (прил. 1.20), «Удовольствие и удовлетворенность» (прил. 1.21), поведенческая активация (п. 8.3 темы 8).

9.3. Работа с суицидальным риском

Суицидальное поведение – это серьезный психологический феномен, который требует внимательного изучения и компетентного подхода со стороны специалистов. Оно может проявляться в различных формах, включая суицидальные мысли, планы или попытки суицида. В КПТ суицидальные проявления рассматриваются в ключе когнитивной модели, где основной акцент делается на том, как работает оценка клиентом значимых ситуаций, какими убеждениями эта оценка провоцируется.

Особое значение в работе с суицидальными проявлениями придается ценностям и мотивации клиента. Также в анализе риска уделяется внимание выраженности антисуицидальных факторов, среди которых можно отметить:

- наличие эмоциональной привязанности;
- родственные обязанности;
- чувство долга, понятие о чести;

- зависимость от общественного мнения (в том случае, если общественные нормы не допускают суицида);
- наличие планов, определяющих цель в жизни;
- внимание к собственному здоровью;
- представление о неиспользованных возможностях;
- наличие эстетических критериев мышления;
- экзистенциальное осмысление конфликта;
- религия.

Один из основных вопросов профилактики суицидального риска – анализ его маркеров. Так, А. Б. Холмогорова указывает на черты склонности к уязвимости, включающие импульсивную агрессию, перфекционизм и отсутствие опыта конструктивного решения проблем³². Идентификация дезадаптивных искажений мышления позволяет выработать эффективную стратегию решения проблемы. Примеры типичных убеждений суицидента и их здоровые альтернативы представлены в табл. 4.

Т а б л и ц а 4

**Типичные убеждения суицидента
и их здоровая альтернатива**

Негативные убеждения суицидента	Здоровая альтернатива
Будущее безнадежно.	Состояние является временным.
Текущая жизненная ситуация невыносима.	Нормальность переживания.
Нет никого, кто способен оказать поддержку	Ты нужен близким. Ты имеешь право ответственно распоряжаться своей жизнью

В качестве рекомендуемых техник можно отметить: «Сократовский диалог» (прил. 1.12) и «План безопасности» (прил. 1.22).

³² См.: Холмогорова А. Б. Протокол когнитивно-бихевиоральной терапии пациентов, переживающих суицидальный кризис // СТПН. 2014. № 1. С. 26–27. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protokol-kognitivno-bihevioralnoy-terapii-patsientov-perezhiyayuschih-suitsidalnyy-krizis> (дата обращения: 01.05.2024).

9.4. Работа с зависимостями

Зависимое поведение проявляется в необходимости постоянно прибегать к определенным веществам или действиям. Зависимости проявляются в различных формах: употребление алкоголя или наркотиков, азартные игры, чрезмерное времяпрепровождение в Интернете и другие занятия, которые занимают центральное место в жизни человека в ущерб остальным сферам и приводят к утрате способности контролировать свое поведение, а также другим негативным последствиям.

Работа с зависимым поведением необходима, потому что оно может сильно повлиять на качество жизни человека и его окружающих. Зависимость может привести к разрушительным последствиям для физического и психического здоровья, в социальных отношениях, финансовом положении и др.

Зависимость следует рассматривать как результат комплексного взаимодействия между мыслями, чувствами и поведением.

На уровне мыслей человек с зависимым поведением может испытывать искаженные убеждения и представления о себе, окружающем мире и своих возможностях контролировать ситуацию. Например, он может верить, что не справится с жизненными трудностями без прибегания к зависимости, или что употребление вещества поможет ему расслабиться и справиться со стрессом.

Поведение у зависимого включает в себя акты потребления вещества или участие в определенных действиях. Человек может прибегать к этим действиям в ответ на стресс, тревогу и другие негативные эмоции, считая их способом справиться с проблемами.

Физиологические реакции связаны с изменениями в организме, вызванными зависимым поведением, например, изменениями в уровне нейротрансмиттеров или реакциями стрессовой системы.

Для осуществления эффективной работы необходимо провести концептуализацию зависимого поведения и согласовать ее с клиентом (рис. 9). Это позволяет выработать общий взгляд на природу проблемы и определиться с ключевыми целями терапии.

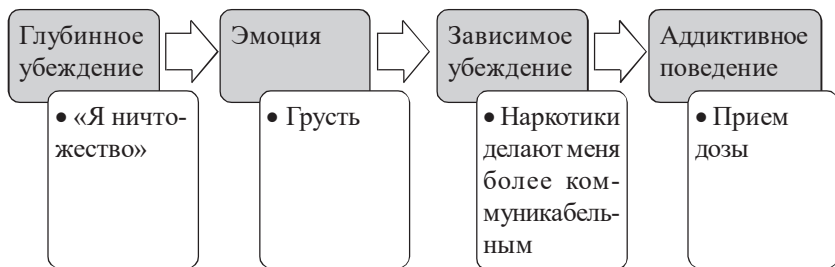


Рис. 9. Пример построения концептуализации
зависимого поведения

Также необходимо объяснить и согласовать с клиентом конкретные циклы зависимого поведения, определиться с их содержанием, т. е. конкретными триггерами, переживаемыми эмоциями и т. д. Это даст возможность прогнозировать риски и нивелировать их воздействие. Ниже приведен типичный цикл зависимого поведения (рис. 10).

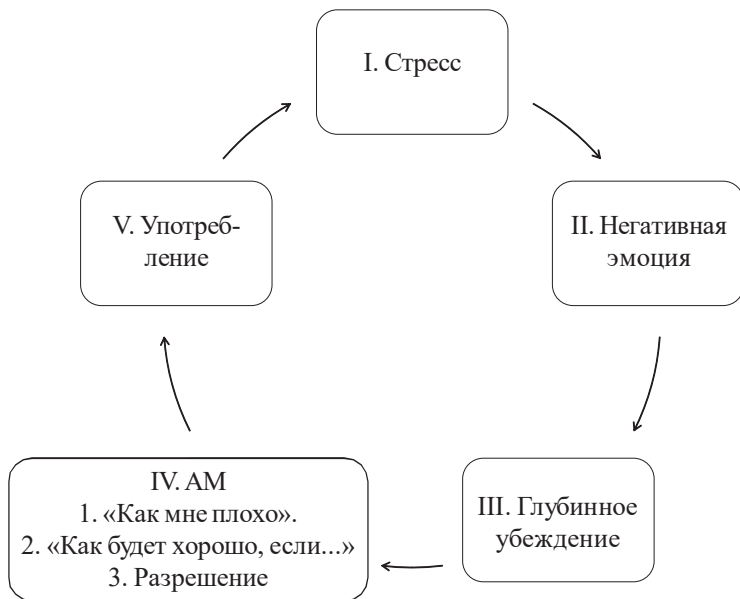


Рис. 10. Цикл зависимого поведения

В соответствии с представленным циклом зависимый человек, столкнувшись с ситуацией стресса, испытывает негативные эмоции, провоцирующие проявление глубинного убеждения. Его актуализация требует снижения напряжения через появление автоматических мыслей. Можно выделить следующие их категории:

1. «Как мне плохо». Зависимый переоценивает свое негативное состояние в связи с влиянием глубинного убеждения. Например: «Я не могу начать день без сигареты». Или: «Мне так плохо, поэтому надо расслабиться».

2. «Как будет хорошо, если...» Эта категория автоматических мыслей предлагает ему альтернативу совладания со стрессом посредством зависимого поведения. При этом сам человек понимает, что выбор аддиктивного поведения является деструктивным. Примеры таких мыслей: «Сегодня я точно смогу выиграть». Или: «В состоянии наркотического опьянения мое сознание расширяется».

3. Разрешение. Данные мысли делают акцент на принятии решения, при этом зависимый испытывает значительное облегчение. Например: «Если я сыграю один раз, то ничего страшного не произойдет»; «У меня был напряженный день, поэтому я заслуживаю немного выпить»; «Это будет последний раз, завтра я начну новую жизнь».

Важно отметить, что причина, по которой разрешающие мысли снимают напряжение, заключается в том, что вне зависимости от принятого решения исчезает ситуация неопределенности.

В целом работа с зависимым поведением проходит через ряд этапов:

1. Работа с мотивационными паттернами (прояснение ожиданий, постановка целей, работа с ценностями, мотивационное интервью → список действий, ценностей, копинг-карты).

2. Работа с когнитивными паттернами – убеждениями, автоматическими мыслями (СМЭР, ЭМУУМЭ, функциональный анализ → копинг-карты и списки триггеров с вариантами действий).

3. Работа с фокусом внимания и аффективными паттернами (навыки эмоциональной регуляции, майндфулнесс → навыки регулярной самоподдержки и осознанности).

4. Работа с поведенческими паттернами (поведенческие эксперименты).

Эффективная коррекция зависимости требует значительных усилий не только зависимого и терапевта, но и вклада всего ближайшего окружения. Важно помнить, что это длительный процесс, полного излечения от многих видов зависимости не существует, а необходимость профилактики на протяжении всей оставшейся жизни зависимого человека остается.

Темы для выступлений

1. Виды тревожных расстройств.
2. Работа с тревогой в КПТ.
3. Депрессия и ее классификации.
4. Техники работы с депрессией в КПТ.
5. Понятие суицидального риска.
6. Зависимое поведение и формы его коррекции.

Темы для обсуждения

1. Насколько распространена депрессия в современном обществе? Какие факторы ее распространения можно выделить?
2. Насколько опасно обсуждение тем суицида с несовершеннолетними?
3. Какие могут быть показатели успешного преодоления зависимого поведения?

Разбор техники

1. Анализ мотивации изменений при тревоге.
2. Техника оценки активности «Удовольствие / Удовлетворенность».
3. Чек-лист «Симптомы депрессии».
4. План безопасности.

Информационные ресурсы для конспектирования

Лихи Р. Победи депрессию прежде, чем она победит тебя. Гл. 2. «Депрессивный разум» / Р. Лихи. Санкт-Петербург : Питер, 2020. С. 38–62.

Уоткинс Э. Сфокусированная на руминации когнитивно-поведенческая терапия депрессии. Главные принципы сфокусированной на руминации КПТ / Э. Уоткинс. Санкт-Петербург : Питер, 2023. С. 97–114. (Сер. «Когнитивно-поведенческая психотерапия»).

Холмогорова А. Б. Протокол когнитивно-бихевиоральной терапии пациентов, переживающих суицидальный кризис / А. Б. Холмогорова // СТПН. 2014. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protokol-kognitivno-bihevioralnoy-terapii-patsientov-perezhivayuschih-suitsidalnyy-krizis> (дата обращения: 01.05.2024).

Практические задания

Задание 1. На основе художественной литературы сделайте подборку мыслей тревожного персонажа.

Задание 2. Составьте таблицу, включающую анализ различий между проявлениями депрессии.

Задание 3. Разработайте наглядный материал по первичной профилактике суицидального риска для специалистов, работающих с несовершеннолетними.

Задание 4. Предложите комплекс мероприятий по профилактике употребления психически активных веществ. Подберите успешные, на ваш взгляд, примеры такой работы.

Тема 10

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Ключевые понятия

Расстройство личности, план безопасности, планирование, мониторинг, оценочные критерии, протокол.

10.1. Этапы работы с клиентом

Работа клиента с терапевтом в КПТ обычно проходит через несколько этапов:

1. *Начальная оценка и установление контакта.* На этом этапе клиент знакомится с терапевтом, объясняет свои проблемы и ожидания от терапии, а также устанавливаются контакт и доверие с терапевтом.

2. *Определение проблемы и целей терапии.* Вместе с терапевтом клиент определяет свои проблемы и цели, которых он хотел бы достичь в ходе терапии. Это включает в себя обсуждение текущих трудностей и их влияния на жизнь клиента.

3. *Изучение убеждений и мыслей.* Клиент с терапевтом анализируют свои мысли, убеждения и реакции на различные ситуации. Они обсуждают, как эти мысли могут влиять на эмоции и поведение клиента.

4. *Разработка стратегий изменений.* На основе анализа убеждений и мыслей клиент с терапевтом разрабатывают стратегии и навыки для изменения негативных или неадаптивных мыслей и поведения клиента.

5. *Практика и применение новых навыков.* Клиент применяет изученные навыки в повседневной жизни и отслеживает их эффективность. Терапевт помогает ему преодолевать препятствия и поддерживает его в процессе изменений.

6. Оценка прогресса и коррекция стратегий. Клиент с терапевтом регулярно оценивают прогресс в достижении целей терапии и корректируют стратегию, если необходимо. Это позволяет поддерживать мотивацию и продвигаться вперед.

7. Завершение терапии и поддержание результатов. После достижения целей терапии клиент с терапевтом обсуждают завершение работы и определяют план поддержания достигнутых результатов в дальнейшем.

10.2. Проблемы в терапии

В ходе КПТ могут возникать различные типичные проблемы как у клиентов, так и у терапевтов. Приведем некоторые из них:

1. Соппротивление изменениям. Некоторые клиенты могут испытывать сопротивление по отношению к изменению своих мыслей, убеждений и поведения. Это обычно вызвано страхом перед неизвестным или привычкой к прежнему образу жизни.

2. Недостаток мотивации. У отдельных клиентов наблюдается недостаток мотивации для активного участия в терапевтическом процессе. Это обычно связано с отсутствием веры в успешность терапии, сниженным настроением или апатией.

3. Сложности в применении навыков. Клиентам может быть трудно применять изученные навыки и стратегии в повседневной жизни. Это часто связано с неуверенностью в своих силах, наличием препятствий или неадаптированным окружением.

4. Трудности в выражении эмоций. Клиенты могут испытывать трудности в выражении своих эмоций и переживаний в рамках терапевтического процесса, что затрудняет работу с негативными эмоциями и их преодолением.

5. Недостаточное понимание терапевтических концепций. Для отдельных клиентов концепции и стратегии КПТ непонятны или сложны. Это может привести к затруднениям в понимании заданий и выполнении терапевтических упражнений.

6. Проблемы в отношениях с терапевтом. Иногда клиенты могут испытывать трудности в установлении и поддержании рабочих

отношений с терапевтом, что связано с недоверием, разногласиями в подходах или неудовлетворенностью результатами.

Важно, чтобы терапевт и клиент совместно работали над решением данных проблем, обсуждали их открыто и искали адаптивные стратегии для их преодоления. Это позволит сделать терапию более продуктивной и эффективной. Для проверки и решения типичных проблем в терапии воспользуйтесь формой вариантов решения проблем в прил. 1.23.

10.3. Оценка эффективности терапии

Традиционно КПТ больше ориентирована на процесс работы. Поэтому для оценки эффективности наиболее важными показателями при аттестации терапевтов является умение следовать ключевым процедурам и протоколам работы.

Процедура аттестации опирается на следующий список стандартизированных требований оценки эффективности работы когнитивно-поведенческого терапевта³³:

- совместная формулировка уместной повестки дня;
- уверенное получение обратной связи от клиента;
- понимание клиента, его невербальных и вербальных проявлений;
- оптимальное проявления заботы, искренности и профессионализма;
- помощь в проявлении клиентом активной позиции;
- эффективное использование времени сессии;
- оптимальное использование техники «направляемого открытия»;
- способность фокусироваться на ключевых мыслях и поведении в соответствии с обсуждаемой проблемой;
- успешно выбранная последовательная стратегия изменений;
- оптимальный выбор когнитивно-поведенческих техник;
- успешно проверенное домашнее задание и выбор нового задания с учетом индивидуальных особенностей клиента.

³³ См.: Бек Д. Когнитивно-поведенческая терапия. От основ к направлениям. С. 405–411.

Также важно учитывать, что любое направление психотерапии предполагает высокий уровень личностного развития специалиста. Знание техник и следование протоколам не может заменить человеческого отношения.

Темы для выступлений

1. Стратегия работы с клиентом в когнитивно-поведенческом подходе.
2. Типичные проблемы в терапии.

Темы для обсуждения

1. С чего начать решение трудностей в терапии?
2. От чего зависит эффективность терапии: процесс или результат.

Информационные ресурсы для конспектирования

Добсон Д. Научно-обоснованная практика в когнитивно-поведенческой терапии. Гл. 12. «Сложности, возникающие в когнитивно-поведенческой терапии» / Д. Добсон, К. Добсон. Санкт-Петербург : Питер, 2021. С. 320–353.

Бек Д. Когнитивная терапия для сложных случаев: что делать, когда простые решения не работают. Гл. 3. «Когда лечение осложняется расстройством личности» / Д. Бек ; пер. с англ. Санкт-Петербург : «Диалектика», 2020. С. 73–100.

Практические задания

Задание 1. Клиент по имени Максим обратился к психологу с симптомами депрессии. Он чувствует постоянную усталость, потерю интереса к обычным делам, сонливость, апатию и снижение настроения. В последние месяцы у него было несколько серьезных конфликтов на работе, а также расставание с долгосрочным партнером. Максим часто сравнивает себя с другими и чувствует себя недостойным и бесполезным. В связи с этим он часто проводит время в одиночестве, избегая общения с друзьями и близкими.

Напишите возможные цели терапии.

Предложите этапы КПТ для Максима.

Задание 2. Клиент по имени Алекс обратился к терапевту из-за депрессии и тревожности. Алекс работает в стрессовой среде и испытывает постоянное давление на работе. Его депрессия ухудшается из-за переживаний о неспособности справиться с требованиями работы и страха перед неудачей. Он также испытывает конфликты в отношениях с семьей из-за его недоступности и раздражительности.

Однако Алекс чрезвычайно закрытый и неохотно делится своими мыслями и эмоциями. Он считает, что проявление уязвимости – это признак слабости, поэтому предпочитает скрывать свои чувства. Это создает трудности в установлении доверительных отношений с терапевтом и в рамках терапевтического процесса.

Кроме того, Алекс пренебрегает назначениями и не выполняет домашние задания, предложенные терапевтом. Он скептически относится к эффективности терапии и сомневается в своей способности изменить свое положение.

Предложите план действий.

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

О с н о в н а я л и т е р а т у р а

Бек А. Когнитивная терапия, ориентированная на восстановление / А. Бек, П. Грант, Э. Инверсо, Д. Периволиотис. – Санкт-Петербург : Питер, 2024. – 416 с.: ил. – (Сер. «Когнитивно-поведенческая психотерапия»). – ISBN 978-5-4461-2948-5.

Бек Д. Когнитивная терапия для сложных случаев: что делать, когда простые решения не работают / Д. Бек ; пер. с англ. С. Ю. Кравченко. – Санкт-Петербург : Вильямс, 2020. – 432 с.: ил. – ISBN 978-5-907144-88-0.

Бек Д. Когнитивно-поведенческая терапия. От основ к направлениям / Д. Бек. – Санкт-Петербург : Питер, 2023. – 416 с.: ил. – (Сер. «Мастера психологии»). – ISBN 978-5-4461-0552-6.

Бек Д. Когнитивно-поведенческая терапия. От основ к направлениям / Д. Бек. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2024. – 512 с.: ил. – (Сер. «Когнитивно-поведенческая психотерапия»). – ISBN 978-5-4461-2960-7.

Гринбергер Д. Разум рулит настроением. Измени свои мысли, привычки, здоровье, жизнь / Д. Гринбергер, К. А. Падески. – Санкт-Петербург : Питер, 2020. – 368 с. – (Сер. «Сам себе психолог»). – ISBN 978-5-4461-1321-7.

Рационально-эмотивно-поведенческая терапия / Р. Диджузеппе, К. Дойл, У. Драйден, У. Бакс. – Санкт-Петербург : Питер, 2021. – 480 с. – (Сер. «Когнитивно-поведенческая психотерапия»). – ISBN 978-5-4461-1511-2.

Добсон Д. Научно-обоснованная практика в когнитивно-поведенческой терапии / Д. Добсон, К. Добсон. – Санкт-Петербург : Питер, 2021. – 400 с. – (Сер. «Когнитивно-поведенческая психотерапия»). – ISBN 978-5-4461-1584-6.

Лихи Р. Техники когнитивной психотерапии / Р. Лихи. – Санкт-Петербург : Прогресс, 2020. – 656 с. – (Сер. «Сам себе психолог»). – ISBN 978-5-4461-1218-0.

Сократовские вопросы в психотерапии и консультировании / С. Уолтман, Р. Кодд, Л. Макфарр, Б. Мур. – Санкт-Петербург : Питер, 2023. – 464 с.: ил. – (Сер. «Когнитивно-поведенческая психотерапия»). – ISBN 978-5-4461-2912-6.

Уоткинс Э. Сфокусированная на руминации когнитивно-поведенческая терапия депрессии / Э. Уоткинс. – Санкт-Петербург : Питер, 2023. –

512 с.: ил. – (Сер. «Когнитивно-поведенческая психотерапия»). – ISBN 978-5-4461-1502-0.

Beck J. S. Cognitive behavior therapy: Basics and beyond / J. S. Beck. – New York : The Guilford Press, 2020. – 414 p. – ISBN 9781462544196.

Д о п о л н и т е л ь н а я л и т е р а т у р а

I Международный съезд Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии : сборник научных статей / сост. Д. В. Ковпак, А. И. Ковпак. – Санкт-Петербург : СИНЭЛ, 2015. – 98 с. – ISBN 978-5-9906651-4-9.

Бек А. Когнитивная психотерапия расстройств личности / А. Бек, А. Фримен ; переводчик С. Комаров. – Санкт-Петербург : Питер, 2024. – 448 с.: ил. – (Сер. «Мастера психологии»). – ISBN 978-5-4461-1156-5, 978-5-496-03098-4.

Бек А. Т. 60-летняя эволюция когнитивной теории и терапии / А. Т. Бек // VIII Международный форум ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии CBTFORUM : сборник научных статей. Санкт-Петербург, 20–22 мая 2022 года. – Санкт-Петербург : Лема, 2022. – С. 7–16.

Гараян Н. Г. Интегративная психотерапия тревожных и депрессивных расстройств на основе когнитивной модели / Н. Г. Гараян, А. Б. Холмогорова // Московский психотерапевтический журнал. – 1996. – № 3. – С. 112–163.

Граница А. Тактики диспута. Когнитивно-поведенческий подход / А. Граница, А. Зепсен, Д. Ковпак. – Санкт-Петербург : Питер, 2023. – 400 с. – (Сер. «Когнитивно-поведенческая психотерапия»). – ISBN 978-5-4461-2128-1.

Ли Д. Когнитивно-поведенческая терапия для врачебной практики : Практ. руководство / Дэвид Ли ; пер. с англ. Е. М. Савиновой. – Киев : Науковий Світ, 2023. – 382 с.: ил. – Парал. тит. англ. – ISBN 978-617-550-074-3 (укр.), ISBN 978-1-904842-93-4 (англ.)

Ковпак Д. В. Когнитивно-поведенческая терапия суицидального поведения / Д. В. Ковпак // Вестник Московской международной академии. – 2021. – № 2. – С. 55–63.

Когнитивная терапия депрессии / А. Бек, А. Раш, Б. Шо, Г. Эмери. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 304 с.: ил. – (Сер. «Золотой фонд психотерапии»). – ISBN 5-318-00689-2.

Линехан М. Когнитивно-поведенческая терапия пограничного расстройства личности / М. Линехан. – Москва : Вильямс, 2020. – 592 с. – ISBN 978-5-907203-09-9.

Лихи Р. Победы депрессию прежде, чем она победит тебя / Р. Лихи. – Санкт-Петербург : Питер, 2022. – 384 с. – ISBN 978-5-4461-1664-5.

Лихи Р. Преодоление сопротивления в когнитивной терапии / Р. Лихи. – Санкт-Петербург : Питер, 2021. – 352 с. – (Сер. «Когнитивно-поведенческая психотерапия»). – ISBN 978-5-4461-1630-0.

Лихи Р. Свобода от тревоги. Справься с тревогой, пока она не расправилась с тобой / Р. Лихи. – Санкт-Петербург : Питер, 2025. – 512 с. – ISBN 978-5-4461-1856-4.

Малыгин Я. В. Концептуализация коморбидных тревожных и депрессивных расстройств и подходы к их ведению / Я. В. Малыгин, А. С. Орлова, В. Л. Малыгин // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2022. – Т. 122, № 6. – С. 48–54.

Оверхолзер Дж. Метод Сократа в психотерапии / Джеймс Оверхолзер ; пер. с англ. под ред. Т. А. Исмаил. – Киев : Диалектика, 2022. – 306 с.: ил. – Парал. тит. англ. – ISBN 978-5-907458-05-5.

Когнитивно-бихевиоральная терапия психических расстройств / Я. Прашко, П. Можны, М. Шлепецки и др. – Москва : Институт общегуманитарных исследований, 2015. – 1072 с. – ISBN 978-5-8823-0355-5.

Прохазка Д. Системы психотерапии. Для консультантов, психотерапевтов и психологов / Д. Прохазка, Д. Норкросс. – 6-е изд. – Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 384 с. – (Сер. «Большая университетская библиотека»). – ISBN 5-93878-386-0, ISBN 978-5-93878-386-7.

МакМаллин Р. Практикум по когнитивной терапии / Райан МакМаллин ; пер. с англ. Т. Саушкиной. – Санкт-Петербург : Речь, 2001. – 560 с. – ISBN 5-9268-0036-6.

Ромек Е. А. Философские концепции, лежащие в основании современной когнитивно-поведенческой психотерапии / Е. А. Ромек, В. Г. Ромек // VIII Международный форум ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии CBTFORUM : сборник научных статей. Санкт-Петербург, 20–22 мая 2022 года. – Санкт-Петербург : Лема, 2022. – С. 212–215.

Росал М. Л. Когнитивно-поведенческая арт-терапия / М. Л. Росал. – Санкт-Петербург : Питер, 2022. – 320 с.: ил. – (Сер. «Когнитивно-поведенческая психотерапия»). – ISBN 978-5-4461-1789-5.

Смагина Е. Н. Теоретический обзор концепций ценностей в психологии / Е. Н. Смагина // Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. – 2020. – № 2 (155). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskiy-obzor-kontseptsiiy-tsennostey-v-psihologii> (дата обращения: 01.05.2024).

Спрингер К. С. Большая книга экспозиций: инновационная и эффективная методика лечения тревожных расстройств на основе когнитивно-поведенческой терапии / К. С. Спрингер, Д. Ф. Толин ; пер. с англ. Я. В. Баб-

ковой. – Киев : Диалектика, 2022. – 304 с.: ил. – Парал. тит. англ. – ISBN 978-617-7874-51-4 (укр.), ISBN 978-1684-03373-7 (англ.).

Холмогорова А. Б. Протокол когнитивно-бихевиоральной терапии пациентов, переживающих суицидальный кризис / А. Б. Холмогорова // Современная терапия в психиатрии и неврологии. – 2014. – № 1. – С. 26–27. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protokol-kognitivno-bihevioralnoy-terapii-patsientov-perezhivayuschih-suicidalnyy-krizis> (дата обращения: 01.05.2022).

Холмогорова А. Б. Суицидальное поведение: теоретическая модель и практика помощи в когнитивно-бихевиоральной терапии / А. Б. Холмогорова // Консультативная психология и психотерапия. – 2016. – Т. 24, № 3.

Ярусси М. М. Интеграция мотивационного консультирования и когнитивно-поведенческой терапии в клинической практике / М. М. Ярусси ; пер. с англ. Т. П. Предчук. – Киев : Диалектика, 2022. – 400 с. – ISBN 978-5-907458-04-8.

Beck A. T. Cognitive approaches to panic disorder: Theory and therapy // Pan-ic. – Routledge, 2013. – P. 91–109.

Beck A. T. Thinking and depression: II. Theory and therapy / A. T. Beck // Archives of General Psychiatry. – 1964. – Т. 10, nr 6. – P. 561–571.

Beck A. T. Cognitive therapy: current status and future directions / A. T. Beck, D. J. A. Dozois // Annual Review of Medicine. – 2011. – Т. 62. – P. 397–409.

Easden M. H. Case conceptualization research in cognitive behavior therapy: A state of the science review / M. H. Easden, N. Kazantzis // Journal of Clinical Psychology. – 2018. – Т. 74, nr 3. – P. 356–384.

Ellis A. Reason and emotion in psychotherapy / A. Ellis. – New York : L. Stuart, 1962. – 440 p.

Open, aware, and active: Contextual approaches as an emerging trend in the behavioral and cognitive therapies / S. C. Hayes, M. Villatte, M. Levin, M. Hildebrandt // Annual Review of Clinical Psychology. – 2011. – Т. 7. – P. 141–168.

Rosen H. The constructivist-development paradigm. Chapter 14 / H. Rosen // Paradigms of Clinical Social Work / ed. by Rachele A. Dorfman. – New York : Routledge, 1988. – 460 p. – P. 317–355.

APA Dictionary of Psychology / ed. G. R. VandenBos. – Washington : American Psychological Association, 2007. – 1024 p. – ISBN 978-1-59147-380-0.

What four decades of meta-analysis have taught us about youth psychotherapy and the science of research synthesis / J. R. Weisz, K. E. Venturo-Conerly, O. M. Fitzpatrick, J. A. Frederick, Mei Yi Ng // Annual Review of Clinical Psychology. – 2023. – Т. 19. – P. 79–105.

ПРОТОКОЛЫ И ТЕХНИКИ КПТ

1.1. Протокол СМЭР

Протокол СМЭР (ситуация – мысли – эмоции – реакция) является одним из основных инструментов в КПТ, используемым для анализа и изменения негативных мыслей и эмоций у клиента.

Этот протокол помогает клиенту осознать взаимосвязь между ситуацией, его мыслями, эмоциями и реакцией на эту ситуацию, т. е. донести до него когнитивную модель.

Протокол является диагностическим, его проведение направлено на прояснение ситуации, уточнение проблемы, составление концептуализации, а не на когнитивную реструктуризацию. Протокол является формой сбора информации, чтобы отделить важное от вымысла.

В первый раз протокол заполняется совместно с клиентом, в процессе терапии клиенту делегируется задача его заполнения. Ведение дневника СМЭР, или дневника мыслей, – одно из типичных заданий в КПТ.

Критерии выбора ситуации для СМЭР:

1. Ультрасвежий пример (здесь и сейчас);
2. Свежий пример (в последние две недели);
3. Повторяющаяся ситуация;
4. Сверхяркая ситуация (запомнившаяся, травматичная, где сильнее всего проявилась проблема);
5. Первая ситуация.

Алгоритм заполнения протокола СМЭР

1. Ситуация:

- Есть ли пример ситуации, в которой проявляется та проблема, которую мы обсуждаем?
- Сможете ли вы подробно описать ситуацию в деталях?
- Что произошло? Когда это случилось? Где вы были? Что вы делали?

С кем вы были?

2. Эмоции:

- Что вы почувствовали? Опишите чувство, эмоцию, которые вы испытывали в этой ситуации.

- Оцените интенсивность этой эмоции в... балльной шкале?
- Какие еще эмоции испытали?

3. Реакция:

• Какие были ваши физиологические ощущения? Где в теле вы испытывали данную эмоцию?

- Как эта эмоция отразилась на вашем поведении?
- Что чувствовали, и в какой части тела было переживание?

4. Автоматические мысли (ключевые мысли):

• О чем вы подумали в этот момент? Какие мысли вызвали такую реакцию?

• Был ли какой-то зрительный образ, отражающий вашу оценку ситуации?

• Какое значение вы придали ситуации в тот момент? Как вы ее расценили?

Примечания к заполнению протокола СМЭР:

1. Можно проиграть ситуацию.
2. Попросить клиента закрыть глаза.
3. Перефразировать вопросительные мысли и мысли-междометия («черт», «блин») в утвердительные.
4. Чаще всего мысль – несколько слов, эмоция – одно слово.
5. Разные эмоции вызваны разными мыслями, надо выделить связки и согласовать с клиентом.
6. Если мысль выделена корректно, то клиент испытывает сходные эмоции.

Форма протокола СМЭР

Ситуация	Мысли	Эмоции	Реакции	
			Телесные	Поведенческие

1.2. Падающая стрела

Техника направлена на выяснение установок и убеждений клиента посредством определения значения рассматриваемых в терапии ситуаций.

До проведения техники важно:

1. Выяснить конкретную жизненную ситуацию, сделать «поперечный срез» ситуации (протокол СМЭР).
2. Выделить и уточнить ключевые автоматические мысли клиента, согласовать их значимость, не оспаривая.

Подводящие вопросы:

- предположим, это так, и что?
- к чему данная мысль может привести?
- если эта мысль верна, то что тогда?
- почему вы так думаете? На что вы опираетесь?

Вопросы, направленные на выявление промежуточных убеждений клиента (правила, определения, предположения):

- что это значит для вас?
- когда вы так думаете, то что это говорит о мире?
- когда вы так думаете, то что это говорит о вашей жизни?
- когда вы так думаете, то что это говорит о других?
- и что в этом плохого (ужасного)?
- и что по этому поводу стоит делать? Что, в связи с этим нельзя делать?

Вопросы на выявление глубинных убеждений клиента:

- что данная ситуация говорит о вас?
- когда вы думаете так..., что вы думаете о себе?
- как эта мысль характеризует вас?

Критерии того, что техника была проведена успешно:

- получены однозначные формулировки, часто встречающиеся у клиента, объясняющее клиенту его трудности;
- ухудшение настроения клиента меняется (чаще ухудшается – он грустнее).

1.3. Мотивационное интервью

Техника мотивационного интервью позволяет связать ценности клиента с его целями, таким образом укрепит мотивацию и будет способствовать выстраиванию необходимых изменений в поведении.

Основные принципы мотивационного интервью:

1. Центрирование на клиенте: мотивационное интервью фокусируется на клиенте и его собственных ценностях, мотивациях и целях. Целью

является активное слушание и понимание клиента, а не попытка научить его своим взглядам и ценностям.

2. Создание эмпатической атмосферы. Консультант создает эмпатическую атмосферу, где клиент чувствует, что его понимают и принимают без осуждения. Это помогает установить доверительные отношения и способствует открытому общению.

3. Использование когнитивного диссонанса. Мотивационное интервью работает с противоречиями между текущим поведением клиента и его желаемыми изменениями. Терапевт помогает клиенту осознать этот диссонанс и принять решение о необходимости изменений.

4. Поддержание самооффективности: техника помогает клиенту увидеть свои собственные ресурсы и силы, которые могут быть использованы для достижения желаемых изменений, способствует развитию уверенности в собственных силах и способностях.

5. Целью мотивационного интервью является развитие готовности к изменениям у клиента. Терапевт помогает клиенту исследовать преимущества изменений, недостатки текущего поведения и возможные способы достижения целей.

Пример заполнения бланка мотивационного интервью

Описание	Примеры
<i>Ценности</i>	
Выступают недостижимым идеалом. Важны как процесс. Выбираются самим человеком.	Здоровье
<i>Абстрактные цели</i>	
Отражают ценности, связаны с ними. Не связаны с конкретными формами поведения. Выступают связующим звеном между ценностями и конкретными целями	Регулярная физическая активность
<i>Конкретные цели</i>	
Конкретные действия, выполнение которых позволит добиться абстрактных целей	Ходить на тренировки два раза в неделю по вторникам и пятницам в 18:00

Бланк мотивационного интервью

Ценности
1. 2. 3.
Абстрактные цели
Ценность 1
1. 2. 3.
Ценность 2
1. 2. 3.
Ценность 3
1. 2. 3.
Конкретные цели
Абстрактная цель 1 (ценность 1)
1. 2. 3.
Абстрактная цель 2 (ценность 1)
1. 2. 3.
Абстрактная цель 3 (ценность 1)
1. 2. 3.

Абстрактная цель 1 (ценность 2)
1.
2.
3.
Абстрактная цель 2 (ценность 2)
1.
2.
3.
Абстрактная цель 3 (ценность 2)
1.
2.
3.
Абстрактная цель 1 (ценность 3)
1.
2.
3.
Абстрактная цель 2 (ценность 3)
1.
2.
3.
Абстрактная цель 3 (ценность 3)
1.
2.
3.

1.4. Список ценностей

1. Автономия: свобода и независимость в принятии решений и действий.
2. Адаптивность: готовность адаптироваться к изменяющимся условиям и ситуациям.
3. Безопасность: чувство защищенности и безопасности в окружающей среде.
4. Благополучие: достаток и материальная безопасность.
5. Вдохновение: возбуждение и внутренняя мотивация к творчеству и действию.
6. Вера: духовные убеждения и ценности.
7. Внимание к деталям: стремление к точности и вниманию к деталям в работе и жизни.
8. Внутренний мир: гармония и понимание своих внутренних переживаний и чувств.
9. Внутренняя свобода: чувство освобождения от внутренних ограничений и страхов.
10. Волонтерство: добровольное участие в общественных и благотворительных мероприятиях.
11. Гармоничные отношения: уважение и взаимопонимание в семье и отношениях.
12. Гармония: баланс между различными аспектами жизни и средой.
13. Гибкость: способность адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам и условиям.
14. Гуманность: уважение к человечности и доброте в отношениях.
15. Динамизм: стремление к активному и энергичному образу жизни.
16. Доброта: доброжелательность и желание помогать другим людям.
17. Достижение: стремление к достижению поставленных целей.
18. Доступность: открытость и доступность для общения и взаимодействия с другими.
19. Дружба: ценность близких и доверительных отношений с друзьями.
20. Духовность: осознание и поиск своего места в духовном мире.
21. Жизнелюбие: радость и ценность жизни во всех ее проявлениях.
22. Здоровье: поддержание физического и психического благополучия.
23. Инициативность: способность к действию и инициативе.
24. Инновации: создание новых идей и технологий для улучшения жизни.
25. Интеллект: стремление к познанию и развитию своих умственных способностей.
26. Интуиция: доверие к внутреннему чувству и внутренней мудрости.

27. Искренность: искреннее отношение и честность в общении.
28. Коммуникация: умение общаться и взаимодействовать с другими людьми.
29. Конфиденциальность: уважение к частной жизни и доверительности.
30. Красота: гармония, пропорциональность и эстетическое удовольствие.
31. Креативность: способность к творческому мышлению и деятельности.
32. Лидерство: способность вести и мотивировать других.
33. Личная ответственность: осознанность своих действий и их последствий.
34. Любовь: ценность глубоких и нежных чувств к другим людям.
35. Мудрость: глубокие знания и способность применять их в жизни.
36. Надежность: возможность быть надежным и верным в отношениях.
37. Непредвзятость: открытость к новым идеям и перспективам.
38. Образование: постоянное стремление к обучению и саморазвитию.
39. Оптимизм: положительное отношение к жизни и вера в лучшее.
40. Оригинальность: стремление к самобытному и уникальному образу жизни.
41. Ответственное потребление: осознанное и ответственное отношение к потреблению ресурсов.
42. Ответственность перед обществом: осознанность своей роли в обществе и влияния на него.
43. Отдых: ценность релаксации и времени для отдыха и восстановления сил.
44. Отзывчивость: готовность помочь и поддержать других в трудных ситуациях.
45. Открытость: готовность к новым идеям, опыту и познанию.
46. Поддержка: готовность поддержать и помочь другим в трудные моменты.
47. Подлинность: стремление к истинности и подлинности в отношениях и действиях.
48. Позитивное мышление: умение находить позитивные аспекты во всем.
49. Понимание: стремление к пониманию и принятию окружающего мира и других людей.
50. Порядок: упорядоченность и систематизация в повседневной жизни.
51. Преданность: лояльность и верность своим убеждениям и целям.

- 52. Прекрасное: ценность красоты и эстетических наслаждений в жизни.
- 53. Признание: уважение и признание своих достижений и труда другими.
- 54. Приключения: желание исследовать мир и новые возможности.
- 55. Природа: ценность окружающей среды и забота о сохранении природы.
- 56. Прогресс: стремление к постоянному улучшению и развитию.
- 57. Профессионализм: стремление к высоким стандартам и профессиональному росту.
- 58. Равенство: признание равных возможностей и прав всех людей.
- 59. Развитие: стремление к личностному и профессиональному росту.
- 60. Реалистичность: понимание реальности и объективности в оценках.
- 61. Рефлексия: способность к самоанализу и осмыслению своего опыта.
- 62. Романтика: ценность романтических отношений и моментов в жизни.
- 63. Самовыражение: возможность выражать свои мысли, чувства и идеи.
- 64. Самодостаточность: способность решать свои проблемы и принимать ответственность за свою жизнь.
- 65. Самоконтроль: умение контролировать свои эмоции и поведение.
- 66. Самореализация: достижение своего полного потенциала и самораскрытие.
- 67. Самосознание: понимание своих сильных и слабых сторон, а также своих ценностей.
- 68. Самоуважение: уважение к себе и своим достоинствам.
- 69. Свобода: возможность принимать собственные решения и делать выбор.
- 70. Семья: близкие отношения с членами семьи и поддержка взаимопонимания.
- 71. Скромность: умеренность и отсутствие зазнайства в поведении.
- 72. Совместимость: гармоничные и доверительные отношения с окружающими.
- 73. Созидание: стремление к созданию и развитию нового.
- 74. Сопереживание: чувство эмпатии и сочувствия к другим людям.
- 75. Сотрудничество: способность работать в команде и совместно достигать целей.
- 76. Сплоченность: чувство принадлежности и поддержки в коллективе или сообществе.
- 77. Спокойствие: уравновешенность и гармония внутреннего состояния.

78. Спонтанность: способность быть открытым к новым идеям и приключениям.

79. Справедливость: чувство справедливости и равенства перед законом.

80. Стабильность: надежность и устойчивость в жизненных обстоятельствах.

81. Стойкость: умение сохранять спокойствие и решительность в трудных ситуациях.

82. Стремление к успеху: достижение выдающихся результатов в выбранной области.

83. Тактичность: умение действовать тактично и уважительно в общении.

84. Творчество: выражение себя через творческие идеи и проекты.

85. Терпимость: уважение и принятие различий в мнениях и убеждениях.

86. Уважение: уважение к себе и другим людям.

87. Уверенность: чувство уверенности в себе и своих способностях.

88. Умиротворенность: способность к внутреннему спокойствию и гармонии.

89. Учеба: получение новых знаний и навыков.

90. Фокусировка: способность концентрировать внимание на задаче или цели.

91. Целеустремленность: нацеленность на достижение определенных целей и результатов.

92. Честность: честность во взаимоотношениях с другими людьми.

93. Чистота: забота о своем окружении и гигиене.

94. Экологическое сознание: забота об окружающей среде и устойчивом использовании ресурсов.

95. Экономическое благополучие: достаток и материальная уверенность в жизни.

96. Энергия: желание и способность к динамичной и активной деятельности.

97. Этика: соблюдение моральных принципов и правил поведения.

98. Эффективность: способность достигать желаемых результатов с минимальными усилиями.

99. Юмор: способность видеть смешное и приносить радость другим.

100. Ясность: четкость в мышлении и выражении своих идей.

1.5. Список тем структурированного интервью для оценочной сессии

1. Как вы себя сейчас чувствуете?
2. Сколько вам лет и где вы родились?
3. Есть ли у вас семья или партнер? Есть ли у вас дети, если да, то сколько и как вы о них заботитесь?
4. С кем вы живете и какие условия у вас дома?
5. Можете ли вы сами себя обеспечить? Есть ли у вас финансовые проблемы?
6. Какой ваш опыт работы?
7. Какое образование вы получили и когда закончили учебу?
8. Какое у вас физическое здоровье? Принимаете ли вы лекарства?
9. Какие психоактивные вещества вы употребляете? Были ли у вас проблемы с этим?
10. Участвуете ли вы в каких-то общественных мероприятиях? Чем вы увлекаетесь в свободное время?
11. Почему вы обратились за помощью и какие у вас проблемы сейчас:
 - в каких ситуациях возникают проблемы и как они влияют на вашу жизнь?
 - какие чувства у вас вызывают эти проблемы?
 - как вы реагируете на них?
 - как думаете, что может произойти в таких ситуациях?
 - что вы обычно делаете, когда сталкиваетесь с этими проблемами?
 - есть ли что-то еще, что помогает вам в подобных ситуациях?
 - какие навыки вы могли бы развить, чтобы справиться с данными проблемами?
12. Когда начали беспокоить текущие проблемы? Как вы воспринимали свое детство и отношения в семье:
 - были ли проблемы в вашей семье, когда вы были ребенком?
 - обращались ли вы к кому-то за помощью по поводу психологических проблем?
 - есть ли в вашей семье кто-то с похожими проблемами?

1.6. Список методик и клинических шкал

Список клинических шкал, используемых для мониторинга психо-эмоционального состояния пациентов:

1. Шкала безнадежности Бека, BHS.
2. Шкала безнадежности для детей, HSC.
3. Шкала депрессии Бека, BDI.
4. Шкала суицидальных мыслей Бека, SSI.
5. Шкала тревоги Бека, BAI.

Список методик, применяемых в диагностике клиентов в рамках направлений КПТ:

1. Диагностика иррациональных установок, SPB.
2. Когнитивная регуляция эмоций, CERQ.
3. Комплексный копинговый опросник.
4. Метакогнитивная включенность в деятельность, MAI.
5. Методика оценки осознанного присутствия, МООП.
6. Многомерный опросник психологической гибкости, MPFI.
7. Опросник безусловного самопринятия, USAQ.
8. Опросник внимательности и осознанности, MAAS.
9. Опросник временной перспективы Зимбардо, ZTP1.
10. Опросник дисфункциональных убеждений при ПРЛ.
11. Опросник когнитивной флексибельности, CFI.
12. Опросник когнитивных ошибок, CMQ.
13. Опросник контроля мыслей, TCQ.
14. Опросник личностных убеждений, PBQ.
15. Опросник метакогнитивных убеждений, MCQ-30.
16. Опросник мыслей и паттернов поведения, TBQ.
17. Опросник правдоподобности тревожных мыслей, BAFT.
18. Опросник принятия и действия, AAQ.
19. Опросник принятия и осознания питания, FAAQ.
20. Опросник психологической гибкости, CompACT.
21. Опросник режимов Янга, SMI.
22. Опросник структурного профиля, SPI.
23. Пятифакторный опросник осознанности, FFMQ.
24. Регуляция эмоций у родителей, PERI2.
25. Схемный опросник Янга, YSQ S3R.
26. Тест рационального поведения, RBI.
27. Тест слияния мыслей, TFI.

28. Шкала базисных убеждений, WAS.
29. Шкала дисфункциональности, ШДФ.
30. Шкала дисфункциональных отношений, DAS.
31. Шкала поведенческой активации при депрессии, BADS.
32. Шкала психологической разумности, ШПР/PMS.
33. Шкала руминации, RRS.
34. Шкала сочувствия к себе, SCS.
35. Шкала эмоциональных схем Лихи, LESS II.

1.7. Чек-лист вопросов для структурирования сессий

Вводная часть сессии:

1. Оценить настроение клиента:
 - как вы чувствовали себя на прошлой неделе?
 - какие вещи дают возможность чувствовать себя лучше? из-за каких вещей чувствуете себя хуже?
 - как бы оценили свое состояние сейчас?
2. Обсудить повестку дня:
 - в решении каких проблем вы хотели бы, чтобы я помог сегодня?
 - есть ли еще какие-то трудности?
 - хорошо, сейчас мы уточним изменения, которые произошли с прошлой встречи, затем проверим домашнее задание и составим повестку дня.
3. Изменения за прошлую неделю:
 - случилось ли что-то, о чем мне следовало бы знать?
 - хотели бы вы обсудить это сегодня?
 - случилось ли что-то хорошее?
4. Проверить домашнее задание:
 - теперь я предлагаю обсудить домашнее задание. Итак, первое задание...
5. Составить повестку дня:
 - давайте попробуем определить приоритеты для сегодняшней работы, чтобы понять, как лучше распределить время сессии;
 - итак, мы отметили, что ... должны ли мы еще что-то внести в повестку?

Основная часть сессии:

1. Проработать конкретную проблему и разобрать КПТ-навыки.
 - описать проблему через пятичастную модель, составить СМЭР или ЭМУУМЭ, или адаптивный ответ.

2. Дополнительно обсудить и совместно сформулировать важные домашние задания:

- к какому выводу вы пришли по поводу данной ситуации?
- какой ход мыслей был бы для вас более адаптивным, полезным, выгодным?..

- как можно этот вывод закрепить на практике?

3. Проработать вторую проблему.

Заключительная часть сессии:

1. Подвести итог или помочь клиенту это сделать:

- у нас остается 10 мин, давайте попробуем обобщить то, над чем мы сегодня работали (на первых сессиях это делает терапевт, потом – клиент).

- что было самым важным при обсуждении сегодня?

2. Уточнить домашнее задание:

- как мы можем закрепить то, что обсудили сегодня?

- какое домашнее задание закрепило бы те идеи, что мы обсудили?

3. Получить обратную связь:

- что вы думаете о сегодняшней сессии?

- что вам понравилось в сегодняшней сессии?

- что было для вас важным сегодня?

- может быть, что-то вас беспокоило? вам сегодня что-то мешало?

- насколько вы удовлетворены сегодняшней сессией?

- хотите ли вы, чтобы в следующий раз мы что-то сделали по-другому?

1.8. Бланк сессии

Вариант оформления бланка сессии в КПТ

Клиент _____ Встреча _____ Дата _____

Динамика

Результат ДЗ

Цели на встречу

На сессии

Итог

План действий

Психолог _____ / _____

Претензий к качеству выполнения работ не имею

Клиент _____ / _____

1.9. Адаптивный ответ

Протокол адаптивного ответа является средством формирования навыков саморегуляции эмоций, позволяет развить более эффективные стратегии поведения.

Протокол адаптивного ответа состоит из нескольких этапов, начиная с идентификации проблемной ситуации, которую клиент желает преодолеть. Терапевт и клиент анализируют типичную реакцию на данную ситуацию и определяют цели для разработки адаптивного ответа. На следующем этапе они совместно разрабатывают более адаптивные стратегии реагирования, включая изменение мыслей, разработку новых способов регуляции эмоций и поведенческих стратегий. Завершающие этапы включают тренировку и практику применения новых навыков в реальных ситуациях, а также оценку и коррекцию эффективности адаптивного ответа.

Бланк протокола адаптивного ответа

1. Ситуация: Кто? Что? Когда? Где?	
2. Эмоция: Что почувствовали? Оцените (0–100 %)	
3. Автоматическая мысль (АМ): О чем подумали в этот момент? Есть ли еще какие-то мысли и образы? (Выделить ключевую АМ)	
4. Доказательства «за»	
5. Доказательства «против»	
6. Альтернативная мысль: Есть ли альтернативные объяснения? Оцените уверенность в каждой из альтернатив (0–100 %)	
7. Эмоция: Оцените чувства во втором столбце, а также новые чувства (0–100 %)	

1.10. Техника замены императивного иррационального убеждения эффективным новым убеждением³⁴

На смену категоричного иррационального убеждения по типу «Я должен сдать этот экзамен во чтобы ни стало» стоит сформулировать эффективное убеждение, построенное по следующему алгоритму:

1. Первый шаг заключается в отказе от категоричного требования и переформулировании цели через желание. Вместо утверждения «Я должен / должна сделать что-то» клиент формулирует свою цель с помощью фразы «Я хочу» или «Я бы хотел(а)». Например, вместо «Я должен сдать экзамен» клиент говорит: «Я хочу успешно сдать экзамен». Это позволяет ему рассмотреть ситуацию без чувства обязательства и открыться для разных возможностей.

2. Важно исследовать ценность цели для клиента и понять, почему ему это важно, что поможет ему укрепить мотивацию и использовать его эмоциональные ресурсы для достижения цели. Например, если клиент хочет сдать экзамен, важно выяснить, почему это так важно для него и какой результат он ожидает получить.

3. Далее необходимо разработать план достижения цели. Это включает в себя проработку возможных вариантов действий и ресурсов, которые можно привлечь для достижения цели. Например, клиент может составить расписание занятий, использовать методы подготовки к экзамену и обратиться за помощью к преподавателю или наставнику.

4. Кроме того, важно обратить внимание на возможный негативный исход ситуации и разработать план действий на случай его возникновения. Это поможет снизить тревожность клиента и подготовить его к возможным трудностям. Например, клиент может предвидеть возможные препятствия на пути к сдаче экзамена и разработать стратегии их преодоления.

³⁴ См.: Рационально-эмотивно-поведенческая терапия / Р. Диджузеппе, К. Дойл, У. Драйден, У. Бакс. С. 292–294.

Бланк протокола выработки эффективного убеждения

Я хотел бы... (формулировка желания на смену категоричному требованию)	
Потому что... (описание ценности, ради которой стоит приложить усилия)	
Поэтому я буду... (конкретный план действий)	
Если у меня не получится, то это не означает... (страховочный вариант, для снижения тревожности и принятия ситуации)	

1.11. ЭМУУМЭ (разработчик Д. В. Ковпак)

Протокол ЭМУУМЭ является одним из наиболее известных инструментов КПТ. Он направлен на изменение негативных мыслей и убеждений у клиента, что в конечном итоге способствует улучшению его эмоционального состояния и поведенческих реакций.

Вопросы проведения протокола ЭМУУМЭ:

1. Дисфункциональные эмоции:

- опишите ситуацию (что? кто? когда? где?);
- какие эмоции в этот момент вы испытывали?
- насколько сильные (0–100 %)?

2. Дисфункциональные мысли:

- какая мысль вызывала эту эмоцию?
- помогает ли такая мысль? Насколько она логична? Работает ли она?

3. Дисфункциональные убеждения:

- какое правило / идея / убеждение лежит в основе этой мысли?

1.12. Сократовский диалог, или направленное открытие

Сократовский диалог основан на методах философа Сократа, который использовал вопросы для стимулирования самопонимания и размышления у собеседника. В рамках КПТ сократовский диалог используется терапевтом для помощи клиенту в осознании и анализе его мыслей, убеждений и эмоций. Терапевт задает клиенту открытые вопросы, направленные на исследование его мыслей и переживаний в отношении определенных ситуаций. Цель сократовского диалога – помочь клиенту рассмотреть ситуацию с разных точек зрения, идентифицировать негативные убеждения и привычные реакции, а также разработать более адаптивные стратегии реагирования.

Вопросы сократовского диалога

Что делаем	Что спрашиваем
Проверяем истинность	Что доказывает, что это правда? Что доказывает, что это неправда?
Ищем альтернативу	Есть ли другие причины? Есть ли другие объяснения?
Снижаем тревожность	Что самое плохое может произойти? Что самое хорошее может произойти? Как скорее всего произойдет?
Анализируем последствия	К чему приводит такой ход мыслей? Если бы мыслили иначе, то какие могли бы быть варианты?
Смотрим со стороны	Что бы вы подсказали другому человеку в такой же ситуации?
Решаем проблему	Какие могут быть варианты? Какой из них является худшим/лучшим/спорным/оптимальным? Почему? С чего лучше начать?

1.13. Техника сократовского вопрошания С. Уолтмана и Р. Кодда III

Предлагаемая техника состоит из четырех этапов рассмотрения ситуации клиента и опирается на модель сократовского диалога, или направляемого открытия.

Бланк техники сократовского вопрошания С. Уолтмана и Р. Кодда III

Этап 1. «Фокусирование». Ключевая задача: выделить центральную мысль для обсуждаемой проблемы клиента	
Что больше всего огорчает? Какая эмоция самая яркая, в связи этой проблемой? Как мысль тяготит больше всего? Какова основная мысль, которая вас расстраивает? На какие идеи, правила эта мысль опирается? Что означает для вас эта мысль?	Ключевая эмоция и мысль:
Этап 2. «Феноменологическое понимание». Ключевая задача: выяснить, почему клиент придерживается данного убеждения	
Почему вы это делаете? Почему вы в это верите? Где вы этому научились? Что вы должны делать в связи с этим?	Происхождение и подкрепление мысли:
Этап 3. «Совместное любопытство». Ключевая задача: определить альтернативу в отношении к проблеме	
Что мы упускаем? Чего мы не знаем? Как мое поведение влияет на ситуацию? Есть ли еще важные детали?	Альтернативы:

Этап 4. «Резюме и синтез». Ключевая задача: освоить опыт и наметить план его применения	
К какому итогу мы пришли? Как он согласуется с первоначальным убеждением? Какое новое умозаключение может быть более соответствующим действительности? Какое новое умозаключение может быть более полезным для меня? Как я смогу его применить в своей жизни? Что я сделаю в первую очередь?	План действий:

1.14. Протокол экспозиции

Экспозиция призвана проверить реальность худшего варианта развития событий. Для проведения экспозиции воспользуйтесь протоколом, представленным ниже.

В пункте мое худшее опасение – пропишите конкретный вариант риска в форме условного предположения.

Отметьте, насколько клиент в этом уверен до проведения попыток экспозиций.

В столбцах, обозначенных как признаки, приведите конкретные характеристики проявления опасения (например, я потеряю сознание, меня бросит в жар, меня прошибет холодный пот, у меня остановится сердце и т. д.).

После этого проведите первую попытку экспозиции, а в соответствующие ячейки впишите наблюдения клиента за собой, как себя проявляют выделенные признаки.

Бланк экспозиции

Мое худшее опасение

Если _____

то _____

Моя уверенность в худшем сценарии ДО

Моя уверенность в худшем сценарии ПОСЛЕ

	Признак 1	Признак 2	Признак 3	Признак 4	Признак 5
Попытка 1					
Попытка 2					
Попытка 3					
Попытка 4					
Попытка 5					

1.15. Техника самомониторинга

Техника самомониторинга представляет собой систематическое отслеживание и запись различных аспектов своего поведения, мыслей, эмоций или физических состояний в течение времени. Это важный инструмент, поскольку позволяет в целом осознавать и анализировать свои реакции на различные ситуации, выявлять паттерны поведения и мышления, а также отслеживать прогресс в достижении своих целей.

Важно, чтобы клиенты осознавали, что техника самомониторинга помогает им оценить, насколько их текущие стратегии и мышление соответствуют их желаемым целям и благополучию. Это обеспечивает возможность обсудить с терапевтом, нуждаются ли они во внесении изменений в свои мыслительные схемы или поведенческие стратегии для достижения лучших результатов и повышения качества их жизни.

Целесообразно до внесения изменений в качестве домашнего задания рассмотреть заполнение бланка ежедневных занятий, чтобы в дальнейшем оценить объективную сторону поведения клиента. Клиент заполняет бланк, отмечая детальное выполнение всех дел либо отдельных сторон в зависимости от запроса (например, отмечает время и обстоятельства курения).

После заполнения бланка, на последующих сессиях вместе с терапевтом происходит анализ полученных данных, делаются выводы и строятся планы по дальнейшей поведенческой модификации.

Бланк техники самомониторинга

	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	Воскресенье
6.00							
6.30							
7.00							
7.30							
8.00							
8.30							
9.00							
9.30							
10.00							
10.30							
11.00							
11.30							
12.00							
12.30							
13.00							
13.30							
14.00							
14.30							
15.00							
15.30							
16.00							
16.30							
17.00							
17.30							
18.00							
18.30							
19.00							
19.30							
20.00							
20.30							
21.00							
21.30							
22.00							

1.16. «За» и «против»

«За» и «против» – это техника, используемая для анализа проблемных ситуаций и принятия решений путем систематического разбора. Этот протокол помогает клиенту принять взвешенное решение и разработать более эффективные стратегии решения проблем.

Для начала использования протокола необходимо:

1. Идентифицировать проблемную ситуацию.
2. Выделить в ней как минимум два варианта решения.

Далее вместе с терапевтом последовательно, в порядке цифр в ячейках, заполняется следующая форма.

Бланк техники «За» и «против»

Форма поведения	Достоинства/выгоды	Недостатки/потери
Старая	1	2
Новая	4	3

После заполнения данной таблицы, каждый аргумент, представленный в ячейке, оценивается по трехбалльной шкале по степени важности, после чего баллы суммируются по диагонали (1 и 3 ячейки, 2 и 4 ячейки).

На что стоит обратить внимание:

- Как правило, клиент недооценивает достоинства старой формы поведения и недостатки новой.
- Сумма достоинств старой формы и недостатков новой отражает скорее эмоциональные аргументы, а сумма достоинств новой и недостатков старой – скорее рациональные аргументы.
- Чаще всего фактически до сессии клиент неосознанно делал выбор в пользу старой формы поведения, а на текущей сессии приходит к пониманию, что новая форма поведения для него разумнее/выгоднее/функциональнее. Важно поддержать его выбор, создать копинг-карточку поддержки, связать сделанный выбор с ценностями.

Протокол «за» и «против» помогает клиенту более осознанно и систематически подходить к анализу проблем и принятию решений, учитывая как положительные, так и отрицательные аспекты ситуации. Это способствует развитию более гибких и эффективных стратегий решения проблем и улучшению принятия решений.

1.17. Нервно-мышечная релаксация Джекобсона и самонаблюдение

Нервно-мышечная релаксация Джекобсона – одна из наиболее эффективных техник, направленных на повышение уровня саморегуляции, управления стрессом, тревожностью и физическими симптомами напряжения. Эта методика разработана американским физиологом Эдмундом Джекобсоном (1928–2012) и базируется на принципе, что физическое напряжение и эмоциональное напряжение взаимосвязаны.

Научившись осознавать и расслаблять определенные мышечные группы, человек может достичь более глубокого расслабления и снижения общего уровня тревоги. Процесс включает в себя последовательное напряжение и расслабление различных групп мышц, начиная с конечностей и заканчивая более крупными группами, такими как спина и живот. Регулярная практика нервно-мышечной релаксации Джекобсона может помочь снизить физиологические проявления стресса, такие как повышенное артериальное давление, повышенное сердцебиение и мышечное напряжение.

Необходимо поочередно напрягать каждую анатомическую область, сделав так, чтобы напряжение было максимальным и длилось под счет до 10, затем расслабляетесь, также считая до 10.

Этапы выполнения техники нервно-мышечной релаксации

№ п/п	Анатомическая область	Положение тела и инструкция
1	Кисти	Сожмите пальцы в кулак, большой палец сверху
2	Предплечья	Согните кисти в лучезапястном суставе
3	Плечи и надплечья	Разведите руки в стороны по одной линии, согните их в локтях, плечи чуть-чуть подняты
4	Лопатки	Сведите лопатки вместе и из этого положения опустите их вниз
5	Лицо	Нахмурьте брови, глаза закройте и сведите к центру, наморщите нос, сожмите челюсти и разведите углы рта в стороны

О к о н ч а н и е т а б л и ц ы

№ п/п	Анатомическая область	Положение тела и инструкция
6	Шея	Пытайтесь наклонить голову вперед, но мысленно представляйте противодействие. Ваша голова словно бы упирается в непреодолимое препятствие
7	Пресс	Втяните живот, сделайте его плоским
8	Ягодицы	Сядьте на жесткую поверхность одними ягодицами так, чтобы бедра их не касались, покачайтесь на напряженных ягодицах
9	Промежность	Одновременно с напряжением брюшного пресса и ягодиц втяните в себя промежность
10	Бедра	Из положения сидя вытяните ноги вперед под прямым углом
11	Голени	Подайте стопы на себя и чуть-чуть к центру
12	Стопы	Согните пальцы стоп

Противопоказания и важные детали по выполнению упражнений:

- не стоит выполнять задания, если у вас есть хронические заболевания;
- нельзя выполнять упражнение беременным;
- не нужно при первых выполнениях производить напряжение в полную силу;
- при наступлении неприятных ощущений (болей, судорог и пр.) прекратите выполнение упражнений;
- напряжение не должно быть связано с прекращением дыхания. Оно должно оставаться поверхностным, спокойным, в противном случае выполнение упражнения может привести к повышению давления.

1.18. «Лестница страха»

Цель: «Лестница страха» помогает клиенту систематизировать и осознать свои страхи, а также разработать стратегии их преодоления.

Важные моменты:

- будьте внимательны к эмоциональному состоянию клиента во время проведения техники;
- поддерживайте клиента, помогая ему определиться с уровнем и градацией страха;
- поощряйте открытость и честность клиента в описании своих чувств и реакций.

Инструкция

к проведению техники «Лестница страха»

1. Познакомьте клиента с техникой и объясните ее цель. Расскажите о том, что «Лестница страха» поможет упорядочить и идентифицировать разные уровни тревоги, вызываемые различными ситуациями или людьми.

2. Попросите клиента выбрать 5–10 ситуаций или людей, вызывающих у него страх или тревогу. Ситуации должны располагаться по возрастающей степени тревоги, начиная от наименьшего страха до наибольшего.

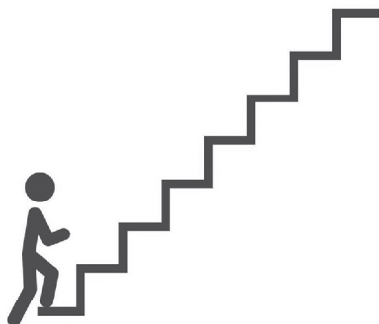
3. Предложите клиенту нарисовать лестницу на листе бумаги или воспользуйтесь рисунком ниже. На вершине лестницы расположите ситуацию или человека, вызывающего наибольший страх, а внизу – наименьший.

4. Попросите кратко описать каждую ситуацию или человека и связанные с ними эмоции и физические ощущения.

5. После завершения выполнения техники обсудите с клиентом его впечатления. Обратите внимание на возможные образцы поведения, мышления и физические реакции, связанные с разными уровнями тревоги.

6. На основе лестницы страха создайте с клиентом план поэтапного снижения уровня тревоги. Обсудите возможные стратегии для преодоления страхов и разработки адаптивных копинг-механизмов.

Бланк техники «Лестница страха»



1.19. Анализ мотивации изменений при тревоге

Данную технику рекомендуется выполнять для оценки мотивации изменений при наличии тревожности или тревожного расстройства.

Необходимо вместе с клиентом выписать его страхи и проанализировать каждый из них по пунктам, внесенным в таблицу.

Затраты – что вынужден делать или чего не может делать клиент из-за своей тревоги или страха.

Выгоды – что он получает благодаря тому, что у него есть этот страх или тревога. Есть ли конкретные преимущества или вторичная выгода?

Возможные преимущества – что получит клиент, если сможет преодолеть страх.

Техника помогает прояснить истинные мотивы поведения клиента, может обнаружиться, что преодоление конкретной фобии не является чем-то актуальным, а лишь выступает средством компенсации.

Бланк техники анализа мотивации изменений при тревоге

Конкретный страх		
Затраты	Выгоды	Возможные преимущества

1.20. Чек-лист «Симптомы депрессии»

Чек-лист используется на этапе прояснения симптомов клиента. Его можно рассмотреть вместе с клиентом, отметив имеющиеся маркеры, обсудить ситуации их проявления.

Бланк «Симптомы депрессии»

Эмоциональные	Когнитивные
Изменчивое настроение с резкой сменой веселья на тоску. Апатия, крайнее уныние. Подавленное, гнетущее состояние. Ощущение тревоги, беспокойства или даже беспричинного страха. Отчаяние. Утрата интереса и удовольствия от работы и окружающего мира. Ощущение вины	Невозможность сконцентрировать внимание на определенной работе или действии. Выполнение простых задач за более длительное время. «Зацикленность» на своей никчемности – человек постоянно думает о бессмысленности своей жизни, у него преобладают только негативные суждения о себе. Негативное мышление о мире и будущем. Постоянные мысли о смерти и/или самоубийстве
Физиологические	Поведенческие
Нарушение аппетита. Проблемы со сном (бессонница или излишек сна). Физические боли без явной причины. Усталость и потеря энергии. Плохое самочувствие. Моторная заторможенность	Нежелание контактировать с родными и друзьями. Реже – попытки привлечь к себе и своим проблемам внимание окружающих. Потеря интереса к жизни и развлечениям. Неряшливость и нежелание следить за собой. Постоянное недовольство собой и другими, которое выливается в чрезмерную требовательность и высокую критичность. Пассивность

1.21. Техника «Удовольствие и удовлетворенность»

Техника «Удовольствие и удовлетворенность» направлена на помощь клиенту в поиске источников радости, удовлетворения и смысла жизни. Эта техника помогает осознать, какие действия или активности приносят ему удовлетворение, и научиться использовать их для повышения качества жизни.

В процессе работы терапевт помогает идентифицировать и оценить различные источники удовольствия и удовлетворения в жизни клиента. Это могут быть такие области, как хобби, интересы, отношения с близкими, достижения в работе или учебе, физическая активность и т. д.

Клиент заполняет столбик таблицы «Активность», где указывает конкретные виды деятельности или занятия. После этого оценивает их по степени удовольствия и удовлетворенности.

В данном контексте удовольствие рассматривается как степень получения положительных эмоций в процессе выполнения какого-либо действия. Удовлетворенность же – как степень положительных эмоций по отношению к выполненному действию, его результату.

Бывает так, что дела, приносящие нам удовольствие в процессе занятия ими, в дальнейшем вызывают у нас ощущение неприязни или чувство вины, так, если человек находится на диете, то сладкое в процессе его потребления вызывает у него положительные эмоции, но потом он чувствует разочарование. Также в процессе их выполнения, нам может не нравиться то, что мы делаем, но результат приносит нам ощущение реализованности. Важно научить клиента различать эти оценки и выработать осознанное, ответственное отношение к своей жизни.

По итогам оценки можно перемножить показатели, увидев их производную для общего ощущения счастья.

Бланк техники «Удовольствие и удовлетворенность»

Активность	Удовольствие (процесс)	Удовлетворенность (результат)	Итоговая оценка

Пример заполнения

Активность	Удовольствие (процесс)	Удовлетворенность (результат)	Итоговая оценка
Кальян	5	2	10
Тренировка	3	5	15

1.22. План безопасности, или антикризисный план

План безопасности, или антикризисный план – это инструмент для помощи людям в управлении кризисными ситуациями или реагировании на рискованные или опасные события. Такой план разрабатывается для предотвращения возникновения кризисов, а также для обеспечения безопасности и защиты в случае их возникновения.

Бланк техники «План безопасности»

Шаг 1. Оценить предупреждающие знаки: как я узнаю, когда следует использовать план?

* Суицидальные мысли, ощущение никчемности и безнадежности. Желание сбежать, выпить, проявить агрессию...

Шаг 2. Что я могу сделать, ни к кому не обращаясь?

* Хобби, занятия для отвлечения

Шаг 3. Социальные ситуации и люди, способные меня отвлечь

* Встречи, прогулки, конкретные места

Шаг 4. Люди, у которых я могу просить помощи

* Мама, папа, подруга, соседка, сестра

Шаг 5. Специалисты или организации, к которым я могу обратиться во время кризиса

* Телефон кризисной помощи – ...Психиатр – ...Психолог – ...

Шаг 6. Создание безопасной среды

* Держать в доме только небольшое количество таблеток. Убрать из дома алкоголь, выбросить лезвия

Шаг 7. Отметить и обдумать причины жить, которые для меня актуальны

Антикризисный план, или план безопасности, помогает клиентам быть более подготовленными к управлению кризисными ситуациями и обеспечивает им чувство контроля и безопасности в трудных моментах.

1.23. Варианты решения проблем терапии

В случае возникновения проблем в терапии проанализируйте свою работу с клиентом по следующим пунктам. Представлены варианты действий, которые с высокой вероятностью позволят преодолеть трудности и сделать работу более продуктивной:

- перепроверьте составленную концептуализацию клиента, рассмотрите альтернативные объяснения, чтобы лучше понять состояние клиента;
- обсудите составленную концептуализацию с клиентом, убедитесь, что он с ней согласен;
- оцените необходимость обращения к профильному специалисту: психиатру, терапевту, диетологу и т. д. Такой осмотр позволит сделать более полную картину его здоровья;
- вынесите кейс клиента на супервизию, попросите помощи у коллег;

- изучите литературу по проблеме клиента для более глубокого понимания ее природы;
- получите обратную связь от клиента о его видении совместной работы;
- переформулируйте цели клиента и обсудите с ним их достижимость;
- определите свое мнение о клиенте и его случае, оцените их влияние на терапию;
- обсудите с клиентом когнитивную модель, уточните сомнения и трудные моменты;
- обсудите план лечения и выявите переживания и сомнения клиента;
- обсудите с клиентом ответственность в рамках совместной работы, оцените его реакцию на это;
- пересмотрите формулировки и систему проверки домашних заданий. Проверьте, насколько систематически они выполняются;
- уточните, насколько регулярно вы обсуждаете ключевые автоматические мысли, убеждения и стратегии поведения клиента;
- проверяйте уровень понимания клиентом материала сессии, предлагайте ему записывать ключевые идеи;
- попробуйте варьировать темп и структуру сессии, а также количество обсуждаемого материала в зависимости от потребностей и предпочтений клиента.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ, РЕШАЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ КПТ

Т а б л и ц а 1

**Неполный список расстройств, которые успешно лечатся
в рамках когнитивно-поведенческого подхода³⁵**

Психические расстройства	Психологические проблемы	Соматические заболевания с психологической состав- ляющей
Большое депрессивное расстройство. Гериатрическая депрессия. Генерализованное тревожное расстройство. Гериатрическая тревога. Паническое расстройство. Агорафобия. Социофобия. Обсессивно-компульсивное расстройство. Расстройство поведения (кондуктивное расстройство). Злоупотребление психоактивными веществами.	Проблемы в паре. Проблемы в семье. Патологическая игромания. Осложненное горе. Стресс ухаживающего лица. Гнев и враждебность	Хроническая боль в спине. Боль при серповидно-клеточной анемии. Мигрени. Звон в ушах. Онкологические боли. Соматоформные расстройства. Синдром раздраженного кишечника. Синдром хронической усталости. Боль при ревматических заболеваниях. Эректильная дисфункция. Бессонница. Ожирение. Бульводиния. Гипертония.

³⁵ См.: Бек Д. Когнитивно-поведенческая терапия. От основ к направлениям. С. 21.

Окончание табл. 1

Психические расстройства	Психологические проблемы	Соматические заболевания с психологической составляющей
Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Ипохондрия. Телесная дисморфия. Расстройства пищевого поведения. Расстройства личности. Лица, совершившие сексуальное преступление. Расстройства привычек. Биполярное расстройство (в дополнение к медикаментозной терапии). Шизофрения (в дополнение к медикаментозной терапии)		Синдром войны в Персидском заливе

Т а б л и ц а 2

**Исследования эффективности
когнитивно-поведенческой терапии³⁶**

Расстройство	Терапия	Тип эффективности в идеальных условиях		
		Абсолютная эффектив- ность	Эффектив- ность относительно медикамен- тозного лечения	Эффектив- ность относительно других психотерапий
Изолированная фобия	Экспозиция и когнитивная реструктури- зация	++	+	
Социальное тревожное расстройство	Экспозиция и когнитивная реструктури- зация	++	=	=
Паническое расстройство	Экспозиция и когнитивная реструктури- зация	++	=	+
Генерализо- ванное тревожное расстройство	Экспозиция и когнитивная реструктури- зация	+	=	+
Пост- травматическое стрессовое расстройство	Экспозиция и когнитивная реструктур- зация	++	+	=
Обсессивно- компульсивное расстройство	Экспозиция и когнитивная реструктури- зация	++	=	+

³⁶ См.: Добсон Д., Добсон К. Научно-обоснованная практика в когнитивно-поведенческой терапии. С. 378–380.

Продолжение табл. 2

Расстройство	Терапия	Тип эффективности в идеальных условиях		
		Абсолютная эффективность	Эффективность относительно медикаментозного лечения	Эффективность относительно других психотерапий
Патологическое накопительство	Экспозиция и когнитивная реструктуризация, тренинг избавления от хлама	+		
Большое депрессивное расстройство	Планирование активности, когнитивная реструктуризация, изменение схем	+	+	=
Биполярное расстройство	Регулирование аффекта и когнитивная реструктуризация	+		+
Расстройства, связанные со злоупотреблением ПАВ и зависимостями	Регулирование аффекта, контроль поведения и когнитивная реструктуризация	+	+	=
Расстройства пищевого поведения	Управление питанием и когнитивная реструктуризация	+	=	+

Продолжение табл. 2

Расстройство	Терапия	Тип эффективности в идеальных условиях		
		Абсолютная эффективность	Эффективность относительно медикаментозного лечения	Эффективность относительно других психотерапий
Расстройства сна	Контроль поведения и когнитивная реструктуризация	++	=	+
Синдром хронической усталости	Планирование активности и когнитивная реструктуризация	++	+	+
Гнев и агрессия	Когнитивная реструктуризация и управление эмоциями	+		=
Психоз ³⁷	Управление аффектом и когнитивная реструктуризация	+		+
Расстройства, проявляющиеся соматическими симптомами	Переносимость дистресса и когнитивная реструктуризация	+	=	

³⁷ «В работе с расстройствами когнитивно-поведенческая терапия обычно используется в качестве дополнения к медикаментозному лечению» (см.: Добсон Д., Добсон К. Научно-обоснованная практика в когнитивно-поведенческой терапии. С. 379).

Окончание табл. 2

Расстройство	Терапия	Тип эффективности в идеальных условиях		
		Абсолютная эффективность	Эффективность относительно медикаментозного лечения	Эффективность относительно других психотерапий
Синдром раздраженного кишечника	Переносимость дистресса и когнитивная реструктуризация	+	=	
Пограничное расстройство личности	Диалектическая поведенческая терапия	+		

Примечание:

• пустая ячейка означает отсутствие достаточного количества данных для формулирования вывода;

• знак «+» – позитивная доказательная база;

• знак «=» – относительная эквивалентность методов;

• знак «++» – терапия выбора (предпочтительный метод лечения).

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Абстрактные цели – общие цели клиента, отражающие его ценности и указывающие на выбранное направление их реализации.

Автоматическая мысль – категория мыслей, которые возникают, как правило, бессознательно и мгновенно, при этом содержат в себе оценку текущей ситуации и могут вызывать эмоции.

Агорафобия – страх перед открытыми или общественными местами, который может приводить к избеганию таких ситуаций из-за опасения потерять контроль или не иметь возможности уйти в случае возникновения панического приступа.

Аддиктивное поведение – поведение, характеризующееся непреодолимой потребностью в употреблении вещества или занятии деятельности, даже при наличии негативных последствий.

Аддикция – состояние, при котором человек становится физически или психологически зависимым от вещества или деятельности и испытывает сильное влечение к их употреблению или занятию.

Активное слушание – навык терапевта активно включаться в процесс общения с клиентом, проявляя внимание, эмпатию и понимание, а также умение отражать и подтверждать переживания и мысли клиента.

Анамнез – информация о жизненной истории клиента и истории его трудностей.

Ассертивность – способность выражать свои чувства, мнения и потребности четко и уверенно, не нарушая при этом права и интересы других людей.

Безоценочное принятие – способность терапевта принимать клиента безусловно и без оценок, демонстрируя понимание и уважение к его опыту и чувствам, даже если они могут казаться необычными или противоречивыми.

Бихевиоризм – психологическая теория, согласно которой поведение человека формируется под влиянием внешних стимулов и реакций на них.

Гипотеза доступности – согласно этой гипотезе содержание и процесс мышления познаваемы и могут быть оценены.

Гипотеза изменений – человек имеет возможность изменить свои эмоции и поведение посредством изменения отношения к ситуациям.

Гипотеза медиации – мысли выступают посредниками между ситуациями и эмоциональными и поведенческими реакциями.

Глубинное убеждение – основополагающее убеждение или представление о себе, других или мире в целом, которое часто лежит в основе автоматических мыслей и поведения человека.

Диспут – процесс анализа и оспаривания мыслей или убеждений, целью которого является изменение когнитивных паттернов и поведения.

Дисфункциональное убеждение – убеждение, которое препятствует достижению здоровых и адаптивных результатов для клиента, создавая препятствия и мешая ему эффективно справляться с жизненными вызовами.

Долженствование – в контексте когнитивно-поведенческой терапии – когнитивное искажение, при котором человек накладывает на себя или на других строгие требования или ожидания относительно того, как следует действовать или каким должно быть определенное положение.

Домашнее задание – задачи, которые пациент выполняет вне терапевтической сессии с целью углубления самопонимания, практики новых навыков или применения обсуждаемых стратегий. Часто его используют как синоним термина «план активации».

Значение автоматической мысли – тот смысл, который клиент придает появляющимся у него автоматическим мыслям.

Значимые события детства или важная информация о детстве – события, переживания и опыт, происходившие в детстве клиента и оказавшие значительное влияние на его личность, поведение и отношения в зрелой жизни, причем ключевое значение придается интерпретациям клиента, а не конкретным обстоятельствам.

Искренний интерес – способность терапевта проявлять глубокий интерес к переживаниям и опыту клиента, демонстрируя свою заинтересованность в его личной истории и чувствах.

Катастрофизация – когнитивное искажение, при котором человек сосредоточен и переоценивает возможные негативные последствия событий, часто представляя их в крайне негативном свете.

Когнитивная модель – теория, в основе которой лежит предположение о том, что мысли человека в наибольшей степени определяют его эмоции, физиологические ощущения и поведение.

Когниции – процессы мышления, понимания, восприятия, включающие в себя память, внимание, решение задач и язык.

Компенсаторная стратегия – компонент концептуализации клиента, отражающий убеждения и конкретные способы их реализации в поведении.

Конгруэнтность самовыражения – способность терапевта быть искренним и открытым в выражении своих собственных чувств, мыслей и реакций на клиента, сохраняя при этом аутентичность и цельность своего самопонимания.

Конкретные цели – специфические и измеримые цели клиента, отражающие его регулярные действия по достижению абстрактных целей и реализации ценностей.

Конструктивизм – теория, согласно которой учение – процесс активного построения знаний и понимания на основе собственного опыта и взаимодействия с окружающей средой.

Концептуализация / формулировка – процесс формирования понимания клиентской проблемы или ситуации, включая выявление значимых событий детства, глубинных убеждений, промежуточных убеждений и компенсаторных стратегий.

Логический диспут – стратегия КПТ, направленная на анализ и оспаривание негативных мыслей или убеждений на основе их логической некорректности или недостаточности.

Мониторинг – систематическое отслеживание прогресса или изменений в психологическом состоянии клиента с целью оценки эффективности терапии.

Мотивационное интервью – методика работы с клиентом, направленная на активизацию его мотивации к изменению, разрешению проблемы или достижению целей, используя стратегии и техники, основанные на эмпатии, автономии и коллаборации.

Мысленный фильтр – когнитивное искажение, при котором человек сосредоточен только на определенных аспектах ситуации или информации, игнорируя все остальное, что может быть релевантным или важным.

Навешивание ярлыков – когнитивное искажение, при котором человек придает другим людям или себе слишком узкие и однозначные определения, основанные на одном или нескольких аспектах их личности или поведения.

Нервно-мышечная релаксация – методика психофизиологической регуляции, которая включает в себя упражнения по снижению напряжения в мышцах и улучшению общего состояния пациента.

Обесценивание или игнорирование позитивного опыта – когнитивное искажение, при котором человек не придает должного значения положительным событиям, достижениям или качествам или считает их незначительными или недостаточными.

Обратная связь – обмен информацией между клиентом и консультантом относительно процесса терапии.

Ожидания / допущения как промежуточные убеждения – предположения о том, каким должен быть мир или другие люди, сформулированные, как правило, по формуле: «если..., то...».

Ответственный гедонизм – концепция, которая подчеркивает важность стремления к удовлетворению собственных потребностей и наслаждению жизнью, при этом учитывая последствия своих действий для себя и других.

Отношения или определения как промежуточные убеждения – особые взгляды, что представляет собой мир вокруг нас. Эти убеждения служат своеобразными фундаментальными суждениями, определяющими наше понимание окружающей действительности.

Охранительное поведение – стратегии и механизмы, которые человек использует для защиты себя от потенциальных угроз или неприятных ситуаций, часто проявляющиеся в выборе безопасных и привлекательных форм поведения и избегания определенных ситуаций или объектов.

Оценочная, или диагностическая, сессия – сессия, на которой терапевт собирает информацию о клиенте, его проблемах, истории и текущем состоянии для определения дальнейших направлений работы.

Оценочные критерии – стандарты или критерии, используемые для оценки успеха или эффективности терапевтической интервенции.

Паническое расстройство – тип тревожного расстройства, характеризующийся внезапными и повторяющимися приступами паники, сопровождающимися физиологическими симптомами, такими как учащенное сердцебиение и потливость.

Персонализация – в контексте КПТ, когнитивное искажение, при котором человек связывает случайные события или действия других людей с собой, чувствуя, что они направлены лично против него.

Перфекционизм – стремление к достижению идеальности или безупречности в своих действиях, мыслях или результате работы, которое может приводить к чрезмерной самокритике и тревожности.

План активации – план действий, разработанный в рамках терапии, направленный на активизацию пациента, улучшение его настроения и функционирования, а также достижение целей терапии. Часто его используют как синоним термина «домашнее задание».

План безопасности – документ, разработанный терапевтом и клиентом в случае, если у клиента имеются мысли о суициде, содержащий стратегии и методы для предотвращения потенциально опасных ситуаций.

Планирование – процесс определения целей, разработки стратегий и определения ресурсов для достижения желаемого результата.

Поведенческая активация – стратегия в КПТ, направленная на увеличение активности и участия пациента в приятных или значимых для него деятельности, чтобы бороться с депрессией или другими психологическими проблемами.

Поведенческая интервенция – методика в психотерапии, цель которой заключается в изменении поведения клиента через использование специально разработанных техник и стратегий.

Поведенческий эксперимент – метод в КПТ, который используется для проверки и изменения негативных убеждений или представлений клиента путем проведения контролируемого опыта или действия.

Повестка (аджента) – список вопросов, тем или задач, который пациент или терапевт хотят обсудить на сессии, чтобы обеспечить структуру и направление беседы.

Подкрепляющий цикл – циклический процесс, в котором определенные мысли приводят к поведению, которое, в свою очередь, создает ситуации, подкрепляющие и поддерживающие подобные мысли и поведение в будущем.

Правила как промежуточные убеждения – сформулированные или неосознанные нормы, которые руководят поведением или оценкой ситуаций и могут влиять на формирование автоматических мыслей.

Прагматизм – философское направление, согласно которому истинность утверждений оценивается их практической ценностью и полезностью для человека.

Прагматический диспут – стратегия КПТ, которая направлена на анализ и оспаривание негативных мыслей или убеждений на основе их практической реализуемости или полезности для клиента.

Преувеличение или преуменьшение – когнитивное искажение, при котором человек представляет события, свои возможности или качества в увеличенном или уменьшенном масштабе, не соответствующем реальности.

Проблема – состояние или ситуация, вызывающая дискомфорт, беспокойство или дисфункцию у клиента и требующая вмешательства терапевта.

Произвольная мысль – мысленный процесс, который осознанным образом и целенаправленно иницируется и контролируется человеком, часто используется для решения задач или планирования действий.

Промежуточные убеждения – убеждения, которые лежат между уровнем автоматических мыслей и глубинными убеждениями, включающие правила, определения и условные предположения.

Протокол – определенная технология или последовательность действий в процессе терапии, включающая цели, обсуждаемые вопросы, принимаемые решения и планы действий.

Протокол СМЭР (событие – мысль – эмоция – реакция) – инструмент КПТ, который помогает клиенту осознавать и анализировать взаимосвязь между событиями, вызывающими эмоциональные реакции, и его мыслями и поведением. Этот протокол используется для выявления автоматических мыслей, эмоций и реакций, которые могут быть связаны с конкретными ситуациями, помогая клиенту понять, как его мышление влияет на его эмоциональное состояние и поведение.

Протокол экспозиции – документ, в котором фиксируются подробности проведения экспозиционных сессий, включая описание стимулов, уровень тревожности, продолжительность сессии и реакции клиента. Позволяет отслеживать прогресс и эффективность терапевтического вмешательства.

Протокол ЭМУУМЭ – план действий, используемый в КПТ для обсуждения когнитивной модели и оказания помощи по когнитивной реструктуризации дисфункциональных эмоций, мыслей и убеждений.

Психогенная депрессия – тип депрессии, вызванный психологическими или эмоциональными проблемами, связанными с конкретным травматическим событием.

Пятичастная модель жизненного опыта – теория, предполагающая, что жизненный опыт можно описать через взаимодействие пяти сфер: когнитивной, эмоциональной, физиологической, поведенческой и средовой.

Расстройство личности – это патологическое состояние, характеризующееся стойкими и глубоко интегрированными паттернами мышления, восприятия и поведения, которые приводят к дисфункциональности и значительным проблемам в общении и функционировании.

Рационализм – философское учение, согласно которому знание возникает через разумное рассуждение и анализ, а не только через наблюдение и опыт.

Реакции – ответы организма на внешние или внутренние стимулы.

Реализм – понимание мира в соответствии с его реальными характеристиками и свойствами, без приукрашивания или искажений.

Рефлексия – процесс осмысления и анализа собственных мыслей, чувств, поведения и опыта с целью понимания себя.

Руминации – повторяющиеся мысли или размышления о негативных событиях или проблемах, которые могут усугублять депрессию или тревогу.

Самозффективность – уверенность человека в своей способности успешно справляться с трудностями, достигать целей и контролировать собственную жизнь.

Сверхобобщение – когнитивное искажение, при котором человек делает обобщения на основе ограниченного количества событий или опыта, не учитывая все возможные варианты или контекст.

Сократовский диалог, или направляемое открытие – методика работы с клиентом, основанная на активном задавании вопросов и исследовании его собственных убеждений и решений с целью стимулирования самопонимания и поиска альтернативных решений.

Стимул – событие, способное вызвать реакцию в организме.

Страх – реакция на реальную (конкретную) угрозу или опасность.

Структурирование – процесс организации и систематизации сессии терапии с целью повышения эффективности работы и достижения поставленных целей.

Суицидальное намерение – наличие намерения или желания совершить суицид.

Суицидальное поведение – любые действия, направленные на совершение суицида или угрожающие жизни человека.

Суицидальные мысли – мысли о смерти, собственной смерти или желание умереть.

Терапевтическая сессия – сеанс терапии, направленный на обсуждение и решение проблем клиента.

Терапевтические отношения – взаимодействие между терапевтом и клиентом, основанное на эмпатии, понимании, поддержке и сотрудничестве, направленное на достижение терапевтических целей.

Техники дыхательной релаксации – методы психофизиологической регуляции, направленные на снижение уровня стресса и тревожности путем контроля за дыханием и использования специальных дыхательных упражнений.

Техники саморегуляции – набор методов и стратегий, направленных на управление эмоциями, поведением и мыслями для достижения желаемого состояния психического равновесия и благополучия.

Тревога – эмоциональное состояние, характеризующееся ощущением беспокойства, напряжения или опасности.

Тревожное расстройство – патологическое состояние, характеризующееся чрезмерной тревожностью и беспокойством, которые могут значительно мешать функционированию человека в повседневной жизни.

Тревожность – постоянное или частое чувство тревоги или беспокойства, которое может мешать повседневной жизни.

Тренинг навыков – метод обучения пациента новым навыкам или умениям, которые могут помочь ему более эффективно справляться с повседневными проблемами и стрессовыми ситуациями.

Триада Роджерса – концептуальная модель терапевтических отношений, которая включает в себя искренний интерес, конгруэнтность самовыражения и безоценочное принятие.

Туннельное зрение – когнитивное искажение, при котором человек сосредоточен только на одном аспекте ситуации или проблемы, игнорируя другие, что может привести к искаженному восприятию или принятию решений.

Функциональное убеждение – убеждение, которое способствует достижению здоровых и адаптивных результатов для клиента, помогая ему эффективно справляться с жизненными вызовами и стремиться к своим целям.

Функциональный диспут – метод КПТ, который направлен на анализ и оспаривание негативных мыслей или убеждений путем выявления их дисфункциональности или ненужности для достижения целей клиента.

Ценности – основные убеждения, которые определяют, что для человека важно и ценно в жизни, и могут служить ориентиром для принятия решений и действий.

Черно-белое мышление – это когнитивное искажение, при котором человек видит мир только в крайне противоположных категориях, без учета промежуточных оттенков или возможности совместного существования противоположностей.

Чтение мыслей – когнитивное искажение, при котором человек предполагает, что знает, что думают или чувствуют другие люди, даже если на самом деле это не так, и нет достаточных доказательств для таких утверждений.

Экзогенная депрессия – депрессивное состояние, вызванное внутренними биологическими факторами.

Экспозиция – метод, включающий постепенное и систематическое воздействие на ситуации или объекты, вызывающие у клиента тревожность или страх, с целью снижения их воздействия и преодоления симптомов.

Эмоциональное обоснование – когнитивное искажение, при котором человек оправдывает свои мысли, убеждения или действия на основе своих эмоциональных состояний, а не рациональных доводов или фактов.

Эмпиризм – философское направление, согласно которому знание основано на опыте и наблюдении.

SMART-цели – цели, сформулированные с учетом следующих критериев: конкретные, измеримые, достижимые, релевантные и ограниченные по времени.

Учебное издание

Муслумов Рустам Рафикович

КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Учебно-методическое пособие

Заведующий редакцией *М. А. Овечкина*

Редактор *В. И. Попова*

Корректор *В. И. Попова*

Компьютерная верстка *Г. Б. Головиной*

Подписано в печать 09.07.2025. Формат 60×84/16.
Бумага офсетная. Цифровая печать.
Уч.-изд. л. 9,0. Усл. печ. л. 9,07. Тираж 30 экз. Заказ 47.

Издательство Уральского университета.
Редакционно-издательский отдел ИПЦ УрФУ ЦСД
620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.
Тел.: +7 (343) 389-94-79, 350-43-28
E-mail: rio@urfu.ru

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре УрФУ ЦСД
620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.
Тел.: +7 (343) 358-93-06, 350-58-20, 350-90-13
<http://print.urfu.ru>

